Optimal Untuk Negeri

optimal

Buku Ajar

KETERAMPILAN KLINIS KEBIDANAN

PEMERIKSAAN, TINDAKAN DASAR, DAN KIE

Dyah Ayu Septika Wijaya • Septika Yani Veronica • Hanik Khairun Nisa
Siska Rosdiana • Titi Purwitasari Handayani

Editor: Prof. Dr. Runjati, Bdn., M.Mid.



BUKU AJAR
KETERAMPILAN KLINIS KEBIDANAN: PEMERIKSAAN, TINDAKAN DASAR, DAN KIE

Penulis:
Dyah Ayu Septika Wijaya, S.Tr, Keb., M.Keb.
Septika Yani Veronica, S.ST.Bdn., M.Tr.Keb.
Hanik Khairun Nisa, S.Tr.Keb.,Bdn., M.Keb.
Siska Rosdiana, S.ST., M.Keb.
Titi Purwitasari Handayani, SST., Bdn., M.Keb.

Editor:
Prof. Dr. Runjati, Bdn., M.Mid.

Optimal
Untuk
Negeri

BUKU AJAR KETERAMPILAN KLINIS KEBIDANAN: PEMERIKSAAN, TINDAKAN DASAR, DAN KIE

Penulis:
Dyah Ayu Septika Wijaya, S.Tr, Keb., M.Keb.
Septika Yani Veronica, S.ST.Bdn., M.Tr.Keb.
Hanik Khairun Nisa, S.Tr.Keb.,Bdn., M.Keb.
Siska Rosdiana, S.ST., M.Keb.
Titi Purwitasari Handayani, SST., Bdn., M.Keb.

Editor: Prof. Dr. Runjati, Bdn., M.Mid.

Desain Sampul: Ivan Zumarano
Penata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-634-7927-97-2

Cetakan Pertama : September, 2026
Hak Cipta 2026
Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang Undang
Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
Copyright © 2026
Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.
Website : optimaluntuknegeri.com
Instagram : @bimbel.optimal
Tiktok : @maskokooo

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI
Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88
RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat
Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ajar Keterampilan Klinis Kebidanan: Pemeriksaan, Tindakan Dasar, dan KIE dapat diselesaikan. Buku ini disusun sebagai salah satu sumber pembelajaran untuk membantu mahasiswa kebidanan memahami dan mengembangkan keterampilan klinis yang diperlukan dalam memberikan asuhan kebidanan secara aman, sistematis, dan berorientasi pada kebutuhan perempuan.

Keterampilan klinis merupakan bagian penting dalam pendidikan kebidanan karena kemampuan seorang bidan tidak hanya ditentukan oleh penguasaan pengetahuan, tetapi juga oleh kemampuan melakukan pemeriksaan, melaksanakan tindakan dasar, berkomunikasi secara efektif, serta memberikan informasi dan edukasi yang tepat kepada klien dan keluarga. Oleh karena itu, pembelajaran keterampilan klinis perlu mengintegrasikan aspek pengetahuan, keterampilan, komunikasi, etika, keselamatan pasien, dan profesionalisme.

Buku ajar ini membahas berbagai keterampilan yang berkaitan dengan pemeriksaan dan tindakan dasar dalam pelayanan kebidanan serta komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE). Materi disusun secara bertahap agar mahasiswa dapat memahami tujuan dan prinsip setiap tindakan, melakukan pengkajian dan pemeriksaan dengan benar, serta menghubungkan hasil pemeriksaan dengan kebutuhan asuhan kebidanan. Pembahasan juga menekankan pentingnya komunikasi terapeutik, pemberian informasi yang mudah dipahami, penghormatan terhadap hak dan pilihan klien, serta penerapan prinsip keselamatan dalam setiap pelayanan.

Dalam praktik kebidanan, keterampilan klinis tidak dapat dipisahkan dari kemampuan mengambil keputusan dan bekerja sesuai kewenangan profesi. Setiap tindakan perlu dilakukan berdasarkan kondisi klien, standar pelayanan, prinsip etika, serta pertimbangan keselamatan. Dengan demikian, buku ini diharapkan tidak hanya menjadi sumber untuk memahami prosedur, tetapi juga membantu mahasiswa membangun pola pikir klinis dan sikap profesional sejak proses pendidikan.

Penyusunan buku ini tentu masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan isi buku pada masa mendatang. Semoga buku ajar ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa kebidanan, pendidik, praktisi, dan pembaca lain yang memiliki perhatian terhadap pengembangan keterampilan klinis kebidanan.

Akhir kata, semoga buku ajar Keterampilan Klinis Kebidanan: Pemeriksaan, Tindakan Dasar, dan KIE dapat menjadi salah satu sumber pembelajaran yang bermanfaat dalam membentuk tenaga bidan yang kompeten, terampil, komunikatif, profesional, dan senantiasa mengutamakan keselamatan serta martabat klien.

Penulis

Juli, 2026

DAFTAR ISI

PRAKATA ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **v**

BAB 1 TINDAKAN DASAR PERSALINAN AMAN: PIMPINAN PERSALINAN, PERLINDUNGAN PERINEUM, DAN AMTSL **1**
A. Konsep Persalinan Aman dan Pimpinan Persalinan Kala II 3
B. Perlindungan Perineum dalam Persalinan 4
C. Pengelolaan Kala III dan Prinsip AMTSL 6
D. Pemantauan Ibu Setelah Plasenta Lahir dan Pencegahan Perdarahan Postpartum 7
E. Keselamatan Pasien, Komunikasi, dan KIE dalam Tindakan Persalinan 9
F. Integrasi Keterampilan Klinis dalam Persalinan Aman 10
G. Latihan Soal 11
H. Ringkasan 14
I. Daftar Pustaka 15

BAB 2 KETERAMPILAN ASUHAN BAYI BARU LAHIR: PENGERINGAN, IMD, TERMOREGULASI, DAN PERAWATAN TALI PUSAT **17**
A. Asuhan Bayi Baru Lahir 18
B. Evaluasi 19
C. Dokumentasi 19
D. Latihan Soal 22
E. Ringkasan 38
F. Daftar Pustaka 44

BAB 3 RESUSITASI DASAR BAYI BARU LAHIR: PERSIAPAN, VENTILASI, DAN EVALUASI **47**
A. Konsep Dasar dan Persiapan Resusitasi Bayi Baru Lahir 50
B. Penilaian Awal dan Langkah Awal Resusitasi 51
C. Ventilasi Tekanan Positif pada Bayi Baru Lahir 53
D. Evaluasi Respons dan Koreksi Ventilasi 55
E. Perawatan Pascareusitasi, KIE, dan Dokumentasi 57
F. Latihan Soal 60

G. Ringkasan 63
H. Daftar Pustaka 65

BAB 4 KETERAMPILAN ASUHAN NIFAS DAN MENYUSUI: PEMERIKSAAN IBU, TEKNIK MENYUSUI, DAN MANAJEMEN MASALAH UMUM 67
A. Definisi dan Konsep Dasar Masa Nifas 69
B. Perubahan Fisiologis Masa Nifas 71
C. Perubahan Hormon Masa Nifas 74
D. Kebutuhan Dasar Masa Nifas 77
E. Pemeriksaan Fisik dan Tanda Bahaya 78
F. Jadwal Kunjungan Masa Nifas (KF) 80
G. Asuhan Kebidanan Masa Nifas 81
H. Komunikasi, Informasi, dan Komunkasi (KIE) 97
I. Dokumentasi Asuhan Kebidanan pada Ibu Nifas 97
J. Pemerikasaan Fisik pada Ibu Nifas 98
K. Instrumen Evaluasi Laktasi dengan LATCH Score 99
L. Instrumen Evaluasi dengan Early Warning Score (EWS) 100
M. Lampiran Instrumen Evaluasi dan OSCE/Lab Skill 101
N. Latihan Soal 116
O. Daftar Pustaka 119

BAB 5 KETERAMPILAN PELAYANAN KB: KONSELING, SKRINING KELAYAKAN, DAN TINDAK LANJUT EFEK SAMPING 127
A. Konsep Pelayanan KB dan Konseling Berpusat pada Klien 130
B. Pengkajian dan Skrining Kelayakan Metode Kontrasepsi 130
C. Pemilihan Metode dan Pengambilan Keputusan Bersama 131
D. Efek Samping Kontrasepsi dan Penatalaksanaan Awal 132
E. Tindak Lanjut, KIE, Dokumentasi, dan Rujukan 133
F. Latihan Soal 134
G. Ringkasan 138
H. Daftar Pustaka 139

PROFIL PENULIS 141

BAB 1

TINDAKAN DASAR PERSALINAN AMAN: PIMPINAN PERSALINAN, PERLINDUNGAN PERINEUM, DAN AMTSL

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- CPL 1. Menguasai konsep teoritis ilmu kebidanan, fisiologi persalinan, serta prinsip asuhan persalinan normal sebagai dasar pelaksanaan keterampilan klinis kebidanan.
- CPL 2. Mampu melakukan pengkajian dan pemantauan kondisi perempuan selama proses persalinan secara sistematis sesuai standar pelayanan kebidanan.
- CPL 3. Mampu menerapkan keterampilan klinis dasar dalam membantu persalinan normal dengan memperhatikan keselamatan perempuan dan bayi.
- CPL 4. Mampu menerapkan prinsip pencegahan komplikasi persalinan, termasuk pencegahan trauma perineum dan perdarahan postpartum.
- CPL 5. Mampu menggunakan komunikasi terapeutik dan memberikan informasi yang tepat kepada perempuan serta keluarga selama proses persalinan dengan menghormati hak, martabat, dan pilihan perempuan.
- CPL 6. Mampu mengambil keputusan klinis sesuai kondisi perempuan, prinsip evidence-based practice, standar profesi, etika, keselamatan pasien, dan kewenangan bidan.
- CPL 7. Mampu menunjukkan sikap profesional, bertanggung jawab, teliti, responsif terhadap perubahan kondisi klinis, serta mampu mengenali kondisi yang membutuhkan kolaborasi atau rujukan.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

- Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:
- CPMK 1. Menjelaskan konsep dan prinsip dasar persalinan aman serta peran penolong dalam mempertahankan proses persalinan yang fisiologis.
- CPMK 2. Menjelaskan perubahan fisiologis pada kala II dan kala III persalinan sebagai dasar pelaksanaan tindakan klinis.
- CPMK 3. Menjelaskan prinsip pimpinan persalinan pada kala II dengan mempertimbangkan kondisi ibu, janin, dan kemajuan persalinan.

- CPMK 4. Menerapkan prinsip komunikasi dan dukungan kepada perempuan selama kala II untuk membantu proses persalinan yang aman dan positif.
- CPMK 5. Menjelaskan prinsip perlindungan perineum dan faktor-faktor yang berhubungan dengan trauma perineum selama persalinan.
- CPMK 6. Menerapkan prinsip pemilihan dan penggunaan teknik perlindungan perineum sesuai kondisi perempuan, pilihan perempuan, dan ketersediaan pelayanan.
- CPMK 7. Menjelaskan konsep kala III persalinan dan risiko perdarahan postpartum yang berkaitan dengan periode tersebut.
- CPMK 8. Menjelaskan konsep, tujuan, dan komponen utama AMTSL dalam pencegahan perdarahan postpartum.
- CPMK 9. Menjelaskan penggunaan uterotonika untuk pencegahan perdarahan postpartum serta prinsip pemantauan respons uterus setelah pemberian uterotonika.
- CPMK 10. Menjelaskan prinsip controlled cord traction sebagai salah satu komponen pengelolaan kala III yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terampil sesuai kondisi dan standar pelayanan.
- CPMK 11. Membedakan tindakan rutin dalam pencegahan perdarahan postpartum dengan tindakan yang dilakukan berdasarkan indikasi klinis.
- CPMK 12. Menganalisis kondisi ibu dan bayi selama kala II dan kala III untuk menentukan kebutuhan pemantauan, tindakan, kolaborasi, atau rujukan.
- CPMK 13. Menerapkan prinsip keselamatan pasien, pencegahan infeksi, komunikasi efektif, dokumentasi, dan profesionalisme dalam pelaksanaan tindakan dasar persalinan.

Uraian Materi

A. Konsep Persalinan Aman dan Pimpinan Persalinan Kala II

Persalinan merupakan proses fisiologis yang membutuhkan pemantauan dan asuhan secara sistematis untuk menjaga keselamatan ibu dan bayi. Meskipun sebagian besar persalinan dapat berlangsung secara normal, perubahan kondisi dapat terjadi dengan cepat sehingga penolong perlu mampu mempertahankan proses fisiologis sekaligus mengenali tanda-tanda penyimpangan. Persalinan aman tidak hanya ditandai dengan lahirnya bayi, tetapi juga mencakup upaya menjaga kondisi ibu dan bayi, mencegah tindakan yang tidak diperlukan, memberikan dukungan selama persalinan, serta melakukan tindakan yang tepat apabila terjadi komplikasi.

Asuhan persalinan yang aman perlu menempatkan perempuan sebagai pusat pelayanan. Perempuan memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai kondisi dan asuhan yang diberikan, mendapatkan dukungan selama proses persalinan, serta diperlakukan dengan hormat dan bermartabat. Oleh karena itu, keterampilan klinis tidak dapat dipisahkan dari komunikasi yang efektif. Penolong perlu menjelaskan tindakan dengan bahasa yang mudah dipahami, memberikan kesempatan kepada perempuan untuk menyampaikan kebutuhan dan kekhawatirannya, serta membangun suasana yang tenang dan mendukung.

Persalinan normal berlangsung melalui beberapa tahap atau kala. Kala II dimulai setelah pembukaan serviks lengkap dan berakhir dengan lahirnya bayi. Pada tahap ini, kontraksi uterus menjadi semakin kuat dan penurunan janin semakin lanjut. Tekanan bagian terendah janin pada dasar panggul dapat menimbulkan dorongan meneran. Kondisi tersebut membutuhkan pendampingan penolong agar perempuan dapat mengikuti proses persalinan secara efektif dan tetap merasa aman.

Pimpinan persalinan kala II bukan berarti penolong mengambil alih seluruh proses meneran, melainkan memberikan dukungan dan bantuan sesuai kebutuhan. Penolong perlu memperhatikan kondisi ibu, kontraksi uterus, kemajuan penurunan janin, serta kondisi janin. Selama kondisi ibu dan janin baik dan persalinan menunjukkan kemajuan, proses fisiologis perlu diberikan kesempatan untuk berlangsung. Intervensi dilakukan berdasarkan kebutuhan dan indikasi, bukan hanya karena tindakan tersebut biasa dilakukan.

Posisi perempuan selama kala II juga perlu diperhatikan. Selama tidak terdapat kontraindikasi, perempuan dapat didukung untuk memilih posisi yang nyaman dan sesuai dengan kondisi klinis. Penolong dapat memberikan bantuan dalam perubahan posisi, memberikan dukungan verbal, serta membantu perempuan

mengatur respons terhadap kontraksi dan dorongan meneran. Komunikasi yang tenang dan jelas sangat penting karena perempuan pada tahap ini dapat mengalami nyeri, kelelahan, kecemasan, atau kesulitan berkonsentrasi.

Ketika kepala bayi mulai turun dan tampak pada introitus vagina, penolong perlu meningkatkan perhatian terhadap proses kelahiran. Kelahiran kepala perlu berlangsung secara terkendali dengan tetap mengikuti mekanisme fisiologis. Penolong memberikan arahan yang sesuai kepada perempuan dan menghindari tindakan yang tidak diperlukan. Setelah kepala lahir, penolong memperhatikan proses rotasi dan kelahiran bahu serta tubuh bayi dengan tetap mengutamakan keselamatan ibu dan bayi.

Pemantauan selama kala II dilakukan secara berkesinambungan. Kondisi umum ibu, tanda vital sesuai kebutuhan, kontraksi uterus, kemajuan persalinan, serta kondisi janin merupakan bagian penting yang perlu diperhatikan. Penolong harus mampu mengintegrasikan hasil pemantauan tersebut dalam pengambilan keputusan. Apabila ditemukan perubahan yang menunjukkan penyimpangan dari proses fisiologis, kondisi tersebut perlu segera dinilai dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan.

Kemampuan mengenali kondisi yang membutuhkan kolaborasi atau rujukan merupakan bagian dari persalinan aman. Gangguan kondisi ibu atau janin, tidak adanya kemajuan persalinan, perdarahan, atau tanda kegawatdaruratan lainnya membutuhkan respons yang cepat dan terkoordinasi. Bidan perlu melakukan tindakan sesuai kewenangan, menjaga keselamatan ibu dan bayi, serta mengupayakan kolaborasi atau rujukan apabila kondisi berada di luar kemampuan pelayanan.

B. Perlindungan Perineum dalam Persalinan

Perlindungan perineum merupakan bagian penting dalam keterampilan klinis pada saat kelahiran bayi. Perineum mengalami peregangan yang cukup besar ketika kepala dan bahu bayi melewati jalan lahir sehingga diperlukan pemahaman mengenai anatomi, fungsi, dan respons jaringan perineum selama proses tersebut. Pemahaman ini menjadi dasar bagi bidan untuk memberikan dukungan yang tepat selama kelahiran sekaligus mengenali kondisi yang dapat meningkatkan risiko terjadinya trauma perineum.

Trauma perineum dapat terjadi dalam berbagai tingkat, mulai dari cedera ringan hingga kerusakan jaringan yang lebih luas. Risiko tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain karakteristik jaringan perineum, kondisi persalinan, ukuran dan posisi janin, kecepatan lahirnya kepala, serta tindakan yang dilakukan selama proses persalinan. Oleh karena itu, perlindungan perineum tidak diarahkan

untuk menjamin bahwa perineum selalu tetap utuh, tetapi untuk membantu mengurangi kemungkinan terjadinya trauma yang berat dan mempertahankan proses kelahiran yang aman.

Prinsip perlindungan perineum perlu diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi perempuan dan kemajuan persalinan. Pengaturan proses lahirnya kepala secara terkendali dapat membantu memberikan kesempatan bagi jaringan perineum untuk beradaptasi terhadap peregangan. Posisi perempuan juga dapat dipertimbangkan sesuai dengan kenyamanan, kondisi klinis, dan pilihan perempuan selama tidak terdapat kontraindikasi. Pendekatan tersebut perlu disertai pemantauan terhadap kondisi ibu dan bayi agar tindakan yang diberikan tetap sesuai dengan kebutuhan.

Dalam praktik klinis, teknik hands-on dan hands-off merupakan dua pendekatan yang dapat digunakan dalam mendukung kelahiran kepala. Pemilihan pendekatan perlu mempertimbangkan situasi klinis, keterampilan penolong, serta kebutuhan dan kenyamanan perempuan. Komunikasi selama proses tersebut juga memiliki peran penting. Bidan perlu memberikan arahan dengan tenang dan jelas, membantu perempuan mengikuti proses kelahiran, serta menghindari instruksi atau tindakan yang tidak diperlukan.

Upaya lain yang dapat dipertimbangkan untuk membantu mengurangi trauma perineum adalah penggunaan kompres hangat pada perineum selama kala II dan pijat perineum pada konteks yang sesuai. Penerapannya perlu disesuaikan dengan kondisi perempuan, tahap persalinan, ketersediaan fasilitas, serta kompetensi penolong. Penggunaan metode tersebut bukan merupakan jaminan bahwa robekan perineum tidak akan terjadi, tetapi merupakan bagian dari pendekatan untuk mengurangi risiko trauma yang lebih berat.

Episiotomi perlu dipahami sebagai tindakan yang memiliki indikasi klinis tertentu dan bukan tindakan rutin pada setiap persalinan. Keputusan untuk melakukan episiotomi harus mempertimbangkan kondisi ibu dan bayi serta manfaat dan risiko tindakan. Dengan demikian, mahasiswa perlu mampu membedakan antara perlindungan perineum sebagai upaya mempertahankan proses kelahiran yang fisiologis dengan episiotomi sebagai tindakan yang dilakukan ketika terdapat kebutuhan klinis.

Setelah bayi lahir, kondisi perineum perlu dinilai untuk mengetahui adanya trauma dan menentukan kebutuhan penatalaksanaan selanjutnya. Penilaian dilakukan secara sistematis dengan memperhatikan lokasi dan tingkat cedera serta kondisi perempuan. Apabila ditemukan trauma yang memerlukan penanganan lebih lanjut, bidan perlu memberikan tindakan sesuai kewenangan dan melakukan kolaborasi atau rujukan apabila kondisi berada di luar kompetensinya.

Perlindungan perineum pada akhirnya merupakan bagian dari keterampilan klinis yang menggabungkan pengetahuan anatomi, pemahaman fisiologi persalinan, keterampilan teknis, komunikasi, dan pengambilan keputusan klinis. Mahasiswa diharapkan tidak hanya mampu memahami teknik yang digunakan, tetapi juga mampu menjelaskan alasan pemilihannya, mengenali keterbatasannya, serta menyesuaikan tindakan dengan kondisi perempuan. Pendekatan tersebut membantu mewujudkan asuhan persalinan yang aman, berpusat pada perempuan, dan meminimalkan intervensi yang tidak diperlukan.

C. Pengelolaan Kala III dan Prinsip AMTSL

Kala III merupakan periode persalinan yang dimulai setelah bayi lahir hingga plasenta dan selaput ketuban lahir. Meskipun berlangsung relatif singkat dibandingkan kala persalinan lainnya, periode ini memiliki risiko klinis yang penting karena perdarahan dapat terjadi dalam waktu yang cepat. Oleh karena itu, pengelolaan kala III tidak hanya berfokus pada proses kelahiran plasenta, tetapi juga mencakup pemantauan kondisi perempuan dan upaya pencegahan perdarahan postpartum.

Setelah bayi lahir, uterus mengalami perubahan untuk membantu pelepasan plasenta. Kontraksi uterus menyebabkan tempat implantasi plasenta mengecil sehingga plasenta dapat terlepas dari dinding uterus. Beberapa tanda dapat menunjukkan terjadinya pelepasan plasenta, seperti perubahan bentuk uterus, adanya semburan darah, dan pemanjangan tali pusat. Pengenalan tanda-tanda tersebut membantu bidan menentukan perkembangan kala III dan memberikan tindakan secara tepat.

Pengelolaan kala III perlu dilakukan secara sistematis dengan tetap memperhatikan kondisi perempuan. Kondisi umum, kontraksi uterus, perdarahan, serta tanda-tanda pelepasan plasenta perlu dipantau. Setelah plasenta lahir, kelengkapan plasenta dan selaput ketuban juga perlu diperiksa karena bagian yang tertinggal di dalam uterus dapat berhubungan dengan perdarahan atau komplikasi lainnya. Setiap perubahan kondisi perlu dinilai dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan.

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam pencegahan perdarahan postpartum adalah Active Management of the Third Stage of Labour (AMTSL). Prinsip utama pengelolaan aktif kala III adalah membantu mengurangi risiko perdarahan melalui penggunaan uterotonika dan pengelolaan proses kelahiran plasenta secara tepat. Penerapan AMTSL perlu dipahami berdasarkan prinsip dan tujuan klinisnya, bukan sekadar sebagai rangkaian tindakan yang dilakukan secara mekanis tanpa mempertimbangkan kondisi perempuan.

Uterotonika memiliki peran penting dalam pencegahan perdarahan postpartum karena membantu mempertahankan kontraksi uterus setelah bayi lahir. Oksitosin merupakan salah satu uterotonika yang digunakan untuk tujuan tersebut. Bidan perlu memahami indikasi, prinsip pemberian, pemantauan respons uterus, serta ketentuan penggunaan obat sesuai standar pelayanan dan protokol yang berlaku di fasilitas kesehatan. Apabila oksitosin tidak tersedia atau terdapat pertimbangan tertentu, pilihan uterotonika lain dapat dipertimbangkan sesuai rekomendasi yang berlaku dan kondisi pelayanan.

Controlled cord traction merupakan salah satu tindakan yang dapat digunakan dalam pengelolaan kala III oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan yang sesuai. Tindakan ini dilakukan untuk membantu kelahiran plasenta setelah terdapat tanda pelepasan plasenta dan kondisi yang memungkinkan. Traksi tidak dilakukan dengan menarik tali pusat secara sembarangan karena tarikan yang tidak tepat dapat menimbulkan komplikasi. Pengendalian uterus dan koordinasi gerakan tangan merupakan bagian penting dalam menjaga keamanan tindakan.

Waktu penjepitan dan pemotongan tali pusat juga perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari pengelolaan segera setelah kelahiran bayi. Pada bayi yang tidak memerlukan tindakan resusitasi segera, penundaan penjepitan tali pusat dapat memberikan manfaat tertentu bagi bayi. Sebaliknya, apabila terdapat kondisi yang membutuhkan penanganan segera, kebutuhan stabilisasi bayi menjadi pertimbangan utama. Dengan demikian, tindakan pada periode segera setelah kelahiran perlu disesuaikan dengan kondisi ibu dan bayi, bukan diterapkan secara kaku pada setiap persalinan.

Setelah plasenta lahir, perhatian terhadap kondisi perempuan tetap diperlukan. Kontraksi dan tonus uterus perlu dinilai, perdarahan perlu dipantau, serta kondisi umum dan tanda vital perlu diperhatikan sesuai kebutuhan. Apabila uterus tidak berkontraksi dengan baik atau terjadi perdarahan yang melebihi kondisi normal, bidan perlu segera melakukan penilaian dan tindakan sesuai kewenangan serta mengupayakan kolaborasi atau rujukan apabila diperlukan.

D. Pemantauan Ibu Setelah Plasenta Lahir dan Pencegahan Perdarahan Postpartum

Setelah plasenta lahir, kondisi ibu perlu dipantau secara berkesinambungan karena periode segera setelah persalinan merupakan fase penting dalam mendeteksi perubahan kondisi klinis dan komplikasi secara dini. Pemantauan mencakup kondisi umum ibu, kontraksi dan tonus uterus, jumlah serta karakteristik perdarahan, tanda-tanda vital, serta pemeriksaan kelengkapan plasenta dan selaput ketuban.

Kontraksi uterus memiliki peran penting dalam mempertahankan hemostasis setelah plasenta terlepas dari dinding uterus. Uterus yang berkontraksi dengan baik akan membantu menekan pembuluh darah pada tempat implantasi plasenta sehingga perdarahan dapat dikendalikan secara fisiologis. Sebaliknya, kontraksi uterus yang tidak adekuat dapat menyebabkan pembuluh darah pada tempat implantasi tetap terbuka dan meningkatkan risiko terjadinya perdarahan postpartum.

Pemantauan tonus uterus perlu dilakukan secara tepat untuk mengenali perubahan kondisi uterus setelah plasenta lahir. Uterus yang teraba keras menunjukkan kontraksi yang baik, sedangkan uterus yang lembek atau tidak berkontraksi secara adekuat perlu mendapat perhatian karena dapat berkaitan dengan atonia uteri. Penilaian tonus uterus harus dipahami sebagai bagian dari pemantauan klinis, bukan sekadar tindakan rutin yang dilakukan tanpa mempertimbangkan kondisi ibu.

Selain menilai uterus, jumlah dan karakteristik perdarahan juga menjadi bagian penting dalam pemantauan. Perdarahan yang meningkat, berlangsung terus-menerus, atau disertai perubahan kondisi umum dan tanda-tanda vital dapat menunjukkan adanya komplikasi yang membutuhkan respons segera. Oleh karena itu, perubahan kondisi ibu perlu dinilai secara menyeluruh dengan mempertimbangkan hubungan antara temuan klinis, kondisi uterus, dan kehilangan darah.

Kelengkapan plasenta dan selaput ketuban juga perlu diperhatikan setelah plasenta lahir. Adanya bagian plasenta atau selaput yang tertinggal di dalam uterus dapat mengganggu proses involusi dan kontraksi uterus serta berkaitan dengan perdarahan postpartum. Pemeriksaan terhadap kelengkapan plasenta menjadi bagian penting dalam memastikan proses persalinan telah berlangsung secara lengkap.

Pemahaman mengenai pemantauan setelah plasenta lahir membantu tenaga kesehatan mengenali kondisi fisiologis dan perubahan yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Penolong perlu mampu membedakan kondisi yang masih dapat dipantau dengan kondisi yang membutuhkan tindakan segera, kolaborasi, atau rujukan sesuai kewenangan dan kondisi klinis ibu. Dengan demikian, pemantauan tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan observasi, tetapi menjadi dasar dalam pengambilan keputusan untuk menjaga keselamatan ibu pada periode segera setelah persalinan.

E. Keselamatan Pasien, Komunikasi, dan KIE dalam Tindakan Persalinan

Pelayanan persalinan merupakan rangkaian asuhan yang membutuhkan ketepatan tindakan sekaligus perhatian terhadap keselamatan dan pengalaman perempuan selama proses persalinan. Setiap tindakan perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi klinis, kebutuhan individual, kewenangan tenaga kesehatan, serta prinsip keselamatan pasien. Keselamatan dalam pelayanan persalinan tidak hanya ditentukan oleh keterampilan teknis, tetapi juga oleh kemampuan penolong mengenali risiko, berkomunikasi secara efektif, menjaga lingkungan pelayanan yang aman, dan merespons perubahan kondisi secara tepat.

Pencegahan dan pengendalian infeksi menjadi salah satu komponen penting dalam menjaga keselamatan ibu dan bayi. Kebersihan tangan, penggunaan alat yang sesuai, pengelolaan alat dan bahan, serta kebersihan lingkungan pelayanan merupakan bagian dari upaya meminimalkan risiko infeksi. Kesiapan alat dan lingkungan juga perlu diperhatikan agar pelayanan dapat berlangsung secara aman dan respons terhadap kondisi yang membutuhkan tindakan lebih lanjut dapat dilakukan tanpa keterlambatan.

Identifikasi pasien dan komunikasi antaranggota tim turut berperan dalam mencegah kesalahan pelayanan. Informasi mengenai identitas, kondisi klinis, hasil pemantauan, serta tindakan yang telah atau akan dilakukan perlu disampaikan secara jelas dan akurat. Dokumentasi yang lengkap dan sistematis menjadi bagian dari kesinambungan asuhan karena menyediakan informasi penting mengenai kondisi perempuan, tindakan yang diberikan, respons terhadap tindakan, serta perkembangan selanjutnya.

Komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) merupakan bagian integral dari asuhan selama persalinan. Perempuan berhak memperoleh informasi yang relevan mengenai kondisi dan perkembangan persalinannya, tujuan serta manfaat tindakan, kemungkinan pilihan yang tersedia, dan informasi lain yang diperlukan untuk memahami asuhan yang diberikan. Informasi perlu disampaikan menggunakan bahasa yang jelas, mudah dipahami, dan disesuaikan dengan kebutuhan perempuan serta keluarganya.

Komunikasi dalam pelayanan persalinan juga berkaitan erat dengan penghormatan terhadap hak, privasi, martabat, dan pilihan perempuan. Penolong perlu membangun hubungan yang saling menghargai dengan memberikan kesempatan kepada perempuan untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan kebutuhan, kekhawatiran, atau preferensinya. Penyampaian informasi secara terbuka dapat membantu perempuan memahami kondisi yang dihadapi dan berpartisipasi dalam keputusan yang berkaitan dengan asuhannya sesuai dengan kondisi klinis dan ketentuan yang berlaku.

Dukungan verbal dan nonverbal yang diberikan selama persalinan dapat membantu menciptakan suasana pelayanan yang lebih aman dan nyaman. Sikap penolong yang tenang, empatik, tidak menghakimi, serta responsif terhadap kebutuhan perempuan dapat mendukung terjalinnya kerja sama selama proses persalinan. Sebaliknya, komunikasi yang merendahkan, mengabaikan kekhawatiran, atau tidak memberikan kesempatan kepada perempuan untuk memperoleh informasi dapat mengurangi rasa aman dan kepercayaan terhadap pelayanan.

F. Integrasi Keterampilan Klinis dalam Persalinan Aman

Pimpinan persalinan, perlindungan perineum, dan manajemen aktif kala III (AMTSL) merupakan keterampilan klinis yang saling berkaitan dalam keseluruhan rangkaian asuhan persalinan. Penguasaan satu keterampilan saja belum cukup untuk menjamin keselamatan ibu dan bayi. Penolong perlu mampu mengintegrasikan hasil pengkajian, pengambilan keputusan klinis, keterampilan teknis, komunikasi, pemantauan, serta evaluasi secara berkesinambungan sesuai perkembangan persalinan.

Dalam praktiknya, setiap tindakan harus disesuaikan dengan kondisi perempuan, kemajuan persalinan, kondisi janin, serta respons ibu terhadap proses persalinan. Mahasiswa tidak hanya dituntut mampu menjelaskan atau melakukan prosedur, tetapi juga memahami alasan klinis yang mendasari setiap tindakan, waktu yang tepat untuk melakukannya, kondisi yang perlu menjadi perhatian, serta risiko yang dapat terjadi apabila tindakan dilakukan secara tidak tepat.

Kemampuan mengintegrasikan berbagai keterampilan tersebut juga diperlukan untuk membangun penalaran klinis. Penolong harus mampu mengenali perubahan kondisi selama persalinan, membedakan keadaan fisiologis dan kondisi yang memerlukan perhatian lebih lanjut, serta menentukan tindakan berdasarkan hasil pengkajian. Setelah tindakan dilakukan, pemantauan tetap diperlukan untuk menilai respons ibu dan bayi serta memastikan bahwa tujuan tindakan telah tercapai.

Komunikasi dengan perempuan dan keluarga juga menjadi bagian penting dalam integrasi keterampilan klinis. Penolong perlu menjelaskan perkembangan persalinan dan tindakan yang akan dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami, tetap menjaga privasi, kenyamanan, serta menghormati pilihan perempuan selama proses persalinan.

G. Latihan Soal

1. Seorang perempuan berusia 25 tahun, G2P1A0, hamil 39 minggu sedang menjalani persalinan di TPMB. Hasil pemeriksaan menunjukkan pembukaan serviks lengkap, kepala janin telah turun, kontraksi kuat dan teratur, serta perempuan mulai merasakan dorongan meneran. Kondisi umum ibu baik dan kondisi janin dalam batas normal. Perempuan mengatakan lebih nyaman meneran dengan posisi setengah duduk.
   Apakah tindakan yang paling tepat dilakukan bidan pada kasus tersebut?
   A. Meminta perempuan tetap dalam posisi terlentang selama meneran
   B. Mendukung perempuan meneran sesuai dorongan dan posisi yang nyaman
   C. Memimpin perempuan meneran terus-menerus meskipun tidak ada kontraksi
   D. Melakukan intervensi untuk mempercepat persalinan karena pembukaan telah lengkap
   E. Meminta perempuan menahan seluruh dorongan meneran sampai kepala terlihat di introitus

   Kunci jawaban: B. Mendukung perempuan meneran sesuai dorongan dan posisi yang nyaman

   Rasional: Pada kala II dengan kondisi ibu dan janin baik serta terdapat kemajuan persalinan, proses fisiologis perlu diberi kesempatan berlangsung. Perempuan dapat didukung memilih posisi yang nyaman selama tidak terdapat kontraindikasi. Pimpinan persalinan bukan berarti mengambil alih proses meneran, tetapi memberikan dukungan sesuai kebutuhan.
   A. A tidak tepat: Posisi terlentang tidak harus diterapkan secara rutin bila perempuan lebih nyaman dengan posisi lain dan tidak ada kontraindikasi.
   B. B tepat: Mendukung dorongan fisiologis dan pilihan posisi perempuan sesuai prinsip asuhan berpusat pada perempuan.
   C. C tidak tepat: Meneran terus-menerus tanpa kontraksi merupakan intervensi yang tidak diperlukan.
   D. D tidak tepat: Kondisi ibu dan janin baik serta persalinan mengalami kemajuan, sehingga tidak terdapat indikasi untuk mempercepat persalinan.
   E. E tidak tepat: Dorongan meneran fisiologis pada pembukaan lengkap tidak perlu ditahan seluruhnya tanpa alasan klinis.

2. Seorang perempuan berusia 23 tahun, G1P0A0, hamil 40 minggu berada pada kala II persalinan. Kepala janin mulai tampak pada introitus vagina dan semakin membuka vulva saat kontraksi. Kondisi ibu dan janin baik. Perempuan tampak tegang dan ingin meneran kuat agar bayi segera lahir. Perineum tampak meregang, tetapi tidak terdapat indikasi khusus untuk tindakan operatif.
   Apakah tindakan yang paling tepat dilakukan bidan?
   A. Melakukan episiotomi secara rutin untuk mencegah robekan
   B. Meminta perempuan meneran sekuat-kuatnya sampai kepala lahir

C. Mengendalikan lahirnya kepala sambil memberikan arahan yang tenang
D. Menarik kepala bayi agar proses kelahiran berlangsung lebih cepat
E. Menghentikan proses kelahiran kepala sampai kontraksi berikutnya

Kunci jawaban: C. Mengendalikan lahirnya kepala sambil memberikan arahan yang tenang

Rasional: Ketika kepala mulai lahir, proses kelahiran perlu berlangsung secara terkendali agar jaringan perineum memiliki kesempatan beradaptasi terhadap peregangan. Komunikasi yang tenang dan jelas juga diperlukan. Episiotomi bukan tindakan rutin dan hanya dilakukan berdasarkan indikasi klinis.

A. A tidak tepat: Episiotomi tidak dianjurkan sebagai tindakan rutin pada setiap persalinan.
B. B tidak tepat: Meneran terlalu kuat dapat menyebabkan lahirnya kepala terlalu cepat dan meningkatkan trauma jaringan.
C. C tepat: Kelahiran kepala secara terkendali merupakan bagian penting dalam perlindungan perineum.
D. D tidak tepat: Kepala bayi tidak boleh ditarik untuk mempercepat persalinan fisiologis.
E. E tidak tepat: Penolong tidak perlu menghentikan proses fisiologis kelahiran kepala secara paksa.

3. Seorang perempuan berusia 29 tahun, P2A0, baru melahirkan bayi secara spontan di puskesmas. Beberapa saat kemudian uterus teraba berkontraksi, tampak semburan darah secara tiba-tiba, dan tali pusat terlihat memanjang dari vulva. Kondisi umum ibu baik dan tidak ditemukan perdarahan berlebihan. Bidan sedang melakukan pengelolaan aktif kala III persalinan.
   Apakah tindakan yang paling tepat selanjutnya?
   A. Menunggu plasenta keluar tanpa melakukan pemantauan
   B. Menarik tali pusat dengan kuat agar plasenta segera lahir
   C. Melakukan controlled cord traction secara tepat
   D. Memasukkan tangan ke dalam uterus untuk mengambil plasenta
   E. Meminta ibu meneran terus-menerus tanpa menilai kondisi uterus

   Kunci jawaban: C. Melakukan controlled cord traction secara tepat

   Rasional: Perubahan bentuk uterus, semburan darah, dan pemanjangan tali pusat merupakan tanda pelepasan plasenta. Controlled cord traction dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang terampil setelah terdapat tanda pelepasan plasenta dan kondisi memungkinkan. Traksi tidak dilakukan dengan menarik tali pusat secara sembarangan.

   A. A tidak tepat: Kala III tetap membutuhkan pemantauan dan pengelolaan yang sistematis.

B. B tidak tepat: Tarikan tali pusat yang tidak terkendali dapat menimbulkan komplikasi.
C. C tepat: Tanda pelepasan plasenta telah ditemukan sehingga controlled cord traction dapat dilakukan dengan teknik yang tepat.
D. D tidak tepat: Tidak terdapat kondisi dalam kasus yang menunjukkan kebutuhan tindakan tersebut.
E. E tidak tepat: Tindakan harus didasarkan pada penilaian kondisi ibu dan tanda pelepasan plasenta.

4. Seorang perempuan berusia 32 tahun, P3A0, telah melahirkan plasenta secara lengkap 10 menit yang lalu. Saat dilakukan pemantauan, bidan menemukan darah keluar lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Uterus teraba lembek dan kontraksinya tidak adekuat. Perempuan mulai mengeluh lemas. Bidan telah memastikan bahwa plasenta dan selaput ketuban tampak lengkap.
   Apakah masalah yang paling perlu segera menjadi perhatian bidan?
   A. Infeksi puerperium
   B. Atonia uteri
   C. Ruptur membran
   D. Persalinan kala II memanjang
   E. Retensio plasenta
   Kunci jawaban: B. Atonia uteri
   Rasional: Setelah plasenta lahir, uterus seharusnya berkontraksi dengan baik sehingga pembuluh darah pada tempat implantasi plasenta tertekan. Uterus yang lembek atau tidak berkontraksi secara adekuat berkaitan dengan atonia uteri dan meningkatkan risiko perdarahan postpartum.
   A. A tidak tepat: Kasus menunjukkan masalah segera setelah persalinan berupa uterus lembek dan perdarahan, bukan tanda utama infeksi.
   B. B tepat: Uterus lembek disertai peningkatan perdarahan merupakan temuan yang mengarah pada atonia uteri.
   C. C tidak tepat: Ruptur membran bukan masalah yang menjelaskan kondisi setelah plasenta lahir tersebut.
   D. D tidak tepat: Persalinan kala II telah selesai.
   E. E tidak tepat: Plasenta telah lahir dan dinilai lengkap.

5. Seorang perempuan berusia 27 tahun, G1P0A0, sedang menjalani kala II persalinan. Kepala bayi mulai turun dan kondisi ibu serta janin dalam batas normal. Perempuan tampak cemas ketika bidan mempersiapkan tindakan dan bertanya, "Apa yang akan dilakukan kepada saya? Apakah saya harus digunting supaya bayi cepat lahir?" Tidak terdapat indikasi klinis untuk episiotomi.
   Apakah respons bidan yang paling tepat?
   A. Menjelaskan bahwa episiotomi pasti dilakukan pada persalinan pertama

B. Meminta perempuan mengikuti seluruh tindakan tanpa banyak bertanya
C. Menjelaskan kondisi, tindakan yang diperlukan, dan melibatkan perempuan dalam asuhan
D. Menyerahkan seluruh keputusan klinis kepada keluarga perempuan
E. Menghindari penjelasan agar perempuan tidak semakin cemas

Kunci jawaban: C. Menjelaskan kondisi, tindakan yang diperlukan, dan melibatkan perempuan dalam asuhan

Rasional: Perempuan berhak memperoleh informasi mengenai kondisi dan perkembangan persalinan, tujuan dan manfaat tindakan, serta pilihan yang tersedia. Komunikasi harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami serta menghormati hak, martabat, privasi, dan pilihan perempuan. Episiotomi sendiri bukan tindakan rutin dan harus berdasarkan indikasi klinis.

A. A tidak tepat: Episiotomi tidak dilakukan secara rutin hanya karena perempuan primipara.
B. B tidak tepat: Perempuan memiliki hak untuk mengetahui dan berpartisipasi dalam asuhan.
C. C tepat: Tindakan ini mencerminkan komunikasi efektif dan asuhan yang berpusat pada perempuan.
D. D tidak tepat: Keluarga dapat memberikan dukungan, tetapi keputusan terkait asuhan tetap melibatkan perempuan sesuai kondisi klinis.
E. E tidak tepat: Menghindari informasi justru bertentangan dengan prinsip komunikasi dan hak perempuan.

H. Ringkasan

Persalinan aman merupakan rangkaian asuhan yang membutuhkan integrasi antara pengetahuan, keterampilan klinis, pengambilan keputusan, komunikasi, dan pemantauan secara berkesinambungan. Pada kala II, bidan perlu mendukung berlangsungnya proses fisiologis persalinan dengan memperhatikan kondisi ibu dan janin, kemajuan persalinan, dorongan meneran, serta pilihan posisi perempuan. Tindakan atau intervensi dilakukan berdasarkan kebutuhan dan indikasi klinis dengan tetap mengutamakan keselamatan ibu dan bayi.

Perlindungan perineum merupakan bagian penting dalam membantu kelahiran secara aman dan mengurangi risiko trauma perineum. Kelahiran kepala yang terkendali, pemilihan teknik perlindungan perineum sesuai kondisi, penggunaan kompres hangat atau pijat perineum pada situasi yang sesuai, serta menghindari episiotomi rutin merupakan bagian dari pendekatan berbasis bukti. Setelah bayi lahir, penilaian kondisi perineum juga diperlukan untuk menentukan kebutuhan penatalaksanaan selanjutnya.

Pengelolaan kala III melalui prinsip manajemen aktif kala III (AMTSL) memiliki peran penting dalam pencegahan perdarahan postpartum. Penggunaan uterotonika, pengelolaan kelahiran plasenta secara tepat, pengenalan tanda pelepasan plasenta, serta pemantauan kontraksi uterus dan perdarahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari asuhan. Setelah plasenta lahir, pemantauan kondisi umum ibu, tonus uterus, jumlah perdarahan, tanda vital, serta kelengkapan plasenta dan selaput ketuban harus tetap dilakukan untuk mendeteksi komplikasi secara dini.

Seluruh keterampilan tersebut perlu dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keselamatan pasien, pencegahan infeksi, komunikasi efektif, dokumentasi, serta penghormatan terhadap hak dan pilihan perempuan. Dengan mengintegrasikan pengkajian, keterampilan teknis, komunikasi, pemantauan, dan evaluasi, bidan dapat memberikan asuhan persalinan yang aman, efektif, berbasis bukti, berpusat pada perempuan, serta sesuai dengan kewenangan profesi dan kebutuhan klinis.

I. Daftar Pustaka

Dwan, K., Fox, T., Lutje, V., Lavender, T., & Mills, T. A. (2024). Perineal techniques during the second stage of labour for reducing perineal trauma and postpartum complications. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2024(10), CD016148. https://doi.org/10.1002/14651858.CD016148

International Confederation of Midwives. (2024). Essential competencies for midwifery practice. International Confederation of Midwives.

National Institute for Health and Care Excellence. (2023). Intrapartum care (NICE guideline NG235). National Institute for Health and Care Excellence.

World Health Organization, International Federation of Gynecology and Obstetrics, & International Confederation of Midwives. (2025). Consolidated guidelines for the prevention, diagnosis and treatment of postpartum haemorrhage. World Health Organization.

World Health Organization. (2021). WHO labour care guide: User's manual. World Health Organization.

World Health Organization. (2022). Key points for considering adoption of the WHO labour care guide: Policy brief. World Health Organization.

World Health Organization. (2022). WHO recommendations on maternal and newborn care for a positive postnatal experience. World Health Organization.

World Health Organization. (2025). Compendium on respectful maternal and newborn care. World Health Organization.

BAB 2

KETERAMPILAN ASUHAN BAYI BARU LAHIR: PENGERINGAN, IMD, TERMOREGULASI, DAN PERAWATAN TALI PUSAT

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang Berkontribusi
CPL-2	Menerapkan komunikasi terapeutik, konseling, dan kolaborasi yang berpusat pada perempuan dan keluarga.	CPMK-2; CPMK-7
CPL-3	Menerapkan keselamatan pasien, pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI), serta K3 dalam seluruh tindakan klinis.	CPMK-1; CPMK-7

Kode CPMK	**Rumusan CPMK**
CPMK-1	Menerapkan prinsip keselamatan pasien, APD, pencegahan infeksi, dan K3 pada seluruh keterampilan klinis kebidanan.
CPMK-2	Melaksanakan komunikasi terapeutik dan KIE/konseling kebidanan yang empatik, terstruktur, dan sesuai kebutuhan serta literasi kesehatan
CPMK-7	Melaksanakan tindakan dasar asuhan kebidanan dan stabilisasi awal pada persalinan, nifas, bayi baru lahir, KB, serta rujukan aman sesuai standar

Uraian Materi

A. Asuhan Bayi Baru Lahir

Asuhan bayi baru lahir merupakan serangkaian intervensi esensial yang dilakukan segera setelah kelahiran untuk memastikan keberlangsungan hidup bayi serta mendukung proses adaptasi dari kehidupan intrauterin ke ekstrauterin. Intervensi ini meliputi pengeringan bayi, inisiasi menyusu dini (IMD), termoregulasi, dan perawatan tali pusat, yang seluruhnya telah terbukti secara ilmiah berkontribusi signifikan terhadap penurunan angka morbiditas dan mortalitas neonatal (Moore et al., 2016; Boundy et al., 2016; World Health Organization, 2023). Pengeringan bayi merupakan tindakan awal yang sangat penting karena bayi baru lahir sangat rentan kehilangan panas melalui mekanisme evaporasi akibat cairan ketuban yang melekat pada tubuhnya; oleh karena itu, bayi harus segera dikeringkan dalam waktu kurang dari 30 detik setelah lahir menggunakan kain bersih dan kering tanpa menghilangkan verniks kaseosa secara berlebihan, karena lapisan tersebut memiliki fungsi protektif terhadap infeksi dan kehilangan panas (Lunze et al., 2018; Widström et al., 2019). Setelah pengeringan, bayi dianjurkan untuk segera dilakukan kontak kulit dengan ibu (skin-to-skin contact) sebagai bagian dari pelaksanaan IMD, yaitu suatu proses alami yang memungkinkan bayi mencari puting susu ibu dan mulai menyusu dalam satu jam pertama kehidupan; praktik ini tidak hanya meningkatkan keberhasilan pemberian ASI eksklusif, tetapi juga memperkuat ikatan emosional antara ibu dan bayi serta menstabilkan suhu tubuh, denyut jantung, dan pernapasan bayi (Moore et al., 2016; Smith et al., 2017)

Selanjutnya, termoregulasi menjadi komponen krusial dalam asuhan bayi baru lahir mengingat sistem pengaturan suhu tubuh bayi belum matang sehingga sangat rentan terhadap hipotermia, yang dapat meningkatkan risiko kematian neonatal (Lunze et al., 2018; Boundy et al., 2016). Upaya menjaga suhu tubuh bayi dilakukan melalui berbagai cara, antara lain mempertahankan kontak kulit dengan ibu, menyelimuti bayi dengan kain hangat, menggunakan topi untuk mengurangi kehilangan panas melalui kepala, serta memastikan lingkungan sekitar tetap hangat dengan suhu minimal 25°C dan bebas dari aliran udara langsung (World Health Organization, 2023). Selain itu, penundaan mandi bayi selama minimal 24 jam setelah lahir juga dianjurkan untuk mencegah penurunan suhu tubuh secara drastis (Lunze et al., 2018). Perawatan tali pusat juga merupakan bagian penting dari asuhan bayi baru lahir, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya infeksi seperti omfalitis yang dapat berujung pada sepsis neonatal; prosedur ini dilakukan dengan cara menjepit dan memotong tali pusat menggunakan alat steril, kemudian menjaga tali pusat tetap bersih dan kering tanpa pemberian bahan tradisional atau zat yang tidak

direkomendasikan (Imdad et al., 2013; Kemenkes RI, 2020). Pendekatan yang dianjurkan secara luas adalah metode dry cord care, yaitu membiarkan tali pusat terbuka tanpa penutup agar cepat mengering dan lepas secara alami, meskipun pada daerah dengan risiko infeksi tinggi dapat dipertimbangkan penggunaan antiseptik seperti klorheksidin sesuai rekomendasi (Imdad et al., 2013; World Health Organization, 2023).

Pelaksanaan asuhan bayi baru lahir memiliki tujuan utama untuk mencegah hipotermia, infeksi, serta komplikasi lain yang dapat mengancam kehidupan bayi, sekaligus mendukung keberhasilan menyusui dan tumbuh kembang optimal (Moore et al., 2016; Boundy et al., 2016). Indikasi tindakan ini mencakup seluruh bayi baru lahir dengan kondisi stabil, baik bayi cukup bulan maupun bayi dengan risiko ringan, sedangkan pada kondisi tertentu seperti asfiksia berat atau ketidakstabilan kondisi ibu dan bayi, beberapa intervensi seperti IMD perlu ditunda hingga kondisi memungkinkan (World Health Organization, 2023; Fraser & Cooper, 2017). Dalam pelaksanaannya, tenaga kesehatan harus mempersiapkan alat dan lingkungan yang sesuai, termasuk kain kering, selimut, topi bayi, klem dan gunting steril, serta memastikan kebersihan tangan dan penggunaan alat pelindung diri guna mencegah infeksi (Kemenkes RI, 2020; Varney, 2018). Selain itu, aspek keselamatan harus diperhatikan secara ketat, seperti memastikan bayi tidak terjatuh saat dilakukan kontak kulit dengan ibu, memantau suhu tubuh secara berkala, serta mengamati tanda-tanda bahaya seperti kesulitan bernapas atau perubahan warna kulit (Boundy et al., 2016).

B. Evaluasi

Evaluasi terhadap asuhan yang diberikan dilakukan dengan menilai stabilitas suhu tubuh bayi dalam rentang normal (36,5–37,5°C), keberhasilan bayi dalam melakukan pelekatan dan menyusu, serta tidak adanya tanda-tanda infeksi pada tali pusat seperti kemerahan, bengkak, atau keluar cairan berbau (Lunze et al., 2018; Imdad et al., 2013). Seluruh tindakan yang dilakukan harus didokumentasikan secara lengkap dalam rekam medis, meliputi waktu kelahiran, tindakan pengeringan, pelaksanaan IMD, hasil pemantauan suhu, kondisi tali pusat, serta respons bayi terhadap intervensi yang diberikan (Kemenkes RI, 2020).

C. Dokumentasi

Dokumentasi yang baik tidak hanya berfungsi sebagai bukti pelayanan, tetapi juga sebagai dasar untuk evaluasi dan tindak lanjut asuhan kebidanan. Berbagai penelitian, termasuk kajian sistematis oleh Moore et al. (2016) dan Boundy et al.

(2016), serta rekomendasi dari World Health Organization (2023), menunjukkan bahwa penerapan intervensi sederhana namun berbasis bukti ini dapat menurunkan angka kematian neonatal secara signifikan, sehingga menjadi standar pelayanan yang wajib diterapkan dalam praktik kebidanan di berbagai tingkat fasilitas kesehatan.

Aktivitas 1 — *Knows How*

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Kasus :

Seorang perempuan usia 26 tahun, G2P1A0, melahirkan secara spontan di Puskesmas pada pukul 10.15 WIB. Bayi lahir cukup bulan, langsung menangis kuat, warna kulit kemerahan, tonus otot baik, dan tidak terdapat kelainan kongenital yang tampak. Berat badan lahir 3200 gram.

Segera setelah lahir, bayi diletakkan di atas perut ibu, namun bidan tidak langsung mengeringkan bayi secara optimal karena fokus pada persiapan alat lainnya. Bayi tampak masih basah oleh cairan ketuban selama beberapa menit. Selanjutnya bayi dibungkus dengan kain, tetapi tidak dilakukan kontak kulit dengan ibu secara maksimal dan IMD tidak segera dimulai.

Pada pukul 10.30 WIB, bayi tampak sedikit menggigil, ekstremitas teraba dingin, suhu aksila 36,2°C. Bayi belum menunjukkan refleks menyusu yang kuat. Bidan kemudian memindahkan bayi ke tempat tidur terpisah dan membungkusnya dengan selimut tanpa menggunakan topi.

Pada pukul 11.00 WIB, dilakukan pemeriksaan ulang, suhu bayi 36,0°C, frekuensi napas 58 x/menit, denyut jantung 160 x/menit. Tali pusat telah dipotong, namun ditutup dengan kasa yang agak lembap. Tidak dilakukan edukasi khusus kepada ibu mengenai perawatan tali pusat.

Pertanyaan Diskusi

1. Apa masalah utama pada kasus di atas?
2. Data apa saja yang mendukung analisis Anda terkait masalah tersebut?
3. Dari komponen asuhan bayi baru lahir (pengeringan, IMD, termoregulasi, perawatan tali pusat), bagian mana yang tidak dilakukan atau tidak optimal? Jelaskan.
4. Apa risiko atau komplikasi yang dapat terjadi akibat kondisi tersebut pada bayi?
5. Tanda bahaya apa yang mulai muncul pada bayi dalam kasus ini?
6. Apa tindakan awal yang harus segera dilakukan oleh bidan untuk mengatasi kondisi bayi tersebut?
7. Apakah kondisi ini masih dapat ditangani di fasilitas pelayanan awal atau memerlukan rujukan? Jelaskan alasan Anda.
8. Bagaimana seharusnya langkah yang benar dalam melakukan pengeringan, IMD, dan termoregulasi pada kasus ini?
9. Apa kesalahan dalam perawatan tali pusat pada kasus di atas, dan bagaimana perawatan yang benar sesuai standar?

10. Informasi dan edukasi apa yang harus diberikan kepada ibu dan keluarga terkait perawatan bayi baru lahir di rumah?

D. Latihan Soal

No.	Komponen	Isi
1	No. Stasiun	1
2	Judul	Asuhan Bayi Baru Lahir
3	Kasus	Asuhan bayi baru lahir normal dengan fokus pengeringan, IMD, termoregulasi, dan perawatan tali pusat
4	Tujuan	Untuk mengetahui bahwa peserta dapat menunjukkan kriteria sebagai calon bidan yang kompeten dalam asuhan bayi baru lahir secara komprehensif, aman, dan berbasis standar
5	Kompetensi	1) Anamnesis singkat terkait kondisi bayi dan ibu 2) Pemeriksaan fisik bayi baru lahir 3) Perumusan diagnosis/masalah kebidanan 4) Prosedur tindakan klinis (pengeringan, IMD, termoregulasi, perawatan tali pusat) 5) KIE/konseling 6) Kolaborasi/rujukan 7) Perilaku profesional
6	Soal: Skenario dan tugas peserta ujian	SKENARIO KLINIK Seorang bayi laki-laki lahir spontan di Puskesmas pada pukul 09.20 WIB dari ibu usia 25 tahun, G1P1A0, usia kehamilan 39 minggu. Bayi lahir langsung menangis, warna kulit kemerahan, tonus otot baik, dan berat badan lahir 3100 gram. Setelah lahir, bayi diletakkan di atas perut ibu, namun belum dikeringkan secara optimal dan masih tampak basah oleh cairan ketuban. Bayi belum dilakukan kontak kulit secara maksimal dan belum dilakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD). Pada 15 menit setelah lahir, bayi tampak sedikit menggigil, suhu aksila 36,3°C, dan belum menunjukkan refleks menyusu yang kuat. Tali pusat telah dipotong, namun ditutup dengan kasa lembap.

No.	Komponen	Isi
		TUGAS 1) Lakukan penilaian awal bayi baru lahir. 2) Lakukan pemeriksaan fisik bayi secara terfokus. 3) Sampaikan diagnosis/masalah kebidanan berdasarkan data yang diperoleh. 4) Lakukan tindakan asuhan bayi baru lahir yang tepat sesuai standar. 5) Berikan KIE kepada ibu terkait IMD, menjaga kehangatan bayi, dan perawatan tali pusat. 6) Tentukan apakah diperlukan kolaborasi/rujukan.
7	Instruksi penguji	INSTRUKSI UMUM 1) Pastikan identitas peserta ujian sesuai dengan kartu ujian. 2) Penomoran peserta mengikuti ketentuan institusi/nasional. 3) Gunakan format penilaian: • Actual mark (0–3) • Global rating (1–4) 4) Penguji tidak diperbolehkan berinteraksi di luar skenario. 5) Laksanakan penilaian sesuai standar OSCE. INSTRUKSI KHUSUS 1) Jika peserta melakukan penilaian awal bayi, penguji memberikan data: • Menangis kuat • Frekuensi napas 50 x/menit • Denyut jantung 140 x/menit • Suhu 36,3°C 2) Jika peserta melakukan pemeriksaan: • Refleks rooting lemah • Ekstremitas dingin • Tonus otot baik 3) Tindakan yang diharapkan: • Segera mengeringkan bayi dengan benar • Melakukan skin-to-skin contact

No.	Komponen	Isi
		• Memulai IMD • Menjaga kehangatan bayi (selimut, topi) • Memantau suhu bayi • Melakukan perawatan tali pusat dengan teknik bersih dan kering • Memberikan edukasi kepada ibu 4) Penguji hanya memberikan data jika diminta sesuai langkah peserta. INSTRUKSI TAMBAHAN 1) Rapikan alat setelah digunakan. 2) Siapkan station untuk peserta berikutnya
8	Kebutuhan dan instruksi PS	Instruksi PS: 1) PS berperan sebagai ibu post partum. 2) PS tampak lelah namun sadar penuh. 3) PS terlihat khawatir karena bayi belum menyusu. 4) Jika diberikan edukasi, PS kooperatif.
9	Dialog PS	Peserta: Selamat pagi/siang, Bu. PS: Pagi/siang, Bu. Peserta: Saya bidan yang akan membantu ibu dan bayi. PS: Iya, Bu. Peserta: Bagaimana kondisi bayi sejak lahir? PS: Tadi langsung menangis, tapi sekarang seperti dingin dan belum menyusu. Peserta: Apakah bayi sudah menyusu? PS: Belum, Bu. Peserta: Ibu tidak perlu khawatir, saya akan membantu agar bayi tetap hangat dan mulai menyusu. PS: Iya, Bu, tolong bantu bayi saya.
10	Kebutuhan manikin	1) Manekin bayi baru lahir 2) Phantom ibu untuk simulasi IMD
11	Kebutuhan laboran	Peran laboran: 1) Menyiapkan alat dan manekin 2) Merapikan alat setelah digunakan 3) Memastikan station siap

No.	Komponen	Isi
12	Kebutuhan alat	1) Meja/perlak — 1 2) Manekin bayi — 1 3) Handuk/kain kering — 1 4) Selimut bayi — 1 5) Topi bayi — 1 6) Sarung tangan — 1 pasang 7) Klem tali pusat — 1 8) Gunting steril — 1 9) Kasa steril — 1 10) Termometer — 1 11) Handrub — 1 12) Tisu — 1 pack 13) Lembar penilaian — 1 14) Pena — 1
13	Penulis	Hanik Khairun Nisa, S.Tr.Keb., Bdn., M.Keb
14	Referensi	1) Boundy, E. O., et al. (2016). *Kangaroo mother care*. *Pediatrics*. 2) Imdad, A., et al. (2013). *Umbilical cord care*. *BMC Public Health*. 3) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Standar Profesi Bidan*. 4) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Standar Kompetensi Bidan*. 5) Moore, E. R., et al. (2016). *Early skin-to-skin contact*. *Cochrane Database*. 6) World Health Organization. (2023). *Newborn care guidelines*.

RUBRIK PENILAIAN DAN KELULUSAN

Stase 1: Asuhan Bayi Baru Lahir

KOMPETENSI 1. Pengumpulan Data Subjektif

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1) Kondisi bayi saat lahir (menangis, warna kulit, tonus)		
2) Riwayat segera setelah lahir (langsung dikeringkan/tidak)		
3) Riwayat IMD (sudah/belum dilakukan)		
4) Kondisi suhu bayi/riwayat menggigil/dingin		
5) Riwayat menyusu (sudah/belum, refleks)		
6) Kondisi tali pusat (bersih/kering/lembap)		
7) Riwayat tindakan awal oleh tenaga kesehatan		
8) Kondisi ibu dan kesiapan menyusui		

Skoring KOMPETENSI 1

- **3** = Jika peserta ujian melakukan semua **8 langkah** dengan benar.
- **2** = Jika peserta melakukan **5–7 dari 8 langkah** dengan benar.
- **1** = Jika peserta melakukan **1–4 dari 8 langkah** dengan benar.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 2. Prosedur Tindakan Klinis

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1) Persiapan		
a. Menyapa ibu dengan sopan		
b. Memperkenalkan diri dan menjelaskan tindakan		
c. Meminta persetujuan		
d. Menjaga privasi ibu dan bayi		
e. Mencuci tangan/hand hygiene		
f. Menyiapkan alat		
2) Langkah-langkah		
a. Menilai kondisi bayi (napas, warna, tonus)		
b. Mengeringkan bayi dengan benar		
c. Mengganti kain basah dengan kain kering		
d. Melakukan skin-to-skin contact		

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
e. Memulai IMD		
f. Menjaga jalan napas bayi		
g. Menjaga kehangatan bayi (selimut, topi)		
h. Memantau suhu bayi		
i. Mengidentifikasi tanda hipotermia		
j. Melakukan perawatan tali pusat dengan teknik bersih		
k. Tidak menutup tali pusat dengan kasa lembap		
l. Menghindari penggunaan bahan tradisional		
m. Melakukan observasi ulang bayi		
n. Menentukan adanya masalah (hipotermia/IMD tidak adekuat)		
3) Pasca tindakan		
a. Menjelaskan hasil tindakan		
b. Mencatat hasil tindakan		
c. Mencuci tangan kembali		

Skoring KOMPETENSI 2

- **3** = Jika melakukan 15–19 langkah dengan tepat dan sistematis
- **2** = Jika melakukan 10–14 langkah dengan cukup tepat
- **1** = Jika melakukan 1–9 langkah atau banyak kesalahan
- **0** = Tidak melakukan atau tidak tepat.

KOMPETENSI 3. KIE/Konseling

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1) Sapa dan salam		
2) Menjelaskan kondisi bayi (suhu, menyusu, dll)		
3) Menjelaskan pentingnya IMD		
4) Menjelaskan cara menjaga kehangatan bayi		
5) Menjelaskan perawatan tali pusat		
6) Memberi kesempatan bertanya		

Skoring KOMPETENSI 3

- **3** = Semua 6 langkah dilakukan

- **2** = 4–5 langkah dilakukan
- **1** = 1–3 langkah dilakukan
- **0** = Tidak melakukan

KOMPETENSI 4. Perilaku Profesional

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1) Sistematis		
2) Menjaga keselamatan bayi		
3) Empati terhadap ibu		
4) Komunikasi jelas dan tenang		
5) Percaya diri		

Skoring KOMPETENSI 4

- **3** = Semua 5 dilakukan
- **2** = 4 dari 5
- **1** = 1–3
- **0** = Tidak melakukan.

TOTAL SKOR DAN KELULUSAN

TOTAL SKOR = TOTAL SKOR = (K1 + K2 + K3 + K4) / 3 *(dicatat di rubrik penilaian)*

IV. Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skore

Nilai akhir = ---------- x 100 =

30

Palembang, ...

.....

Penguji: Hanik Khairun Nisa, S.Tr.Keb.,Bdn., M.Keb

Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Asuhan Bayi Baru Lahir: Pengeringan, IMD, Termoregulasi, dan Perawatan Tali Pusat.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Asuhan Bayi Baru Lahir
Metode penilaian	DOPS merupakan metode penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan prosedural mahasiswa dalam melakukan tindakan klinik secara nyata. Penilai mengamati seluruh proses tindakan mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi, kemudian memberikan umpan balik segera. Domain yang dinilai meliputi informed consent, persiapan, keterampilan teknis, komunikasi, keselamatan pasien, dan profesionalisme.	Pembimbing mengamati secara langsung bagaimana mahasiswa melakukan asuhan bayi baru lahir segera setelah lahir, termasuk pengeringan bayi, pelaksanaan IMD, upaya menjaga kehangatan (termoregulasi), serta perawatan tali pusat sesuai standar.
Tujuan penilaian	Tujuan DOPS pada topik ini adalah menilai kemampuan mahasiswa dalam melakukan asuhan bayi baru lahir secara cepat, tepat, aman, dan berbasis evidence, dengan fokus utama pada pencegahan hipotermia, infeksi, serta keberhasilan menyusui dini. Rekomendasi World Health Organization menekankan pentingnya essential newborn care yang dilakukan segera setelah lahir untuk menurunkan kematian neonatal.	Mahasiswa dinilai tidak hanya dari pengetahuan, tetapi dari kemampuan nyata dalam melakukan pengeringan yang benar, memfasilitasi IMD, menjaga suhu bayi, serta melakukan perawatan tali pusat dengan prinsip bersih dan kering.
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata di lahan praktik yang mencerminkan kebutuhan kompetensi bidan dalam asuhan bayi baru lahir, terutama dalam 1 jam pertama	Seorang bayi lahir spontan, menangis kuat, namun tidak segera dikeringkan secara optimal, IMD belum dilakukan, bayi tampak dingin dengan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Asuhan Bayi Baru Lahir
	kehidupan yang merupakan periode kritis.	suhu 36,2°C, dan tali pusat ditutup dengan kasa lembap.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Mahasiswa diamati saat melakukan tindakan klinik secara langsung, meliputi penilaian awal bayi (napas, warna, tonus), pengeringan bayi, pelaksanaan IMD, menjaga kehangatan bayi, serta perawatan tali pusat. Aktivitas ini harus dilakukan secara sistematis, aman, dan sesuai standar praktik kebidanan.	Mahasiswa memperkenalkan diri, melakukan penilaian kondisi bayi, segera mengeringkan bayi, mengganti kain basah, melakukan skin-to-skin contact, memulai IMD, menjaga kehangatan bayi dengan selimut dan topi, serta melakukan perawatan tali pusat secara aseptik dan dry cord care.
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi ketepatan indikasi tindakan, kemampuan teknis, keselamatan pasien, komunikasi dengan ibu, profesionalisme, serta kemampuan melakukan evaluasi dan tindak lanjut. Dalam konteks neonatal, juga dinilai kemampuan mencegah hipotermia dan infeksi.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu mengidentifikasi bayi berisiko hipotermia, melakukan tindakan yang tepat, serta memberikan edukasi yang benar kepada ibu tentang IMD dan perawatan tali pusat.
Fokus observasi pembimbing	Fokus observasi adalah pada performa nyata mahasiswa dalam melakukan tindakan klinik, termasuk kecepatan, ketepatan, dan urutan tindakan. Penilaian juga mencakup kemampuan mahasiswa dalam menjaga keselamatan bayi dan ibu.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa segera mengeringkan bayi, melakukan IMD tanpa penundaan, menjaga suhu bayi, serta menghindari praktik yang tidak sesuai seperti penggunaan bahan tradisional pada tali pusat.
Umpan balik	Umpan balik diberikan segera setelah tindakan selesai, mencakup aspek yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki. DOPS menekankan refleksi dan	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam menjaga kehangatan bayi, tetapi perlu meningkatkan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Asuhan Bayi Baru Lahir
	perbaikan berkelanjutan melalui feedback langsung dari pembimbing.	kecepatan dalam pengeringan atau ketepatan dalam memulai IMD.
Keputusan penilaian	Hasil penilaian DOPS dikategorikan menjadi kompeten, perlu supervisi, atau remedial, berdasarkan keselamatan tindakan, ketepatan prosedur, dan profesionalisme.	Mahasiswa dinyatakan kompeten jika mampu melakukan seluruh langkah dengan benar dan aman. Perlu supervisi jika masih membutuhkan arahan. Remedial jika tidak mampu melakukan tindakan sesuai standar atau membahayakan bayi.
Makna dalam OBE	DOPS merupakan metode penilaian autentik dalam Outcome-Based Education (OBE) karena menilai performa nyata mahasiswa pada level "does". Penilaian ini memastikan mahasiswa tidak hanya memahami teori tetapi mampu menerapkan keterampilan klinik secara langsung.	Pada asuhan bayi baru lahir, mahasiswa dinilai mampu melakukan tindakan esensial secara langsung, cepat, aman, dan profesional sesuai standar praktik kebidanan.

Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

- OSCE + DOPS
- Catatan kasus singkat
- Refleksi patient safety
- Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

- Bukan sekali ujian
- Bukti konsistensi kompetensi

Tabel. Portofolio pada Asuhan Bayi Baru Lahir: Pengeringan, IMD, Termoregulasi, dan Perawatan Tali Pusat

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Asuhan Bayi Baru Lahir
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menggambarkan perkembangan kompetensi mahasiswa secara bertahap, berkelanjutan, dan autentik. Dalam pendekatan Outcome-Based Education (OBE), portofolio menilai performa nyata mahasiswa dalam praktik klinik, bukan hanya hasil ujian sesaat.	Pada topik asuhan bayi baru lahir, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan pengeringan bayi secara tepat, memfasilitasi IMD, menjaga termoregulasi, serta melakukan perawatan tali pusat sesuai standar, sekaligus menunjukkan peningkatan keterampilan dari waktu ke waktu.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses pembelajaran, pencapaian kompetensi, refleksi diri, serta tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik klinik.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia pernah melakukan asuhan bayi baru lahir, tetapi juga memperlihatkan peningkatan kemampuan dalam melakukan IMD, menjaga suhu bayi, dan mencegah infeksi setelah mendapatkan umpan balik dari pembimbing.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan di laboratorium dan performa nyata di lahan praktik. OSCE menilai keterampilan terstruktur, sedangkan DOPS menilai tindakan langsung di klinik.	OSCE memuat hasil ujian keterampilan pengeringan bayi, IMD, dan perawatan tali pusat. DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa melakukan asuhan bayi baru lahir di ruang bersalin, termasuk menjaga kehangatan bayi dan melakukan perawatan tali pusat.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Asuhan Bayi Baru Lahir
Catatan kasus singkat	Catatan kasus berisi ringkasan kasus pasien yang ditangani mahasiswa, meliputi data penting, masalah kebidanan, tindakan yang dilakukan, dan hasil yang dicapai.	Mahasiswa menuliskan kasus bayi baru lahir yang tidak segera dikeringkan, mengalami hipotermia ringan (suhu 36,2°C), belum dilakukan IMD, serta tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi bayi dan hasil evaluasinya.
Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun strategi pencegahan dalam praktik kebidanan.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya pengeringan segera untuk mencegah hipotermia, pelaksanaan IMD dalam satu jam pertama, menjaga suhu bayi, serta pentingnya perawatan tali pusat yang bersih dan kering untuk mencegah infeksi.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen merupakan bagian penting dalam portofolio untuk menunjukkan pembinaan dan perkembangan kompetensi mahasiswa.	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam melakukan IMD dan komunikasi dengan ibu, tetapi perlu meningkatkan kecepatan pengeringan bayi serta ketelitian dalam menjaga suhu tubuh bayi.
Karakteristik penilaian	Portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang menekankan konsistensi performa mahasiswa dalam berbagai situasi klinik, bukan hanya satu kali tindakan.	Mahasiswa dinilai dari beberapa pengalaman praktik dalam melakukan asuhan bayi baru lahir, sehingga terlihat konsistensi dalam menjaga kehangatan bayi, melakukan IMD, dan perawatan tali pusat.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Asuhan Bayi Baru Lahir
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio menunjukkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa dalam berbagai kesempatan praktik dan waktu yang berbeda.	Dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik, terlihat bahwa mahasiswa konsisten mampu melakukan pengeringan, IMD, dan perawatan tali pusat secara benar dan aman.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dipahami secara teori, tetapi benar-benar diterapkan dalam praktik secara berulang dan berkembang.	Pada topik asuhan bayi baru lahir, portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya memahami konsep, tetapi mampu menerapkannya secara konsisten, aman, dan profesional dalam praktik kebidanan nyata sesuai rekomendasi World Health Organization.

Tabel. Case Report pada Asuhan Bayi Baru Lahir: Pengeringan, IMD, Termoregulasi, dan Perawatan Tali Pusat

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Asuhan Bayi Baru Lahir
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat, sistematis, dan ilmiah mengenai satu kasus klinik yang ditangani mahasiswa selama praktik. Dalam pendekatan Outcome-Based Education (OBE), case report menjadi bukti kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan teori dan praktik klinik secara nyata.	Mahasiswa menyusun laporan tentang bayi baru lahir cukup bulan yang tidak segera dikeringkan, tidak dilakukan IMD, mengalami hipotermia ringan, dan perawatan tali pusat yang tidak sesuai standar.
Tujuan	Case report bertujuan menilai kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, analisis masalah, perencanaan, implementasi, dan evaluasi asuhan kebidanan secara komprehensif.	Mahasiswa tidak hanya mencatat kondisi bayi, tetapi juga menjelaskan masalah utama (hipotermia dan IMD tidak adekuat), tindakan yang dilakukan, serta hasil setelah intervensi.
Isi laporan	Isi case report mencakup identitas pasien, keluhan/masalah, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis kebidanan, rencana tindakan, implementasi, evaluasi, serta pembelajaran yang diperoleh.	Mahasiswa menuliskan bayi lahir spontan, tidak segera dikeringkan, suhu 36,2°C, belum menyusu, tali pusat ditutup kasa lembap, analisis hipotermia ringan, tindakan penghangatan dan IMD, serta evaluasi suhu bayi setelah intervensi.
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, ketajaman analisis masalah, logika clinical reasoning, ketepatan tindakan, serta kemampuan mengevaluasi hasil asuhan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan keterlambatan pengeringan dengan hipotermia, tidak dilakukan IMD dengan kegagalan menyusu, serta kesalahan perawatan tali pusat dengan risiko infeksi.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Asuhan Bayi Baru Lahir
Nilai edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan berpikir klinis, dokumentasi ilmiah, serta refleksi terhadap praktik kebidanan yang telah dilakukan.	Mahasiswa belajar bahwa pengeringan cepat, IMD, dan termoregulasi merupakan tindakan sederhana namun sangat penting dalam mencegah komplikasi neonatal.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam praktik klinik secara sistematis, logis, dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep asuhan bayi baru lahir, tetapi mampu mendokumentasikan dan menganalisis kasus secara profesional sesuai standar World Health Organization.

Tabel. Refleksi Patient Safety pada Asuhan Bayi Baru Lahir: Pengeringan, IMD, Termoregulasi, dan Perawatan Tali Pusat

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Asuhan Bayi Baru Lahir
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan yang menggambarkan kemampuan mahasiswa dalam mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, serta merencanakan langkah pencegahan.	Mahasiswa merefleksikan bahwa keterlambatan pengeringan bayi dapat menyebabkan hipotermia yang berisiko meningkatkan morbiditas neonatal.
Tujuan	Refleksi bertujuan meningkatkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan prioritas utama dalam setiap tindakan kebidanan.	Mahasiswa memahami bahwa tindakan sederhana seperti tidak segera mengeringkan bayi atau tidak melakukan IMD dapat berdampak serius pada kondisi bayi.
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama meliputi

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Asuhan Bayi Baru Lahir
	pencegahan, serta pembelajaran dari pengalaman klinik.	hipotermia, kegagalan menyusu dini, dan infeksi tali pusat akibat perawatan yang tidak sesuai standar.
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa harus mampu mengenali kondisi yang berpotensi membahayakan pasien.	Risiko yang diidentifikasi antara lain keterlambatan pengeringan, tidak dilakukan IMD, kehilangan panas melalui lingkungan, penggunaan kasa lembap pada tali pusat, serta praktik tradisional yang tidak aman.
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa menuliskan pentingnya pengeringan segera (<30 detik), pelaksanaan IMD, menjaga kehangatan bayi, penggunaan topi dan selimut, serta perawatan tali pusat dengan metode dry cord care sesuai rekomendasi World Health Organization.
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan pemahaman yang diperoleh dan bagaimana hal tersebut akan memengaruhi praktik selanjutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa tindakan awal pada bayi baru lahir harus dilakukan cepat, tepat, dan sistematis untuk mencegah komplikasi yang sebenarnya dapat dicegah.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi patient safety menunjukkan perkembangan sikap profesional, tanggung jawab klinik, serta kemampuan berpikir kritis mahasiswa.	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya melakukan tindakan, tetapi juga mampu mengevaluasi risiko dan meningkatkan kualitas asuhan kebidanan secara berkelanjutan.

E. Ringkasan

Asuhan bayi baru lahir merupakan rangkaian intervensi esensial yang dilakukan segera setelah kelahiran untuk memastikan keberlangsungan hidup bayi serta mendukung proses adaptasi dari kehidupan intrauterin ke ekstrauterin. Periode satu jam pertama kehidupan (the golden hour) merupakan fase kritis yang menentukan stabilitas fisiologis bayi, sehingga setiap tindakan harus dilakukan secara cepat, tepat, dan berbasis evidence. Intervensi utama meliputi pengeringan segera, inisiasi menyusu dini (IMD), menjaga termoregulasi, serta perawatan tali pusat yang bersih dan aman. Rekomendasi World Health Organization menegaskan bahwa intervensi sederhana ini terbukti efektif menurunkan angka morbiditas dan mortalitas neonatal secara signifikan.

Pengeringan bayi merupakan tindakan awal yang sangat penting karena bayi baru lahir kehilangan panas terutama melalui evaporasi akibat cairan ketuban yang melekat pada tubuh. Oleh karena itu, bayi harus segera dikeringkan dalam waktu kurang dari 30 detik menggunakan kain bersih dan kering, terutama pada bagian kepala dan tubuh, serta segera mengganti kain yang basah dengan kain kering. Verniks kaseosa tidak perlu dibersihkan secara berlebihan karena memiliki fungsi protektif terhadap infeksi dan membantu mempertahankan suhu tubuh bayi. Keterlambatan pengeringan dapat menyebabkan hipotermia, yang berisiko meningkatkan gangguan metabolik, infeksi, bahkan kematian neonatal.

Setelah pengeringan, bayi harus segera dilakukan kontak kulit dengan ibu (skin-to-skin contact) sebagai bagian dari pelaksanaan IMD. IMD merupakan proses alami di mana bayi diletakkan di dada ibu dan dibiarkan mencari puting susu sendiri dalam satu jam pertama kehidupan. Praktik ini terbukti meningkatkan keberhasilan pemberian ASI eksklusif, menstabilkan suhu tubuh, denyut jantung, dan pernapasan bayi, serta memperkuat ikatan emosional ibu dan bayi. Bayi yang tidak mendapatkan IMD berisiko lebih tinggi mengalami kesulitan menyusu, hipotermia, dan gangguan adaptasi awal kehidupan.

Termoregulasi merupakan aspek krusial dalam asuhan bayi baru lahir karena sistem pengaturan suhu bayi belum matang. Bayi sangat rentan mengalami hipotermia jika tidak dijaga dengan baik, terutama di lingkungan yang dingin atau jika terdapat keterlambatan dalam tindakan awal. Upaya menjaga suhu tubuh bayi meliputi pengeringan segera, kontak kulit dengan ibu, penggunaan selimut dan topi, serta memastikan lingkungan tetap hangat (≥25°C). Selain itu, penundaan mandi minimal 24 jam setelah lahir dianjurkan untuk mencegah kehilangan panas yang berlebihan. Hipotermia dapat berdampak pada gangguan metabolisme, hipoglikemia, serta meningkatkan risiko infeksi.

Perawatan tali pusat merupakan bagian penting dalam mencegah infeksi neonatal, khususnya omfalitis yang dapat berkembang menjadi sepsis. Tali pusat harus dipotong dengan alat steril dan dirawat dengan prinsip bersih dan kering (dry cord care), yaitu tidak menutup dengan bahan lembap serta tidak memberikan zat tradisional atau antiseptik yang tidak direkomendasikan. Pada kondisi tertentu dengan risiko infeksi tinggi, penggunaan antiseptik seperti klorheksidin dapat dipertimbangkan sesuai pedoman. Perawatan yang tidak tepat dapat meningkatkan risiko infeksi serius yang berpotensi mengancam nyawa bayi.

Secara keseluruhan, asuhan bayi baru lahir berfokus pada pencegahan hipotermia, infeksi, serta mendukung keberhasilan menyusui dan adaptasi fisiologis bayi. Bidan harus melakukan penilaian cepat terhadap kondisi bayi (napas, warna, tonus), melakukan intervensi esensial secara sistematis, serta memberikan edukasi kepada ibu dan keluarga. Dokumentasi yang lengkap dan akurat juga menjadi bagian penting dalam menjamin kesinambungan asuhan.

Alur asuhan singkat

Bayi lahir → nilai cepat kondisi bayi (napas, warna, tonus) → segera lakukan pengeringan → lakukan kontak kulit dengan ibu (IMD) → jaga kehangatan bayi (selimut, topi, lingkungan hangat) → lakukan perawatan tali pusat bersih dan kering → observasi kondisi bayi → edukasi ibu dan keluarga → dokumentasi lengkap.

Tabel Red Flags & Eskalasi

Asuhan Bayi Baru Lahir: Pengeringan, IMD, Termoregulasi, dan Perawatan Tali Pusat

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Bayi tidak segera menangis atau napas tidak adekuat	Menunjukkan gangguan adaptasi pernapasan atau kemungkinan asfiksia neonatal	Lakukan penilaian cepat, buka jalan napas, lakukan resusitasi sesuai protokol, panggil bantuan segera
Bayi tampak basah dan tidak segera dikeringkan	Risiko tinggi kehilangan panas melalui evaporasi yang dapat menyebabkan hipotermia	Segera keringkan bayi (<30 detik), ganti kain basah, lanjutkan dengan upaya menjaga kehangatan
Suhu bayi <36,5°C	Hipotermia neonatal yang dapat meningkatkan risiko morbiditas dan mortalitas	Lakukan penghangatan segera (skin-to-skin, selimut, topi), pantau suhu, evaluasi ulang

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Bayi tidak dilakukan IMD dalam 1 jam pertama	Risiko kegagalan menyusui dini dan gangguan adaptasi fisiologis	Segera lakukan skin-to-skin contact dan fasilitasi IMD, edukasi ibu
Bayi tidak menunjukkan refleks menyusu	Kemungkinan gangguan adaptasi atau kondisi klinis tertentu	Evaluasi kondisi bayi, bantu pelekatan, pertimbangkan kolaborasi jika menetap
Bayi tampak pucat, sianosis, atau lemah	Tanda gangguan oksigenasi atau kondisi serius	Nilai cepat kondisi bayi, pantau tanda vital, siapkan rujukan jika diperlukan
Lingkungan dingin atau bayi tidak diselimuti/topi	Risiko kehilangan panas melalui konveksi dan radiasi	Pastikan lingkungan hangat (≥25°C), gunakan selimut dan topi
Tali pusat lembap, kotor, atau ditutup kasa basah	Risiko infeksi tali pusat (omfalitis)	Lakukan perawatan tali pusat bersih dan kering (dry cord care), edukasi ibu
Tali pusat berbau, kemerahan, atau keluar cairan	Tanda infeksi lokal yang berpotensi berkembang menjadi sepsis	Lapor segera, evaluasi lebih lanjut, rujuk jika ada tanda infeksi sistemik
Penggunaan bahan tradisional pada tali pusat	Risiko kontaminasi dan infeksi neonatal	Edukasi ibu/keluarga, hentikan praktik, lakukan perawatan sesuai standar
Bayi tampak tidak aktif atau letargis	Indikasi kondisi serius seperti hipotermia, hipoglikemia, atau infeksi	Nilai kondisi menyeluruh, stabilisasi awal, kolaborasi/rujukan segera
Bayi muntah berulang atau tidak mau menyusu	Gangguan adaptasi atau masalah metabolik	Evaluasi kondisi bayi, pantau ketat, pertimbangkan rujukan
Tidak dilakukan observasi pasca tindakan	Risiko keterlambatan deteksi komplikasi	Lakukan pemantauan berkala (suhu, napas, warna, menyusu)
Dokumentasi tidak lengkap	Mengganggu kesinambungan asuhan dan keselamatan pasien	Lengkapi pencatatan segera sesuai standar

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Kondisi bayi memburuk meskipun sudah dilakukan tindakan awal	Menunjukkan kegagalan stabilisasi awal	Segera eskalasi, kolaborasi dengan dokter, siapkan rujukan

Form Checklist “Saya sudah bisa…”

Bab: Asuhan Bayi Baru Lahir – Pengeringan, IMD, Termoregulasi, dan Perawatan Tali Pusat

Nama Mahasiswa: _____

NIM: _____

Tanggal: _____

Tempat Praktik / Skill Lab: _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan konsep asuhan bayi baru lahir esensial	☐	☐	_____
2	Saya sudah bisa menjelaskan pentingnya pengeringan segera setelah bayi lahir	☐	☐	_____
3	Saya sudah bisa melakukan pengeringan bayi dengan benar (<30 detik)	☐	☐	_____
4	Saya sudah bisa mengganti kain basah dengan kain kering dengan cepat dan tepat	☐	☐	_____
5	Saya sudah bisa menjelaskan manfaat verniks kaseosa dan tidak menghilangkannya secara berlebihan	☐	☐	_____
6	Saya sudah bisa menjelaskan konsep dan manfaat IMD	☐	☐	_____
7	Saya sudah bisa melakukan skin-to-skin contact dengan benar	☐	☐	_____
8	Saya sudah bisa memfasilitasi bayi melakukan IMD dalam 1 jam pertama	☐	☐	_____
9	Saya sudah bisa menilai refleks menyusu dan pelekatan bayi	☐	☐	_____
10	Saya sudah bisa menjelaskan konsep termoregulasi pada bayi baru lahir	☐	☐	_____
11	Saya sudah bisa menjaga kehangatan bayi (selimut, topi, lingkungan hangat)	☐	☐	_____
12	Saya sudah bisa mengidentifikasi tanda hipotermia pada bayi	☐	☐	_____
13	Saya sudah bisa melakukan tindakan awal pada bayi dengan hipotermia	☐	☐	_____

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
14	Saya sudah bisa menjelaskan prinsip perawatan tali pusat bersih dan kering (dry cord care)	☐	☐	_____
15	Saya sudah bisa melakukan perawatan tali pusat dengan teknik yang benar dan aman	☐	☐	_____
16	Saya sudah bisa mengidentifikasi tanda infeksi tali pusat (omfalitis)	☐	☐	_____
17	Saya sudah bisa menjelaskan kepada ibu tentang perawatan tali pusat di rumah	☐	☐	_____
18	Saya sudah bisa melakukan penilaian awal bayi (napas, warna, tonus)	☐	☐	_____
19	Saya sudah bisa memberikan edukasi kepada ibu tentang IMD dan menjaga kehangatan bayi	☐	☐	_____
20	Saya sudah bisa melakukan observasi lanjutan kondisi bayi setelah tindakan	☐	☐	_____
21	Saya sudah bisa mendokumentasikan tindakan dan hasil asuhan bayi baru lahir	☐	☐	_____
22	Saya sudah bisa menjaga keselamatan bayi selama tindakan	☐	☐	_____
23	Saya sudah bisa menunjukkan komunikasi yang baik dan empati kepada ibu	☐	☐	_____
24	Saya sudah bisa bertindak sistematis dan profesional dalam asuhan bayi baru lahir	☐	☐	_____

Refleksi singkat mahasiswa:

F. Daftar Pustaka

American Academy of Pediatrics. (2022). Guidelines for perinatal care (8th ed.). Elk Grove Village, IL: Author.

Bhutta, Z. A., Das, J. K., Bahl, R., Lawn, J. E., Salam, R. A., Paul, V. K., … Lancet Newborn Interventions Review Group. (2014). Can available interventions end preventable deaths in mothers, newborn babies, and stillbirths? The Lancet, 384(9940), 347–370. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)60792-3

Boundy, E. O., Dastjerdi, R., Spiegelman, D., Fawzi, W. W., Missmer, S. A., Lieberman, E., … Chan, G. J. (2016). Kangaroo mother care and neonatal outcomes: A meta-analysis. Pediatrics, 137(1), e20152238. https://doi.org/10.1542/peds.2015-2238

Edmond, K. M., Zandoh, C., Quigley, M. A., Amenga-Etego, S., Owusu-Agyei, S., & Kirkwood, B. R. (2006). Delayed breastfeeding initiation increases risk of neonatal mortality. Pediatrics, 117(3), e380–e386. https://doi.org/10.1542/peds.2005-1496

Imdad, A., Bautista, R. M. M., Senen, K. A., Uy, M. E. V., Mantaring, J. B., & Bhutta, Z. A. (2013). Umbilical cord antiseptics for preventing sepsis and death among newborns. BMC Public Health, 13(Suppl 3), S15. https://doi.org/10.1186/1471-2458-13-S3-S15

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Standar profesi bidan. Jakarta: Kemenkes RI.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Standar kompetensi kerja bidang kebidanan. Jakarta: Kemenkes RI.

Lunze, K., & Hamer, D. H. (2012). Thermal protection of the newborn in resource-limited environments. Journal of Perinatology, 32(5), 317–324. https://doi.org/10.1038/jp.2012.11

McCall, E. M., Alderdice, F., Halliday, H. L., Jenkins, J. G., & Vohra, S. (2018). Interventions to prevent hypothermia at birth in preterm and/or low birth weight infants. Cochrane Database of Systematic Reviews, (2), CD004210. https://doi.org/10.1002/14651858.CD004210.pub5

Moore, E. R., Bergman, N., Anderson, G. C., & Medley, N. (2016). Early skin-to-skin contact for mothers and their healthy newborn infants. Cochrane Database of Systematic Reviews, (11), CD003519. https://doi.org/10.1002/14651858.CD003519.pub4

Sankar, M. J., Natarajan, C. K., Das, R. R., Agarwal, R., Chandrasekaran, A., & Paul, V. K. (2016). When do newborns die? A systematic review of timing of overall and

cause-specific neonatal deaths. PLOS ONE, 11(10), e0162915. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0162915

World Health Organization. (2013). Postnatal care of the mother and newborn. Geneva: WHO.

World Health Organization. (2017). Protecting, promoting and supporting breastfeeding in facilities providing maternity and newborn services. Geneva: WHO.

World Health Organization. (2023). WHO recommendations on essential newborn care. Geneva: WHO.

BAB 3

RESUSITASI DASAR BAYI BARU LAHIR: PERSIAPAN, VENTILASI, DAN EVALUASI

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- CPL 1. Menguasai konsep teoritis mengenai fisiologi adaptasi bayi baru lahir, sistem pernapasan neonatal, serta prinsip dasar resusitasi bayi baru lahir.
- CPL 2. Mampu melakukan pengkajian kondisi bayi baru lahir secara sistematis untuk menentukan kebutuhan asuhan rutin, stabilisasi, atau resusitasi.
- CPL 3. Mampu menerapkan keterampilan klinis dasar dalam persiapan dan pelaksanaan resusitasi bayi baru lahir sesuai standar pelayanan dan kewenangan profesi bidan.
- CPL 4. Mampu melakukan Ventilasi Tekanan Positif pada bayi baru lahir secara tepat dengan memperhatikan posisi jalan napas, ukuran dan pemasangan sungkup, frekuensi ventilasi, serta respons bayi.
- CPL 5. Mampu melakukan evaluasi terhadap respons bayi selama dan setelah tindakan resusitasi serta menentukan kebutuhan tindak lanjut, kolaborasi, atau rujukan.
- CPL 6. Mampu menerapkan prinsip keselamatan pasien, pencegahan dan pengendalian infeksi, komunikasi efektif, dokumentasi, serta kerja sama tim dalam tindakan resusitasi bayi baru lahir.
- CPL 7. Mampu menunjukkan sikap profesional, teliti, responsif, dan bertanggung jawab dalam menghadapi kondisi kegawatdaruratan pada bayi baru lahir dengan tetap bekerja sesuai kewenangan profesi.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah mempelajari topik ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- CPMK 1. Menjelaskan proses adaptasi pernapasan dan sirkulasi bayi setelah lahir sebagai dasar pemahaman resusitasi bayi baru lahir.
- CPMK 2. Menjelaskan tujuan, prinsip, dan prioritas tindakan dalam resusitasi dasar bayi baru lahir.
- CPMK 3. Mengidentifikasi faktor maternal, fetal, dan intrapartum yang dapat meningkatkan kemungkinan bayi membutuhkan resusitasi.

- CPMK 4. Menyiapkan lingkungan, alat, bahan, serta anggota tim yang diperlukan untuk melakukan resusitasi bayi baru lahir.
- CPMK 5. Melakukan penilaian awal terhadap kondisi bayi segera setelah lahir berdasarkan pernapasan, tonus, dan denyut jantung sesuai kebutuhan klinis.
- CPMK 6. Menjelaskan dan melakukan langkah awal resusitasi secara sistematis, meliputi menjaga kehangatan, memposisikan jalan napas, mengeringkan, memberikan stimulasi yang sesuai, dan menilai kembali kondisi bayi.
- CPMK 7. Menentukan indikasi pemberian Ventilasi Tekanan Positif pada bayi baru lahir.
- CPMK 8. Melakukan Ventilasi Tekanan Positif dengan sungkup secara efektif sesuai prinsip keselamatan neonatal.
- CPMK 9. Mengenali tanda ventilasi yang efektif maupun tidak efektif dan melakukan langkah koreksi awal apabila ventilasi belum menghasilkan respons yang diharapkan.
- CPMK 10. Mengevaluasi respons bayi berdasarkan pernapasan, denyut jantung, pergerakan dada, dan parameter klinis lainnya.
- CPMK 11. Menentukan kebutuhan pemantauan lanjutan, kolaborasi, stabilisasi, atau rujukan setelah resusitasi.
- CPMK 12. Melakukan komunikasi dengan keluarga, dokumentasi tindakan, serta pelaporan hasil resusitasi secara profesional.

Pendahuluan

Peralihan kehidupan dari intrauterin ke ekstrauterin merupakan salah satu proses fisiologis paling penting yang dialami bayi. Setelah lahir, bayi harus mampu melakukan adaptasi respirasi, sirkulasi, dan termoregulasi dalam waktu relatif singkat. Sebagian besar bayi dapat memulai pernapasan spontan tanpa bantuan khusus, tetapi sebagian bayi membutuhkan bantuan untuk memulai atau mempertahankan pernapasan. Pada kondisi tersebut, pengenalan masalah secara cepat dan pelaksanaan resusitasi yang efektif menjadi bagian penting dalam menjaga keselamatan bayi baru lahir.

Resusitasi bayi baru lahir merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan untuk membantu bayi yang mengalami gangguan adaptasi setelah lahir, terutama ketika bayi tidak bernapas, mengalami gasping, atau menunjukkan tanda bahwa ventilasi tidak adekuat. Prinsip utama resusitasi neonatal berbeda dengan resusitasi pada kelompok usia lain karena pada bayi baru lahir gangguan denyut jantung paling sering berkaitan dengan kegagalan pertukaran gas dan inflasi paru. Oleh sebab itu, ventilasi paru yang efektif merupakan tindakan utama dalam resusitasi bayi baru lahir. Peningkatan frekuensi denyut jantung setelah ventilasi merupakan salah satu indikator penting bahwa ventilasi telah efektif.

Keberhasilan resusitasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan melakukan ventilasi. Persiapan sebelum kelahiran memiliki peran yang sama pentingnya. Penolong perlu memperkirakan kemungkinan kebutuhan resusitasi berdasarkan kondisi ibu, janin, proses persalinan, dan usia gestasi; memastikan kesiapan tempat, alat, serta sumber daya manusia; membagi peran anggota tim; dan memeriksa fungsi peralatan sebelum bayi lahir. Setiap pelayanan persalinan perlu memiliki kesiapan untuk melakukan pertolongan awal kepada bayi yang mengalami gangguan pernapasan.

Dalam praktik kebidanan, resusitasi dasar mencakup pengkajian kondisi bayi, langkah awal resusitasi, pemberian Ventilasi Tekanan Positif (VTP), penilaian respons bayi, serta tindak lanjut setelah resusitasi. Pelaksanaannya harus dilakukan sesuai standar, kewenangan, kompetensi, dan sistem rujukan yang berlaku. Standar Kompetensi Kerja Bidang Kebidanan Indonesia menempatkan langkah awal sampai VTP sebagai bagian dari tindakan resusitasi bayi yang dilakukan bidan dalam tim.

Mahasiswa kebidanan perlu memahami bahwa resusitasi bukan sekadar menghafal urutan tindakan. Keterampilan ini membutuhkan kemampuan mengenali bayi yang memerlukan bantuan, menentukan prioritas tindakan, memberikan ventilasi yang efektif, mengevaluasi respons secara cepat, serta mengenali kondisi yang membutuhkan bantuan tim yang lebih kompeten atau rujukan. Ketepatan tindakan dalam menit pertama kehidupan dapat menentukan keberhasilan adaptasi bayi dan keberlanjutan asuhan berikutnya.

Uraian Materi

A. Konsep Dasar dan Persiapan Resusitasi Bayi Baru Lahir

Bayi baru lahir harus melakukan proses adaptasi yang cepat dari kehidupan intrauterin ke ekstrauterin. Selama berada di dalam kandungan, pertukaran gas berlangsung melalui plasenta, sedangkan paru belum berfungsi sebagai organ utama pertukaran oksigen. Setelah lahir, bayi harus mulai bernapas secara spontan, mengembangkan paru, meningkatkan aliran darah pulmonal, dan melakukan perubahan sirkulasi agar kebutuhan oksigen tubuh dapat terpenuhi.

Sebagian besar bayi dapat melakukan proses adaptasi tersebut tanpa bantuan khusus. Namun, sebagian bayi mengalami kesulitan memulai atau mempertahankan pernapasan sehingga memerlukan bantuan resusitasi. Resusitasi bayi baru lahir merupakan serangkaian tindakan yang bertujuan membantu bayi membentuk ventilasi dan oksigenasi yang adekuat serta mempertahankan fungsi vital selama proses transisi setelah kelahiran. Pada resusitasi neonatal, ventilasi yang efektif menjadi tindakan utama karena gangguan denyut jantung pada bayi baru lahir sering berkaitan dengan ventilasi paru dan oksigenasi yang tidak adekuat. Peningkatan denyut jantung merupakan salah satu indikator utama bahwa ventilasi telah efektif.

Kebutuhan resusitasi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari ibu, janin, maupun proses persalinan. Beberapa keadaan seperti prematuritas, gangguan pertumbuhan janin, komplikasi kehamilan, gangguan kondisi janin, infeksi, perdarahan, kehamilan multipel, atau komplikasi selama persalinan dapat meningkatkan kemungkinan bayi membutuhkan bantuan setelah lahir. Meskipun demikian, kebutuhan resusitasi tidak selalu dapat diperkirakan sebelum persalinan. Oleh karena itu, setiap kelahiran perlu dihadapi dengan kesiapan untuk memberikan bantuan napas apabila bayi tidak dapat bernapas secara spontan.

Persiapan resusitasi dimulai sebelum bayi lahir. Penolong perlu melakukan pengkajian terhadap kondisi ibu, kehamilan, janin, serta perjalanan persalinan untuk mengenali kemungkinan risiko. Informasi tersebut digunakan untuk memperkirakan kebutuhan tenaga, alat, dan tingkat pelayanan yang mungkin diperlukan setelah kelahiran. Pada persalinan berisiko tinggi, keberadaan tenaga kesehatan dengan kompetensi resusitasi yang sesuai perlu dipastikan sejak awal.

Lingkungan tempat resusitasi juga harus dipersiapkan dengan baik. Area tindakan perlu bersih, memiliki pencahayaan yang cukup, mudah dijangkau, dan mampu mempertahankan kehangatan bayi. Pencegahan kehilangan panas merupakan bagian penting dalam perawatan bayi baru lahir karena hipotermia dapat memperburuk kondisi bayi. WHO menempatkan perawatan segera setelah

lahir, pengaturan suhu, resusitasi bila diperlukan, pencegahan infeksi, dan pengenalan tanda bahaya sebagai bagian penting dari pelayanan esensial bayi baru lahir.

Peralatan resusitasi harus tersedia dan diperiksa sebelum persalinan. Peralatan dasar meliputi sumber kehangatan, kain bersih dan kering, alat pengukur waktu, stetoskop, alat ventilasi berupa balon dan sungkup dengan ukuran yang sesuai, serta sumber oksigen dan alat pemantauan apabila tersedia. Penolong harus memastikan bahwa alat ventilasi dapat berfungsi dengan baik dan sungkup dapat membentuk penutupan yang adekuat pada wajah bayi.

Selain kesiapan alat, kesiapan tim sangat menentukan keberhasilan resusitasi. Setiap anggota tim perlu mengetahui perannya, termasuk siapa yang melakukan penilaian awal, memberikan ventilasi, memantau kondisi bayi, mencatat waktu dan tindakan, serta menghubungi tenaga lain apabila diperlukan. Komunikasi yang jelas dan pembagian tugas sebelum kelahiran membantu mengurangi keterlambatan tindakan ketika bayi membutuhkan resusitasi.

B. Penilaian Awal dan Langkah Awal Resusitasi

Penilaian awal bayi dilakukan segera setelah lahir untuk menentukan apakah bayi dapat melanjutkan proses adaptasi secara fisiologis atau memerlukan bantuan resusitasi. Penilaian harus dilakukan secara cepat dan sistematis karena kondisi bayi dapat berubah dalam waktu singkat. Fokus utama penilaian adalah kemampuan bernapas atau menangis, tonus otot, serta kondisi umum bayi. Pada bayi yang memerlukan tindakan resusitasi, denyut jantung menjadi parameter penting untuk menentukan kebutuhan tindakan selanjutnya dan menilai respons terhadap intervensi.

Bayi yang bernapas atau menangis dengan baik dan memiliki tonus otot yang baik umumnya dapat melanjutkan perawatan rutin dengan menjaga kehangatan dan melakukan kontak kulit dengan ibu apabila kondisi ibu dan bayi memungkinkan. Sebaliknya, bayi yang tidak bernapas, mengalami gasping, menunjukkan usaha napas yang tidak efektif, atau memiliki tonus yang buruk memerlukan penilaian dan tindakan segera. Pedoman resusitasi neonatal menekankan penilaian pernapasan dan tonus sebagai bagian penting dari evaluasi awal bayi baru lahir.

Denyut jantung merupakan salah satu indikator penting dalam resusitasi bayi baru lahir. Penilaian awal dapat dilakukan melalui auskultasi daerah prekordium. Pada bayi yang membutuhkan resusitasi lebih lanjut, pulse oximetry atau elektrokardiografi dapat digunakan sebagai alat tambahan apabila tersedia. Perubahan denyut jantung selama resusitasi membantu penolong menilai apakah tindakan yang diberikan telah menghasilkan ventilasi dan oksigenasi yang adekuat.

Apabila bayi membutuhkan bantuan, langkah awal resusitasi dilakukan dengan menjaga kehangatan, memposisikan kepala untuk membuka jalan napas, mengeringkan tubuh, memberikan stimulasi taktil yang sesuai, serta menilai kembali pernapasan dan kondisi bayi. Tindakan tersebut perlu dilakukan secara cepat agar pemberian ventilasi tidak tertunda apabila bayi tetap tidak bernapas atau mengalami gasping.

Menjaga kehangatan merupakan bagian penting dari langkah awal resusitasi. Bayi yang membutuhkan resusitasi dapat ditempatkan pada permukaan yang hangat atau di bawah radiant warmer, kemudian dikeringkan menggunakan kain bersih dan kering. Kain yang telah basah perlu diganti untuk mengurangi kehilangan panas. Pencegahan hipotermia penting karena suhu tubuh yang tidak stabil dapat memperburuk kondisi bayi dan mengganggu proses adaptasi setelah kelahiran. WHO memasukkan perawatan termal dan resusitasi bila diperlukan sebagai bagian dari perawatan esensial segera setelah lahir.

Posisi kepala bayi perlu diperhatikan agar jalan napas tetap terbuka. Kepala diposisikan secara netral atau sedikit ekstensi sehingga udara dapat masuk dengan baik. Fleksi atau ekstensi yang berlebihan dapat menghambat jalan napas dan menurunkan efektivitas bantuan pernapasan. Selama tindakan, penolong perlu memastikan posisi bayi tetap stabil dan memungkinkan dilakukannya pengamatan terhadap pernapasan dan gerakan dada.

Mengeringkan bayi juga dapat memberikan stimulasi taktil untuk membantu memicu pernapasan spontan. Apabila diperlukan, stimulasi tambahan dapat diberikan dengan menggosok punggung atau telapak kaki secara lembut. Stimulasi dilakukan secukupnya dan tidak boleh menyebabkan trauma. Apabila setelah stimulasi bayi tetap tidak bernapas atau mengalami gasping, stimulasi berulang tidak boleh menunda pemberian ventilasi.

Pembersihan jalan napas tidak dilakukan secara rutin pada setiap bayi baru lahir. Pengisapan mulut atau hidung hanya dipertimbangkan apabila terdapat sekret atau material yang tampak menghambat jalan napas atau mengganggu ventilasi. Pengisapan yang tidak diperlukan dapat menyebabkan bradikardia, apnea, desaturasi, cedera jalan napas, serta menunda pemberian ventilasi. Hal ini juga berlaku pada cairan ketuban bercampur mekonium; tindakan pengisapan rutin tidak direkomendasikan apabila tidak terdapat bukti obstruksi jalan napas.

Setelah langkah awal dilakukan, kondisi bayi harus segera dinilai kembali. Penolong memperhatikan apakah bayi telah bernapas atau menangis secara efektif, bagaimana tonusnya, serta menilai denyut jantung pada bayi yang membutuhkan resusitasi. Apabila bayi mulai bernapas dengan baik dan kondisi stabil, perawatan dapat dilanjutkan dengan pemantauan. Sebaliknya, apabila bayi tetap apnea,

mengalami gasping, atau menunjukkan tanda ventilasi yang tidak adekuat, penolong harus segera melanjutkan ke bantuan ventilasi sesuai indikasi.

C. Ventilasi Tekanan Positif pada Bayi Baru Lahir

Ventilasi Tekanan Positif (VTP) merupakan tindakan utama dalam resusitasi bayi baru lahir yang mengalami gangguan pernapasan. Tujuan VTP adalah membantu mengembangkan paru dan menghasilkan pertukaran gas yang adekuat sehingga oksigen dapat mencapai jaringan tubuh. Pada bayi baru lahir yang membutuhkan resusitasi, keberhasilan ventilasi menjadi prioritas karena peningkatan denyut jantung sangat bergantung pada terbentuknya ventilasi paru yang efektif. Peningkatan denyut jantung setelah pemberian ventilasi merupakan indikator utama bahwa tindakan yang dilakukan memberikan respons yang baik.

VTP diberikan apabila bayi mengalami apnea, gasping, atau denyut jantung tetap kurang dari 100 kali per menit setelah langkah awal resusitasi dilakukan dengan benar. Pada kondisi tersebut, ventilasi tidak boleh tertunda karena keterlambatan bantuan napas dapat memperburuk hipoksia. Pedoman resusitasi neonatal AHA/AAP 2025 merekomendasikan agar ventilasi diberikan dalam 60 detik pertama setelah lahir pada bayi yang tetap apnea, gasping, atau mengalami bradikardia persisten setelah langkah awal.

Sebelum memberikan ventilasi, bayi diposisikan terlentang dengan kepala dalam posisi netral atau sedikit ekstensi sehingga jalan napas tetap terbuka. Posisi kepala yang terlalu fleksi dapat menyebabkan jalan napas terhalang, sedangkan ekstensi yang berlebihan juga dapat mengganggu masuknya udara. Oleh karena itu, penolong perlu memastikan posisi kepala dan leher tetap sesuai selama pemberian ventilasi.

Pemilihan ukuran sungkup juga menentukan keberhasilan VTP. Sungkup harus sesuai dengan ukuran wajah bayi dan menutupi hidung, mulut, serta dagu tanpa menutupi mata. Sungkup yang terlalu kecil tidak dapat menutup mulut dan hidung dengan baik, sedangkan sungkup yang terlalu besar dapat menutupi mata dan menghasilkan kebocoran. Setelah sungkup ditempatkan, penolong perlu membentuk segel yang baik antara sungkup dan wajah agar tekanan yang diberikan dapat masuk ke paru secara efektif.

Ventilasi diberikan menggunakan perangkat ventilasi neonatal yang sesuai dengan cara memberikan tekanan secara teratur. Pedoman AHA/AAP 2025 menyebutkan bahwa frekuensi ventilasi sekitar 30–60 kali per menit dapat digunakan pada bayi baru lahir yang tidak bernapas secara efektif. Tekanan inflasi awal sekitar 20–30 cmH_2O dapat digunakan apabila perangkat memungkinkan pemantauan tekanan, kemudian disesuaikan berdasarkan respons bayi. Tekanan

yang berlebihan perlu dihindari karena dapat menyebabkan volume udara yang terlalu besar dan meningkatkan risiko cedera paru.

Selama pemberian VTP, penolong perlu memperhatikan pergerakan dada bayi. Dada seharusnya menunjukkan gerakan yang lembut sesuai dengan setiap inflasi. Namun, pergerakan dada bukan satu-satunya indikator keberhasilan ventilasi. Peningkatan denyut jantung merupakan indikator utama ventilasi yang efektif, sedangkan munculnya pernapasan spontan atau tangisan juga menunjukkan adanya perbaikan. Ventilasi yang menghasilkan gerakan dada berlebihan perlu dihindari karena dapat menunjukkan pemberian tekanan atau volume yang terlalu besar.

Apabila dada tidak bergerak atau denyut jantung tidak menunjukkan peningkatan, penolong perlu mempertimbangkan bahwa ventilasi mungkin belum efektif. Penyebab yang sering terjadi antara lain posisi kepala yang kurang tepat, kebocoran pada sungkup, obstruksi jalan napas, atau tekanan ventilasi yang tidak mencukupi. Langkah koreksi dapat dilakukan dengan memperbaiki posisi kepala, menyesuaikan kembali pemasangan sungkup, memastikan jalan napas terbuka, dan menyesuaikan tekanan secara hati-hati. Kebocoran sungkup dan obstruksi jalan napas merupakan masalah yang perlu segera dikoreksi agar ventilasi dapat mencapai paru.

Penggunaan oksigen selama VTP perlu disesuaikan dengan usia gestasi dan kondisi bayi. Pada bayi cukup bulan dan bayi dengan usia gestasi 35 minggu atau lebih yang membutuhkan ventilasi, resusitasi umumnya dapat dimulai dengan udara ruangan yang mengandung sekitar 21% oksigen. Selanjutnya, konsentrasi oksigen dapat disesuaikan berdasarkan respons klinis dan hasil pemantauan saturasi apabila pulse oximeter tersedia. Penggunaan konsentrasi oksigen tinggi secara rutin tanpa indikasi perlu dihindari karena paparan oksigen berlebihan juga dapat menimbulkan efek yang tidak diinginkan.

Pada bayi prematur, kebutuhan oksigen memerlukan perhatian khusus karena kelompok ini lebih rentan terhadap efek hipoksia maupun hiperoksia. Oleh karena itu, konsentrasi oksigen diberikan dan disesuaikan secara hati-hati berdasarkan kondisi klinis dan pemantauan saturasi. Jika dilakukan pemantauan saturasi preduktal, sensor pulse oximeter ditempatkan pada tangan atau pergelangan tangan kanan. Saturasi oksigen bayi baru lahir juga tidak langsung sama dengan nilai pada anak yang lebih besar atau orang dewasa karena peningkatan saturasi berlangsung secara bertahap selama beberapa menit setelah lahir.

Keselamatan selama ventilasi perlu diperhatikan sejak persiapan hingga evaluasi. Penolong harus memastikan alat berfungsi dengan baik, ukuran sungkup sesuai, jalan napas terbuka, dan ventilasi diberikan dengan tekanan secukupnya.

Pengisapan jalan napas tidak dilakukan secara rutin dan hanya dipertimbangkan apabila terdapat dugaan obstruksi yang mengganggu ventilasi. Selain itu, suhu tubuh bayi tetap harus dijaga selama resusitasi agar kehilangan panas tidak memperburuk kondisi bayi. WHO menempatkan resusitasi bila diperlukan, perawatan termal, dan pemantauan kondisi bayi sebagai bagian dari pelayanan esensial bayi baru lahir.

VTP merupakan keterampilan yang membutuhkan ketepatan teknik sekaligus kemampuan menilai respons bayi secara terus-menerus. Penolong tidak cukup hanya mampu memberikan tekanan melalui sungkup, tetapi harus memastikan bahwa ventilasi benar-benar menghasilkan pengembangan paru dan peningkatan denyut jantung. Oleh karena itu, pemberian VTP harus selalu diikuti dengan evaluasi terhadap pernapasan, denyut jantung, dan efektivitas ventilasi untuk menentukan apakah bantuan dapat dihentikan, dilanjutkan, dikoreksi, atau memerlukan tindakan lebih lanjut.

D. Evaluasi Respons dan Koreksi Ventilasi

Evaluasi respons merupakan bagian penting setelah pemberian Ventilasi Tekanan Positif (VTP). Penolong tidak hanya memberikan ventilasi, tetapi harus memastikan bahwa udara benar-benar masuk ke paru dan menghasilkan perbaikan kondisi bayi. Penilaian dilakukan secara cepat dan berulang dengan memperhatikan denyut jantung, pernapasan, dan pergerakan dada. Dari ketiga parameter tersebut, peningkatan denyut jantung merupakan indikator utama bahwa ventilasi telah berlangsung efektif.

Setelah ventilasi diberikan secara efektif selama kurang lebih 30 detik dengan bukti adanya pengembangan dada, denyut jantung bayi perlu dinilai kembali. Apabila denyut jantung meningkat dan bayi mulai bernapas spontan atau menangis, hal tersebut menunjukkan respons yang baik terhadap ventilasi. VTP dapat dikurangi dan dihentikan apabila bayi telah mampu mempertahankan pernapasan spontan secara adekuat dan denyut jantung berada dalam kondisi yang stabil. Selanjutnya, bayi tetap memerlukan pemantauan untuk memastikan bahwa kondisi tidak kembali memburuk.

Apabila denyut jantung masih kurang dari 100 kali per menit, penolong perlu melanjutkan ventilasi dan memastikan bahwa VTP yang diberikan benar-benar efektif. Kondisi tersebut tidak selalu berarti bahwa bayi membutuhkan tindakan resusitasi yang lebih lanjut. Penolong terlebih dahulu harus menilai apakah sungkup terpasang dengan baik, jalan napas terbuka, dada bergerak saat ventilasi diberikan, dan tekanan ventilasi telah mencukupi. Pedoman resusitasi neonatal menekankan

bahwa kebocoran sungkup dan obstruksi jalan napas merupakan penyebab yang sering menyebabkan ventilasi tidak efektif.

Pergerakan dada merupakan salah satu tanda bahwa tekanan ventilasi mencapai paru. Dada diharapkan bergerak secara lembut setiap kali ventilasi diberikan. Apabila dada tidak bergerak, kemungkinan terdapat masalah pada teknik ventilasi. Namun, gerakan dada yang sangat besar juga tidak diharapkan karena dapat menunjukkan pemberian tekanan atau volume yang berlebihan. Oleh karena itu, penolong perlu mencapai keseimbangan antara menghasilkan pengembangan paru yang cukup dan menghindari tekanan yang berlebihan.

Koreksi ventilasi dilakukan apabila denyut jantung tidak meningkat atau dada tidak bergerak secara adekuat. Langkah awal yang dapat dilakukan adalah memperbaiki posisi sungkup pada wajah bayi sehingga terbentuk segel yang baik. Selanjutnya, posisi kepala dievaluasi kembali agar berada dalam posisi netral atau sedikit ekstensi sehingga jalan napas tetap terbuka. Jika terdapat dugaan sekret yang menghambat jalan napas, pembersihan jalan napas dapat dilakukan sesuai indikasi.

Penolong juga perlu memastikan bahwa mulut bayi tidak tertutup rapat dan bahwa tekanan yang diberikan melalui alat ventilasi telah mencukupi untuk menghasilkan pengembangan dada. Apabila tekanan masih tidak menghasilkan pergerakan dada, tekanan dapat disesuaikan secara bertahap dengan tetap memperhatikan keselamatan bayi. Pedoman AHA/AAP 2025 memasukkan reposisi jalan napas, penyesuaian sungkup, pengisapan bila terdapat obstruksi, peningkatan tekanan inflasi secara hati-hati, serta penggunaan jalan napas alternatif sebagai bagian dari langkah koreksi ketika ventilasi dengan sungkup belum efektif.

Setelah koreksi dilakukan, ventilasi kembali diberikan dan respons bayi dinilai. Peningkatan denyut jantung menunjukkan bahwa koreksi telah meningkatkan efektivitas ventilasi. Apabila bayi mulai bernapas spontan dengan baik dan denyut jantung mencapai atau melebihi 100 kali per menit, bantuan ventilasi dapat dihentikan secara bertahap sambil tetap memantau pola pernapasan, warna, tonus, suhu, dan kondisi umum bayi.

Sebaliknya, apabila denyut jantung berada antara 60–99 kali per menit, ventilasi efektif harus tetap dilanjutkan dan penyebab ventilasi yang belum optimal perlu terus dievaluasi. Penolong harus menghindari berpindah terlalu cepat ke tindakan lain sebelum memastikan paru telah diventilasi dengan baik, karena pada bayi baru lahir bradikardia paling sering berkaitan dengan pertukaran gas dan inflasi paru yang tidak adekuat.

Apabila denyut jantung tetap kurang dari 60 kali per menit setelah sekitar 30 detik ventilasi yang benar-benar efektif dan menghasilkan pergerakan dada, kondisi

tersebut menunjukkan kegawatan yang membutuhkan resusitasi lanjutan. Pedoman AHA/AAP 2025 merekomendasikan kompresi dada apabila denyut jantung tetap kurang dari 60 kali per menit meskipun telah diberikan ventilasi yang mengembangkan paru secara efektif.

Dalam konteks keterampilan dasar kebidanan, mahasiswa perlu mampu mengenali kondisi tersebut sebagai tanda perlunya eskalasi tindakan. Bidan perlu mempertahankan bantuan ventilasi yang efektif, segera memanggil tenaga atau tim dengan kompetensi resusitasi lanjutan, menyiapkan peralatan yang diperlukan, serta melakukan kolaborasi sesuai kemampuan fasilitas. Apabila fasilitas tidak memiliki kemampuan penanganan lanjutan, stabilisasi awal dan persiapan rujukan perlu dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.

Evaluasi tidak hanya dilakukan saat tindakan resusitasi berlangsung. Bayi yang telah menunjukkan perbaikan setelah VTP tetap membutuhkan pemantauan karena gangguan pernapasan dapat muncul kembali. Pemantauan meliputi pola dan usaha napas, denyut jantung, suhu tubuh, oksigenasi sesuai kebutuhan, tonus, aktivitas, dan tanda klinis lain yang menunjukkan kestabilan bayi. WHO menempatkan resusitasi bila diperlukan, pemantauan masalah kesehatan, pengenalan tanda bahaya, dan rujukan tepat waktu sebagai bagian dari perawatan esensial bayi baru lahir.

Keputusan untuk melakukan kolaborasi atau rujukan harus didasarkan pada kondisi klinis bayi dan kemampuan fasilitas pelayanan. Bayi dengan gangguan napas persisten, kebutuhan oksigen atau ventilasi berkelanjutan, denyut jantung yang tidak stabil, sianosis menetap, prematuritas dengan komplikasi, atau kondisi lain yang membutuhkan pemantauan dan perawatan intensif perlu mendapatkan pelayanan pada fasilitas yang memiliki kemampuan neonatal yang sesuai.

E. Perawatan Pascareusitasi, KIE, dan Dokumentasi

Perawatan pascaresusitasi merupakan bagian penting dalam pelayanan bayi baru lahir setelah tindakan resusitasi berhasil dilakukan. Bayi yang telah menunjukkan perbaikan setelah Ventilasi Tekanan Positif (VTP) tetap memiliki risiko mengalami gangguan transisi, seperti gangguan pernapasan, hipotermia, hipoglikemia, atau penurunan kondisi kembali. Oleh karena itu, penghentian tindakan resusitasi tidak berarti bahwa pemantauan terhadap bayi dapat segera dihentikan. Bayi perlu diamati secara berkelanjutan hingga kondisi benar-benar stabil. Pedoman AHA/AAP 2025 menekankan bahwa bayi yang memerlukan resusitasi lebih dari langkah awal membutuhkan observasi dan pemantauan lanjutan.

Pemantauan pascaresusitasi meliputi penilaian pernapasan, denyut jantung, oksigenasi sesuai kebutuhan, suhu tubuh, tonus, aktivitas, serta kondisi umum bayi. Penolong perlu memperhatikan adanya tanda gangguan pernapasan seperti napas cepat, retraksi dinding dada, grunting, apnea, atau sianosis. Apabila tersedia dan terdapat indikasi, saturasi oksigen dapat dipantau menggunakan pulse oximeter. Pemantauan dilakukan secara berkala untuk memastikan bayi mampu mempertahankan fungsi pernapasan dan sirkulasi tanpa bantuan.

Suhu tubuh merupakan salah satu parameter yang perlu diperhatikan secara khusus. Bayi baru lahir memiliki kemampuan termoregulasi yang terbatas sehingga mudah mengalami kehilangan panas. Suhu tubuh perlu dipertahankan pada kisaran 36,5–37,5°C. Bayi yang mengalami hipotermia setelah resusitasi perlu mendapatkan tindakan penghangatan dan pemantauan suhu secara berkala. Pencegahan hipotermia dapat dilakukan melalui lingkungan yang hangat, penggunaan kain atau selimut kering, radiant warmer sesuai kebutuhan, serta kontak kulit dengan ibu apabila kondisi bayi telah stabil.

Selain suhu, kadar glukosa darah dapat menjadi perhatian terutama pada bayi yang membutuhkan ventilasi berkepanjangan atau resusitasi lanjutan. Bayi yang mengalami stres hipoksia atau resusitasi berat memiliki risiko gangguan metabolik, termasuk hipoglikemia. Pada kondisi tersebut, pemeriksaan glukosa dilakukan sesuai indikasi, kondisi klinis, dan protokol fasilitas pelayanan. Pemantauan perlu dilanjutkan sampai kadar glukosa berada dalam rentang yang stabil.

Pencegahan infeksi juga harus tetap diterapkan selama dan setelah resusitasi. Kebersihan tangan merupakan langkah dasar sebelum dan setelah memberikan perawatan kepada bayi. Peralatan yang digunakan harus bersih, diproses sesuai standar pencegahan dan pengendalian infeksi, serta disimpan dalam kondisi yang siap digunakan. Kebersihan kulit dan tali pusat juga perlu diperhatikan. WHO memasukkan perlindungan suhu, pencegahan infeksi, pemberian ASI, pengenalan tanda bahaya, dan resusitasi bila diperlukan sebagai bagian dari perawatan esensial bayi baru lahir.

Apabila kondisi bayi telah stabil, perawatan esensial bayi baru lahir dapat dilanjutkan sesuai kebutuhan. Kontak kulit dengan ibu dapat dilakukan apabila tidak terdapat kontraindikasi dan kondisi ibu maupun bayi memungkinkan. Pemberian ASI juga dapat dimulai atau didukung ketika bayi telah memiliki pernapasan dan kondisi klinis yang stabil. Pada bayi yang masih membutuhkan pengawasan ketat, prioritas tetap diberikan pada stabilisasi dan pemantauan sebelum melanjutkan perawatan rutin.

Komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada ibu dan keluarga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perawatan pascaresusitasi. Situasi ketika bayi

membutuhkan bantuan pernapasan sering menimbulkan kecemasan bagi keluarga. Oleh karena itu, penolong perlu menjelaskan kondisi bayi secara tenang, jelas, dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Informasi yang disampaikan dapat mencakup kondisi bayi saat lahir, alasan dilakukan resusitasi, tindakan yang telah diberikan, respons bayi terhadap tindakan, serta kondisi bayi setelah resusitasi.

Keluarga juga perlu diberikan edukasi mengenai tanda bahaya yang membutuhkan perhatian segera, seperti bayi sulit bernapas, tidak mau atau sulit menyusu, aktivitas menurun, kejang, demam, tubuh terasa dingin, atau perubahan warna kulit yang tidak normal. WHO merekomendasikan agar keluarga mampu mengenali tanda gangguan kesehatan pada bayi dan segera mencari pelayanan kesehatan apabila tanda bahaya ditemukan.

Selain memberikan informasi, tenaga kesehatan perlu menjaga komunikasi yang empatik dan tidak menyalahkan ibu maupun keluarga atas kondisi bayi. Informasi mengenai prognosis sebaiknya disampaikan secara hati-hati berdasarkan kondisi klinis yang telah dinilai. Apabila bayi membutuhkan pemantauan lebih lanjut atau rujukan, keluarga perlu memperoleh penjelasan mengenai alasan, tujuan, serta proses rujukan sehingga dapat memahami tindakan yang dilakukan.

Dokumentasi merupakan bagian penting dalam keseluruhan proses resusitasi dan perawatan pascaresusitasi. Pencatatan yang lengkap membantu menjamin kesinambungan pelayanan, menjadi sumber informasi bagi tenaga kesehatan yang menerima bayi berikutnya, serta mendukung evaluasi mutu pelayanan. Dokumentasi perlu dilakukan secara sistematis dan mencerminkan kondisi bayi serta tindakan yang benar-benar telah diberikan.

Informasi yang perlu dicatat antara lain kondisi bayi saat lahir, waktu dilakukannya penilaian dan tindakan, hasil penilaian denyut jantung dan pernapasan, langkah awal yang diberikan, pelaksanaan VTP, respons bayi terhadap tindakan, penggunaan oksigen apabila diberikan, hasil pemantauan setelah resusitasi, serta kondisi bayi saat tindakan selesai. Apabila dilakukan kolaborasi atau rujukan, waktu, alasan, tindakan stabilisasi, serta tenaga kesehatan atau fasilitas tujuan juga perlu didokumentasikan.

Keputusan untuk melakukan rujukan ditentukan berdasarkan kondisi bayi dan kemampuan fasilitas pelayanan. Bayi dengan gangguan pernapasan yang menetap, kebutuhan ventilasi atau oksigen berkelanjutan, denyut jantung tidak stabil, gangguan kesadaran atau tonus, kejang, prematuritas dengan komplikasi, atau kondisi lain yang membutuhkan perawatan neonatal lebih lanjut perlu mendapatkan pelayanan pada fasilitas yang memiliki kemampuan sesuai. WHO menempatkan dukungan pernapasan lanjutan dan perawatan neonatal kompleks pada tingkat pelayanan rujukan.

Sebelum rujukan, bayi harus distabilkan semaksimal mungkin sesuai kemampuan fasilitas. Jalan napas dan pernapasan perlu dipastikan adekuat, suhu tubuh dijaga, kondisi sirkulasi dipantau, dan bantuan pernapasan dilanjutkan apabila masih dibutuhkan. Informasi mengenai kondisi bayi, tindakan yang telah dilakukan, serta respons terhadap tindakan perlu disampaikan secara jelas kepada fasilitas penerima sehingga kesinambungan pelayanan dapat dipertahankan.

F. Latihan Soal

1. Seorang perempuan berusia 32 tahun, G2P1A0, hamil 34 minggu datang ke ruang bersalin dengan kontraksi teratur. Persalinan diperkirakan berlangsung dalam waktu dekat. Kondisi ibu stabil, tetapi usia kehamilan menunjukkan persalinan preterm. Bidan mengetahui bahwa bayi prematur memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan adaptasi setelah lahir.
   Apakah tindakan yang paling tepat dilakukan bidan sebelum bayi lahir?
   A. Menunggu kondisi bayi setelah lahir sebelum menyiapkan alat
   B. Menyiapkan alat resusitasi, lingkungan hangat, dan pembagian tugas tim
   C. Langsung menyiapkan oksigen 100% untuk semua kemungkinan kondisi bayi
   D. Menyiapkan alat pengisap sebagai tindakan utama setelah bayi lahir
   E. Membatasi jumlah tenaga kesehatan agar ruang persalinan lebih tenang
   Kunci jawaban: B. Menyiapkan alat resusitasi, lingkungan hangat, dan pembagian tugas tim
   Rasional: Prematuritas merupakan salah satu kondisi yang dapat meningkatkan kemungkinan bayi membutuhkan bantuan setelah lahir. Persiapan resusitasi harus dilakukan sebelum kelahiran, meliputi kesiapan lingkungan, sumber kehangatan, alat ventilasi, sungkup yang sesuai, serta pembagian tugas tim.
   - A tidak tepat: Menunggu sampai bayi lahir dapat menyebabkan keterlambatan tindakan.
   - B tepat: Persiapan alat, lingkungan, dan tim merupakan bagian utama kesiapan resusitasi.
   - C tidak tepat: Oksigen konsentrasi tinggi tidak diberikan rutin kepada setiap bayi.
   - D tidak tepat: Pengisapan jalan napas bukan tindakan rutin utama pada semua bayi.
   - E tidak tepat: Persalinan berisiko justru memerlukan kesiapan tenaga dengan kompetensi yang sesuai.

2. Seorang bayi laki-laki lahir spontan pada usia kehamilan 39 minggu. Setelah lahir, bayi tidak segera menangis, tonus otot tampak menurun, dan pernapasan belum

efektif. Bidan segera membawa bayi ke area resusitasi yang hangat. Bayi belum menunjukkan napas spontan yang adekuat setelah dilakukan pengeringan awal.
Apakah tindakan awal yang paling tepat dilakukan bidan?

A. Langsung melakukan kompresi dada
B. Memberikan minum untuk merangsang bayi
C. Menjaga kehangatan, memposisikan jalan napas, mengeringkan, dan memberi stimulasi
D. Melakukan pengisapan mulut dan hidung secara rutin selama beberapa menit
E. Menunggu satu menit untuk melihat apakah bayi akan bernapas sendiri

Kunci jawaban: C. Menjaga kehangatan, memposisikan jalan napas, mengeringkan, dan memberi stimulasi

Rasional: Pada bayi yang tidak bernapas efektif, langkah awal meliputi menjaga kehangatan, memposisikan kepala agar jalan napas terbuka, mengeringkan tubuh, memberikan stimulasi taktil yang sesuai, lalu menilai kembali pernapasan dan kondisi bayi. Tindakan ini harus dilakukan cepat agar ventilasi tidak terlambat apabila bayi tetap tidak bernapas.

- A tidak tepat: Kompresi dada bukan langkah awal pada kondisi ini.
- B tidak tepat: Pemberian minum bukan bagian dari resusitasi awal.
- C tepat: Sesuai urutan langkah awal resusitasi pada bayi yang tidak bernapas efektif.
- D tidak tepat: Pengisapan tidak dilakukan rutin kecuali terdapat obstruksi.
- E tidak tepat: Menunggu dapat menunda bantuan pernapasan yang diperlukan.

3. Seorang bayi perempuan lahir cukup bulan di puskesmas. Setelah dilakukan penghangatan, pengeringan, pengaturan posisi kepala, dan stimulasi, bayi masih mengalami gasping. Hasil auskultasi menunjukkan denyut jantung 88 kali/menit. Tidak tampak sekret yang menghambat jalan napas dan alat resusitasi telah tersedia di meja tindakan.
   Apakah tindakan selanjutnya yang paling tepat dilakukan bidan?

   A. Melanjutkan stimulasi sampai bayi menangis
   B. Melakukan pengisapan jalan napas berulang
   C. Memberikan Ventilasi Tekanan Positif
   D. Langsung melakukan kompresi dada
   E. Mengobservasi bayi tanpa intervensi selama lima menit

   Kunci jawaban: C. Memberikan Ventilasi Tekanan Positif

   Rasional: VTP diberikan apabila bayi mengalami apnea, gasping, atau denyut jantung tetap kurang dari 100 kali/menit setelah langkah awal dilakukan dengan

benar. Pada kasus ini bayi mengalami gasping dengan denyut jantung 88 kali/menit, sehingga VTP merupakan tindakan yang paling tepat.

- A tidak tepat: Stimulasi berulang dapat menunda ventilasi yang dibutuhkan.
- B tidak tepat: Tidak terdapat tanda obstruksi jalan napas.
- C tepat: Bayi memenuhi indikasi VTP.
- D tidak tepat: Kompresi dada dipertimbangkan bila denyut jantung tetap <60 kali/menit setelah ventilasi efektif.
- E tidak tepat: Observasi tanpa intervensi dapat memperburuk hipoksia.

4. Seorang bayi baru lahir mendapatkan VTP karena apnea dan denyut jantung 80 kali/menit. Setelah ventilasi diberikan, dada bayi tidak tampak bergerak dan denyut jantung belum meningkat. Bidan memperhatikan posisi sungkup kurang rapat pada wajah dan kepala bayi tampak sedikit fleksi. Tidak terlihat sekret yang menghambat jalan napas.

   Apakah tindakan yang paling tepat dilakukan bidan?

   A. Menghentikan VTP dan melakukan observasi
   B. Memperbaiki segel sungkup dan memposisikan ulang kepala bayi
   C. Segera melakukan kompresi dada
   D. Meningkatkan oksigen hingga 100% tanpa memperbaiki ventilasi
   E. Melakukan pengisapan jalan napas meskipun tidak terdapat obstruksi

   Kunci jawaban: B. Memperbaiki segel sungkup dan memposisikan ulang kepala bayi

   Rasional: Tidak adanya pergerakan dada dan peningkatan denyut jantung menunjukkan kemungkinan ventilasi belum efektif. Penyebabnya dapat berupa kebocoran sungkup atau posisi kepala yang tidak tepat. Koreksi pertama adalah memperbaiki pemasangan sungkup dan posisi jalan napas sebelum mempertimbangkan tindakan lain.

   - A tidak tepat: Bayi masih membutuhkan bantuan ventilasi.
   - B tepat: Masalah utama pada kasus adalah kebocoran sungkup dan posisi kepala yang kurang baik.
   - C tidak tepat: Kompresi dada belum menjadi pilihan sebelum dipastikan ventilasi efektif.
   - D tidak tepat: Masalah utama adalah teknik ventilasi, bukan semata konsentrasi oksigen.
   - E tidak tepat: Pengisapan hanya dipertimbangkan bila terdapat obstruksi.

5. Seorang bayi baru lahir sebelumnya mengalami apnea dan mendapatkan VTP. Setelah tindakan, denyut jantung meningkat menjadi 128 kali/menit dan bayi

mulai bernapas spontan. VTP dihentikan secara bertahap. Lima belas menit kemudian bayi tampak bernapas spontan, tetapi suhu tubuh 36,2°C dan masih memerlukan observasi setelah resusitasi.

Apakah tindakan yang paling tepat dilakukan bidan?

A. Memulangkan bayi karena denyut jantung sudah normal
B. Menghentikan seluruh pemantauan karena VTP telah berhasil
C. Menjaga kehangatan dan melanjutkan pemantauan kondisi bayi
D. Memberikan VTP kembali meskipun bayi bernapas spontan baik
E. Melakukan pengisapan jalan napas secara rutin sebelum bayi disusui

Kunci jawaban: C. Menjaga kehangatan dan melanjutkan pemantauan kondisi bayi

Rasional: Bayi yang telah memerlukan VTP tetap membutuhkan observasi setelah resusitasi. Pemantauan meliputi pernapasan, denyut jantung, oksigenasi sesuai kebutuhan, suhu, tonus, dan kondisi umum. Suhu 36,2°C berada di bawah kisaran 36,5–37,5°C yang dituliskan dalam materi, sehingga bayi perlu dihangatkan dan dipantau.

- A tidak tepat: Keberhasilan VTP tidak berarti bayi langsung aman untuk dipulangkan.
- B tidak tepat: Gangguan pernapasan atau kondisi lain dapat kembali muncul setelah resusitasi.
- C tepat: Bayi membutuhkan pencegahan hipotermia dan pemantauan berkelanjutan.
- D tidak tepat: VTP tidak diperlukan bila bayi sudah bernapas spontan secara adekuat dan stabil.
- E tidak tepat: Pengisapan jalan napas tidak dilakukan rutin tanpa indikasi.

G. Ringkasan

Resusitasi dasar bayi baru lahir merupakan keterampilan penting dalam pelayanan kebidanan yang bertujuan membantu bayi melewati proses transisi dari kehidupan intrauterin ke ekstrauterin, terutama ketika bayi tidak mampu memulai atau mempertahankan pernapasan secara efektif. Keberhasilan resusitasi tidak hanya ditentukan oleh tindakan yang dilakukan setelah bayi lahir, tetapi juga oleh kesiapan sebelum kelahiran melalui pengkajian faktor risiko, persiapan lingkungan, pemeriksaan peralatan, serta koordinasi dan pembagian tugas dalam tim.

Penilaian awal dilakukan segera setelah bayi lahir dengan memperhatikan pernapasan atau tangisan, tonus otot, kondisi umum, dan denyut jantung apabila bayi membutuhkan resusitasi. Bayi yang mengalami apnea, gasping, atau gangguan pernapasan memerlukan tindakan secara cepat. Langkah awal meliputi menjaga

kehangatan, memposisikan jalan napas dengan tepat, mengeringkan, memberikan stimulasi yang sesuai, serta melakukan pembersihan jalan napas hanya apabila terdapat indikasi obstruksi.

Ventilasi Tekanan Positif (VTP) merupakan tindakan utama pada bayi yang tidak bernapas secara efektif atau memiliki denyut jantung kurang dari 100 kali per menit setelah langkah awal. Keberhasilan VTP dipengaruhi oleh posisi kepala, pemilihan dan pemasangan sungkup, terbentuknya segel yang baik, tekanan ventilasi yang sesuai, serta kemampuan penolong mengevaluasi respons bayi. Peningkatan denyut jantung merupakan indikator utama bahwa ventilasi telah efektif. Apabila denyut jantung tidak meningkat atau dada tidak bergerak secara adekuat, teknik ventilasi harus segera dievaluasi dan dikoreksi sebelum tindakan resusitasi ditingkatkan.

Evaluasi selama resusitasi dilakukan secara berulang dengan memperhatikan denyut jantung, pernapasan, dan pergerakan dada. Bayi yang menunjukkan peningkatan denyut jantung dan mampu bernapas spontan dapat dihentikan dari bantuan ventilasi secara bertahap, sedangkan bayi yang tetap mengalami bradikardia membutuhkan ventilasi lanjutan dan evaluasi terhadap efektivitasnya. Kondisi yang tidak membaik meskipun ventilasi telah efektif harus segera dikenali sebagai keadaan yang membutuhkan resusitasi lebih lanjut, kolaborasi dengan tim yang kompeten, serta rujukan apabila kemampuan fasilitas terbatas.

Perawatan pascaresusitasi merupakan kelanjutan penting dari proses tersebut. Bayi perlu dipantau hingga stabil dengan memperhatikan pernapasan, denyut jantung, oksigenasi sesuai kebutuhan, suhu tubuh, tonus, aktivitas, serta kemungkinan gangguan metabolik. Pencegahan hipotermia dan infeksi, pemberian ASI serta kontak kulit apabila kondisi memungkinkan, KIE kepada ibu dan keluarga, dan dokumentasi yang lengkap merupakan bagian integral dari pelayanan. Bayi yang menunjukkan gangguan pernapasan persisten, ketidakstabilan sirkulasi, kebutuhan ventilasi atau oksigen berkelanjutan, atau kondisi lain yang memerlukan perawatan neonatal lebih lanjut harus distabilkan dan dirujuk secara tepat.

Dengan demikian, keterampilan resusitasi dasar bayi baru lahir tidak hanya menuntut kemampuan melakukan prosedur, tetapi juga membutuhkan pengkajian yang cepat, pengambilan keputusan klinis, ketepatan teknik ventilasi, evaluasi respons, komunikasi, kerja sama tim, serta kemampuan menentukan kebutuhan kolaborasi dan rujukan. Penguasaan keterampilan tersebut membantu bidan memberikan pertolongan yang aman, tepat waktu, berbasis bukti, dan sesuai dengan kewenangan profesi dalam upaya mempertahankan keselamatan bayi baru lahir.

H. Daftar Pustaka

Lee, H. C., Strand, M. L., Finan, E., Illuzzi, J., Kamath-Rayne, B. D., Kapadia, V., Mahgoub, M., Niermeyer, S., Schexnayder, S. M., Schmölzer, G. M., Weglarz, J., Williams, A. L., Weiner, G. M., Wyckoff, M., Yamada, N. K., & Szyld, E. (2025). Part 5: Neonatal resuscitation: 2025 American Heart Association and American Academy of Pediatrics guidelines for cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiovascular care. Circulation, 152(Suppl. 2), S385–S423. https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000001367

Weiner, G. M., Lee, H. C., & Cooper, C. M. (Eds.). (2025). Textbook of neonatal resuscitation (9th ed.). American Academy of Pediatrics. https://doi.org/10.1542/9781610028585

World Health Organization. (2022a). WHO recommendations for care of the preterm or low-birth-weight infant. World Health Organization. https://www.who.int/publications/i/item/9789240058262

World Health Organization. (2022b). WHO recommendations on maternal and newborn care for a positive postnatal experience. World Health Organization. https://www.who.int/publications/i/item/9789240045989

World Health Organization. (2025). Essential newborn care course (2nd ed.). World Health Organization. https://www.who.int/publications/i/item/9789240112698

BAB 4

KETERAMPILAN ASUHAN NIFAS DAN MENYUSUI: PEMERIKSAAN IBU, TEKNIK MENYUSUI, DAN MANAJEMEN MASALAH UMUM

Pendahuluan

Masa nifas (*puerperium*) merupakan fase pemulihan yang kritis bagi ibu, dimulai segera setelah kelahiran plasenta hingga organ reproduksi kembali ke kondisi sebelum hamil, yang berlangsung selama kurang lebih 6 minggu. Peran bidan dalam periode ini sangat vital, terutama dalam memastikan proses involusi uteri berjalan normal, mendeteksi tanda bahaya sedini mungkin, dan memberikan dukungan laktasi yang optimal. Asuhan kebidanan pada masa ini tidak hanya berfokus pada pemulihan fisik, tetapi juga mendukung transisi psikologis ibu agar memiliki kepercayaan diri yang tinggi dalam merawat bayinya (*Parenting Self-Efficacy*). Bab ini akan membahas secara mendalam mengenai keterampilan klinis yang diperlukan mahasiswa kebidanan dalam memberikan asuhan nifas dan menyusui yang komprehensif. Fokus utama meliputi: Pemeriksaan Fisik Ibu Nifas: Prosedur pemantauan tanda vital, pemeriksaan payudara, evaluasi involusi uterus (TFU), dan pengkajian perineum; Dinamika Menyusui: Teknik penilaian proses laktasi menggunakan instrumen kuantitatif; Manajemen Masalah Umum: Penanganan keluhan pascapersalinan dan hambatan menyusui; Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE): Pemberian edukasi perawatan mandiri melalui metode yang efektif.

Pembahasan dimulai dengan penguatan teori dasar mengenai perubahan fisiologis dan psikologis masa nifas. Selanjutnya, mahasiswa akan dibimbing melalui langkah-langkah praktis pemeriksaan klinis yang aman dan bermutu. Bagian khusus akan mengulas penggunaan instrumen klinis seperti Bristol Breastfeeding Assessment Tool (BBAT) untuk mengevaluasi posisi, perlekatan, dan efektivitas isapan bayi secara objektif. Di akhir bab, akan dibahas mengenai strategi edukasi berpusat pada perempuan dengan melibatkan keluarga sebagai pendukung utama.

Tujuan Instruksional Umum:

Mahasiswa mampu mendemonstrasikan keterampilan asuhan kebidanan masa nifas dan menyusui secara aman, efektif, dan bermutu, serta sesuai dengan kewenangan dan standar profesi.

Tujuan Instruksional Khusus:

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Melakukan pengumpulan data subjektif dan objektif pada ibu nifas secara sistematis.
2. Mengevaluasi keberhasilan laktasi menggunakan skor klinis (BBAT) secara akurat.
3. Memberikan KIE mengenai tanda bahaya nifas dan perawatan bayi sehari-hari.
4. Mengidentifikasi risiko (*Red Flags*) dan menentukan kebutuhan kolaborasi atau rujukan tepat waktu.

Capaian Pembelajaran (CP)

1. Kognitif (Pengetahuan)

- Mampu menjelaskan tahapan kunjungan nifas (KF1-KF4) dan rasionalisasi tindakan yang diberikan.
- Mampu menginterpretasikan data hasil pemeriksaan (seperti involusi uteri dan jenis lokhia) untuk menentukan status kesehatan ibu.
- Memahami konsep asuhan komplementer untuk mendukung kenyamanan dan produksi ASI.

2. Psikomotor (Keterampilan)

- Terampil melakukan pemeriksaan fisik *head-to-toe*, termasuk masase uterus dan perawatan luka perineum.
- Mampu mendemonstrasikan berbagai posisi menyusui yang benar (seperti *cradle hold* atau *rugby hold*) untuk membantu ibu dan bayi [467, Posisi Menyusui].
- Mampu melakukan edukasi dengan teknik *Teach-back* untuk memverifikasi pemahaman ibu dan keluarga.

3. Afektif (Sikap)

- Menunjukkan perilaku profesional, empati, dan menjaga privasi serta keselamatan pasien selama seluruh tindakan klinis.
- Menerapkan prinsip *Respectful Maternity Care* (RMC) dalam memberikan asuhan yang menghargai hak dan martabat ibu.
- Menunjukkan kemampuan bekerja sama dalam tim dan melibatkan pendamping dalam proses asuhan

Uraian Materi

Uraian materi dalam BAB ini terdiri dari pembahasan mengenai asuhan nifas dan menyusui. Mulai dari definisi, konsep dasar nifas, perubahan fisiologi, asuhan kebidanan dalam masa nifas termasuk juga asuhan menyusui, prosedur ketrampilan dan instrument pemeriksaan pada ibu nifas dan menyusui.

A. Definisi dan Konsep Dasar Masa Nifas

Masa nifas, atau dalam terminologi medis disebut sebagai *puerperium*, yang merupakan periode transisi yang dimulai segera setelah lahirnya plasenta dan berakhir ketika organ-organ reproduksi kembali ke kondisi fisiologis seperti sebelum hamil. Secara etimologis, istilah ini berasal dari bahasa Latin *puer* yang berarti bayi dan *parous* yang berarti melahirkan. (Cunningham et al., 2022)

Menurut Chauhan & Tadi (2026), periode ini umumnya berlangsung selama 6 minggu atau 42 hari, namun pemulihan fungsional dan penyesuaian psikososial yang menyeluruh sering kali melampaui rentang waktu tersebut. Berdasarkan tahapan pemulihannya, masa nifas diklasifikasikan menjadi tiga fase utama (Chauhan & Tadi, 2026a):

1. Puerperium Dini (Immediate Postpartum): 0–24 jam pascapersalinan, merupakan fase paling berisiko untuk terjadinya komplikasi akut seperti perdarahan.
2. Puerperium Awal (Early Postpartum): Hari ke-2 hingga hari ke-7, di mana proses involusi organ mulai stabil dan produksi ASI mulai meningkat secara signifikan.
3. Puerperium Lanjut (Late Postpartum): Minggu ke-2 hingga minggu ke-6, fokus pada pemulihan fisik total dan kemantapan peran ibu dalam merawat bayi**.**

Asuhan pada periode ini bersifat holistik, yang mencakup pengawasan proses penyembuhan jaringan, stabilisasi hormonal, hingga pendampingan adaptasi psikologis. Berdasarkan teori adaptasi psikososial, proses ini dijabarkan ke dalam tiga fase utama sebagai berikut (Meilani & Putri, 2024):

1. Fase *Taking In* (Masa Ketergantungan)

Fase *Taking In* merupakan periode awal yang berlangsung pada hari pertama hingga hari kedua setelah persalinan. Pada tahap ini, fokus utama ibu masih tertuju secara intensif pada kondisi dirinya sendiri (*self-focus*) guna memulihkan kelelahan fisik akibat proses melahirkan. Ibu cenderung bersikap pasif terhadap lingkungan dan memiliki kebutuhan yang tinggi untuk menceritakan pengalaman persalinannya secara berulang. Secara klinis, pada fase ini ibu mengalami "proses mengetahui" yang meliputi identifikasi bagian tubuh bayi serta fase *relating*, yaitu menghubungkan kemiripan fisik bayi dengan anggota keluarga lain.

2. Fase Taking *Hold* (Masa Transisi Ketergantungan ke Mandiri)

Fase *Taking Hold* berlangsung antara hari ke-3 hingga hari ke-10 pascapersalinan. Fase ini ditandai dengan peningkatan energi fisik ibu dan pergeseran fokus perhatian dari diri sendiri mulai beralih secara penuh kepada bayi yang dilahirkan. Ibu mulai menunjukkan keinginan untuk belajar dan melakukan perawatan bayi secara mandiri, namun sering kali disertai rasa khawatir atau cemas terhadap kemampuannya dalam menjalankan tanggung jawab tersebut. Karena kondisi emosional ibu pada tahap ini sangat sensitif dan mudah tersinggung, dukungan bidan melalui bimbingan praktis seperti teknik menyusui, perawatan tali pusat, dan senam nifas sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan diri ibu.

3. Fase *Letting Go* (Masa Kemandirian)

Fase *Letting Go* dimulai setelah hari ke-10 pascapersalinan, di mana ibu secara sadar mulai menerima tanggung jawab penuh atas peran barunya sebagai orang tua. Pada tahap ini, ibu umumnya sudah mampu menyesuaikan diri dengan rutinitas baru dan melepaskan gambaran diri atau ekspektasi masa lalu yang tidak realistis. Kepercayaan diri ibu dalam merawat bayi dan dirinya sendiri telah meningkat secara signifikan, sehingga ia menjadi lebih mandiri dalam mengambil keputusan. Meskipun telah mencapai kemandirian, keterlibatan suami dan keluarga dalam membantu pekerjaan rumah tangga tetap krusial agar ibu tidak terbebani secara fisik dan dapat fokus pada pembentukan ikatan kasih sayang (*bonding attachment*) yang optimal dengan bayinya.

Kegagalan dalam melewati fase-fase adaptasi ini secara harmonis dapat memicu munculnya gangguan suasana hati, mulai dari yang ringan seperti *postpartum blues* hingga kondisi yang lebih berat seperti depresi nifas (Meilani & Putri, 2024).

B. Perubahan Fisiologis Masa Nifas

Pemahaman mendalam mengenai perubahan fisiologis sangat krusial bagi bidan untuk membedakan antara proses pemulihan yang normal dengan tanda-tanda patologis. Berikut adalah perubahan fisiologis utama yang terjadi selama masa nifas berdasarkan sistem organ (Chauhan & Tadi, 2026a):

1. Sistem Reproduksi dan Involusi

Proses kembalinya organ reproduksi ke kondisi sebelum hamil disebut sebagai involusi.

a. Uterus: Involusi uteri adalah proses kembalinya uterus ke bentuk dan ukuran semula melalui mekanisme autolisis dan dan infark pembuluh darah uterus akibat penurunan hormon estrogen dan progesteron. Kontraksi ini tidak hanya bertujuan memperkecil ukuran rahim, tetapi juga berfungsi sebagai hemostasis alami dengan menekan pembuluh darah di lokasi implantasi plasenta untuk mencegah perdarahan. Dengan berat sekitar 1000 gram. Berat ini menyusut menjadi 500 gram pada akhir minggu pertama dan mencapai sekitar 50 gram pada minggu keenam.

   Parameter Pemeriksaan Klinis:

   1) Tinggi Fundus Uteri (TFU): Segera setelah janin lahir, fundus berada setinggi pusat atau dua jari di bawah pusat. Penurunan TFU terjadi secara konsisten sekitar 1–2 cm per hari. Pada hari ke-5 postpartum, fundus biasanya berada di pertengahan antara pusat dan simfisis, dan setelah hari ke-12, uterus seharusnya sudah tidak teraba lagi di atas simfisis.
   2) Kontraksi Uterus: Uterus harus selalu teraba keras saat palpasi. Keluhan nyeri ringan (*afterpains*) merupakan hal normal akibat kontraksi uterus, terutama pada ibu multipara atau ibu yang menyusui secara aktif karena pengaruh hormon oksitosin.

   Implikasi Klinis:

   Kegagalan uterus untuk berkontraksi dengan baik (atonia uteri) atau kegagalan proses involusi (subinvolusi) merupakan penyebab utama perdarahan postpartum sekunder. Intervensi seperti masase uterus, mobilisasi dini, dan inisiasi menyusui dini (IMD) sangat disarankan untuk merangsang produksi oksitosin alami yang mendukung involusi.

b. Lochea: Lochea adalah ekskresi cairan vagina selama masa nifas yang mengandung darah, jaringan desidua, dan sisa selaput ketuban. Evaluasi lochea mencakup penilaian volume, konsistensi, warna, dan aroma untuk mendeteksi adanya tanda infeksi atau gangguan involusi.

   Tahapan Karakteristik Lochea:

1) Lochea Rubra (Hari 1–3): Berwarna merah terang, mengandung darah segar, sisa selaput ketuban, dan sisa mekonium.
2) Lochea Sanguinolenta (Hari 3–7): Berwarna merah kecokelatan atau kekuningan, terdiri dari darah bercampur lendir.
3) Lochea Serosa (Hari 7–14): Berwarna merah muda atau kecokelatan, mengandung lebih sedikit darah dan lebih banyak serum serta leukosit.
4) Lochea Alba (Setelah Hari ke-14): Berwarna putih pucat atau kekuningan, didominasi oleh sel leukosit dan jaringan desidua yang sudah mati (Gil et al., 2025).

Kriteria Abnormalitas (*Red Flags*):

1) Aroma: Lochea yang normal memiliki bau khas seperti darah menstruasi. Jika muncul bau busuk (*foul smelling*), hal ini mengindikasikan adanya infeksi seperti endometritis.
2) Volume: Pengeluaran darah yang sangat banyak (mengganti pembalut 2 kali dalam 30 menit) atau adanya gumpalan darah berukuran besar merupakan tanda perdarahan abnormal.
3) Durasi: Lochea rubra yang menetap lebih dari dua minggu dapat mengindikasikan adanya sisa plasenta di dalam rahim atau subinvolusi uterus. Kondisi di mana lochea tidak keluar dengan lancar disebut sebagai *lochiastasis*.

c. Serviks dan Vagina: Vagina yang mengalami edema dan memar akan berangsur pulih, dengan munculnya kembali rugae pada minggu ketiga jika ibu tidak menyusui.

2. Perubahan Payudara dan Laktasi

Transisi fisiologis pada payudara pascapersalinan dimulai dengan proses laktogenesis. Secara biokimiawi, proses Laktogenesis II dimulai sekitar 30–40 jam setelah melahirkan, namun secara klinis ibu biasanya baru merasakan payudara penuh (sensasi *engorgement*) pada rentang 50–73 jam atau hari ke-2 hingga ke-4 postpartum. Peningkatan vaskularisasi dan produksi air susu yang pesat ini sering disebut sebagai "*physiological breast engorgement*".

Karakteristik Normal Payudara Nifas:

a. Sensasi Penuh: Payudara teraba padat dan kencang namun tidak disertai nyeri hebat yang berdenyut atau kemerahan yang terlokalisir.
b. Ekskresi Kolostrum: Cairan kental kekuningan keluar pada awal menyusui. Kolostrum sangat krusial karena mengandung antibodi tinggi, terutama Immunoglobulin A (IgA), yang melapisi usus bayi dan mencegah infeksi serta alergi.

c. Refleks Oksitosin (*Let-down Reflex*): Ibu merasakan sensasi kesemutan *tingling*) atau aliran ASI spontan saat melihat, mendengar suara, atau memikirkan bayinya.

Implikasi Klinis:

Keterlambatan dalam inisiasi menyusui dini (IMD) atau jadwal menyusui yang tidak teratur dapat menyebabkan stasis ASI, yang memicu bendungan payudara patologis dan meningkatkan risiko mastitis. Bidan harus menekankan bahwa isapan bayi merupakan stimulus mekanik utama untuk sekresi prolaktin dan oksitosin.

3. Sistem Kardiovaskular dan Hematologi

a. Hemodinamika: Segera setelah lahir, terjadi peningkatan volume darah sirkulasi akibat kontraksi uterus dan hilangnya tekanan pada vena kava inferior, yang menyebabkan curah jantung melonjak 60-80% sebelum kembali normal dalam dua minggu.
b. Koagulasi: Masa nifas merupakan kondisi hiperkoagulasi (risiko penggumpalan darah meningkat 20 kali lipat dibanding kondisi normal), di mana kadar faktor pembekuan darah tetap tinggi selama beberapa minggu untuk mencegah perdarahan, namun meningkatkan risiko tromboemboli.
c. Leukosit: Terjadi leukositosis fisiologis (hingga 25.000/mm^3) akibat stres persalinan yang akan normal kembali dalam 4 minggu.

Implikasi Klinis:

Masa nifas awal membawa risiko fenomena tromboemboli (penggumpalan darah) hingga dua puluh kali lipat lebih tinggi dibandingkan kondisi tidak hamil. Oleh karena itu, stratifikasi risiko dan pemberian tromboprofilaksis (pencegahan penggumpalan darah) sangat penting bagi pasien dengan risiko menengah hingga tinggi

Kriteria Abnormalitas (Red Flags):

Penurunan tekanan darah >20% dari nilai dasar (*baseline),* memungkinkan adanya masalah klinis berupa Perdarahan Postpartum (HPP) atau adanya Syok Septik. Selain itu, peningkatan tekanan darah yang disertai dengan sakit kepala hebat, dapat memungkinkan adanya masalah klinis berupa preeklamsia pascasalin yang dapat mengganggu system syaraf.

4. Sistem Perkemihan dan Cairan

a. Diuresis: Terjadi pergeseran cairan dari ekstravaskular ke intravaskular (6-8 liter air), yang dibuang melalui diuresis cepat pada dua minggu pertama, dengan pengeluaran urin bisa mencapai 3000 cc/hari.
b. Fungsi Kandung Kemih: Dinding kandung kemih mungkin mengalami edema dan hiperemia, yang sering kali menyebabkan retensi urin karena hilangnya sensasi ingin berkemih atau trauma jalan lahir.

Kriteria Abnormalitas (*Red Flags*):

Ketidakmampuan untuk berkemih pada ibu pasca persalinan meskipun kandung kemih terasa penuh menjadi salah satu tanda bahaya yang memungkinkan. Adanya masalah klinis berupa retensi urin akibat trauma jalan lahir atau edema uretra.

5. Sistem Gastrointestinal dan Integumen

a. Pencernaan: Konstipasi sering terjadi karena penurunan peristaltik usus akibat pengaruh progesteron, kehilangan cairan, dan nyeri perineum. Gejala refluks asam biasanya membaik dalam 3-4 hari setelah kadar progesteron turun.
b. Kulit: Hiperpigmentasi seperti melasma dan linea nigra biasanya akan memudar dalam 6-8 minggu. Otot abdomen yang meregang akan kembali kencang dalam 6-8 minggu, meskipun *striae* (*stretch marks*) mungkin tidak hilang sepenuhnya.

6. Perubahan Umum dan Tanda Vital

a. Suhu: Suhu tubuh dapat sedikit meningkat hingga 37,2°C dalam 24 jam pertama karena metabolisme otot, namun kenaikan suhu setelah hari ketiga biasanya menandakan adanya infeksi.
b. Berat Badan: Penurunan berat badan langsung sekitar 5-6 kg terjadi akibat keluarnya janin dan plasenta, diikuti penurunan 2-3 kg tambahan melalui proses diuresis.

Implikasi Klinis:

Ibu akan kehilangan berat badan sekitar 5–6 kg segera setelah persalinan akibat keluarnya janin, plasenta, dan darah. Penurunan 2–3 kg berikutnya terjadi melalui proses diuresis (pengeluaran urin berlebih) yang bisa mencapai 3000 cc per hari pada dua minggu pertama

Kriteria Abnormalitas (*Red Flags*):

Kondisi suhu tubuh dengan >37,2 °C yang menetap dan/atau melampaui hari ke-3, maka dapat memungkinkan hal tersebut sebagai masalah klinis yang perlu diperhatikan (Chauhan & Tadi, 2026a; Gil et al., 2025).

C. Perubahan Hormon Masa Nifas

1. Penurunan Hormon Plasenta

Segera setelah plasenta dilahirkan, terjadi penurunan drastis pada hormon-hormon yang diproduksi oleh organ tersebut, yaitu *Human Chorionic Gonadotropin* (HCG), *Human Placental Lactogen* (HPL), estrogen, dan progesterone (Westrepp & Huesped, 2025). Kadar HCG menurun dengan sangat cepat dan menetap hanya sekitar 10% dalam waktu 3 jam hingga hari ke-7 pascapersalinan. Penurunan HPL juga berimplikasi pada metabolisme ibu, di mana kadar gula darah cenderung menurun selama masa nifas sebagai akibat dari hilangnya efek antagonis insulin dari hormon tersebut (Chauhan & Tadi, 2026).

2. Dinamika Estrogen dan Progesteron

Kadar estrogen dan progesteron dalam sirkulasi darah menurun secara tajam segera setelah melahirkan. Penurunan estrogen bertanggung jawab atas terjadinya diuresis nifas, yaitu mekanisme tubuh untuk membuang kelebihan cairan yang tertimbun selama kehamilan. Di sisi lain, hilangnya progesteron memengaruhi tonus otot polos, yang berdampak pada perubahan fungsi saluran kemih, usus, hingga dinding vena. Secara psikologis, penurunan tajam estrogen dan progesteron serta rendahnya kadar estriol dianggap sebagai faktor hormonal utama yang memicu gangguan suasana hati seperti *postpartum blues*, karena estrogen memiliki peran dalam menekan aktivitas enzim yang mengatur dopamin dan serotonin di otak (Chauhan & Tadi, 2026).

3. Peran Oksitosin dalan Involusi Uteri

Hormon oksitosin berperan krusial dalam proses involusi uterus, yaitu kembalinya rahim ke bentuk dan ukuran semula setelah persalinan. Berikut adalah mekanisme kerja oksitosin dalam mempercepat proses tersebut (Chauhan & Tadi, 2026):

a. Pemicu Pelepasan Oksitosin: Hormon ini diproduksi di hipotalamus dan disimpan serta dilepaskan oleh kelenjar hipofisis posterior ke dalam aliran darah. Pelepasan ini dipicu oleh rangsangan saraf, seperti isapan bayi pada puting susu (*refleks let-down*) atau melalui stimulasi fisik seperti pijat oksitosin di sepanjang tulang belakang.
b. Kontraksi Otot Miometrium: Setelah masuk ke aliran darah dan sampai ke rahim, oksitosin bekerja langsung pada otot polos uterus (miometrium) dengan cara mengikat reseptor khusus. Hal ini memicu kontraksi dan retraksi (pemendekan permanen) serat-serat otot rahim.
c. Mekanisme Hemostatis: Kontraksi dan retraksi otot rahim yang kuat berfungsi seperti "penjepit" alami yang menekan pembuluh darah pada lokasi bekas implantasi plasenta. Proses ini membantu menghentikan perdarahan postpartum dan secara bertahap memperkecil volume rahim.

d. Proses Involusi: Melalui kontraksi yang terus-menerus, teratur dan sering dirasakan ibu sebagai nyeri mulas atau *afterpains* maka pada fase tersebut jaringan rahim akan mengalami pengecilan ukuran secara progresif. Hal ini menyebabkan tinggi fundus uteri (TFU) menurun sekitar 1–2 cm setiap harinya hingga tidak lagi teraba di atas simfisis setelah sekitar 12 hari postpartum.

Aktivitas pendukung seperti senam nifas atau yoga postpartum juga dapat meningkatkan efektivitas involusi karena gerakan fisik tertentu mampu memengaruhi elastisitas otot dan merangsang pelepasan oksitosin secara lebih optimal (Ruan et al., 2025; Victoria & Yanti, 2021a).

Setelah keluarnya plasenta, tubuh ibu nifas mengalami transisi endokrinologi yang sangat drastis, di mana kadar hormon-hormon yang menyokong kehamilan menurun secara tajam untuk memulai proses pemulihan organ reproduksi dan inisiasi laktasi. Perubahan ini melibatkan interaksi kompleks antara hormon plasenta, kelenjar hipofisis, dan ovarium yang memengaruhi aspek fisik maupun psikologis ibu.

4. Peran Prolaktin dan Oksitosin dalam Laktasi

Selama kehamilan, prolaktin dihambat oleh estrogen dan progesteron yang tinggi, namun setelah persalinan, hilangnya hambatan ini memungkinkan prolaktin bekerja secara efektif merangsang sel-sel alveoli payudara untuk memproduksi ASI. Pada ibu yang menyusui, kadar prolaktin tetap tinggi karena distimulasi oleh isapan bayi pada puting susu yang mengirimkan sinyal ke hipotalamus. Sebaliknya, pada ibu yang tidak menyusui, kadar prolaktin akan kembali normal dalam waktu 2 hingga 3 minggu pascapersalinan (Eker & Aslan, 2024).

Hormon oksitosin disekresikan oleh hipofisis posterior dan memainkan peran ganda yang krusial. Oksitosin bekerja pada otot polos uterus untuk merangsang kontraksi dan retraksi, yang sangat penting bagi proses involusi uterus serta pencegahan perdarahan postpartum dengan cara menjepit pembuluh darah di tempat implantasi plasenta. Selain itu, oksitosin berperan dalam *let-down reflex*, di mana hormon ini memicu kontraksi sel mioepitel di sekitar alveoli payudara sehingga ASI dapat memancar keluar menuju mulut bayi (Ernstmeyer & Christman, 2025; Haider, 2023; Selçuk et al., 2025).

5. Aktivitas Hormon Pituitari dan Ovarium (FSH dan LH)

Kadar hormon *Follicle Stimulating Hormone* (FSH) dan *Luteinizing Hormone* (LH) biasanya mulai meningkat pada fase konsentrasi folikuler sekitar minggu ketiga setelah melahirkan. Namun, pada wanita yang menyusui secara eksklusif, kadar prolaktin yang tinggi dapat menghambat respons ovarium terhadap FSH

dan menekan pelepasan LH, sehingga menunda kembalinya siklus menstruasi dan ovulasi. Pada wanita yang tidak menyusui, sekitar 40% akan mulai mendapatkan menstruasi kembali pada 6 minggu pascapersalinan, sementara pada wanita menyusui, persentase tersebut hanya berkisar 16% pada waktu yang sama (Ernstmeyer & Christman, 2025; Haider, 2023).

D. Kebutuhan Dasar Masa Nifas

Pemenuhan kebutuhan dasar yang adekuat merupakan fondasi pemulihan fisik dan keberhasilan laktasi primer.

1. Nutrisi

Kebutuhan energi ibu menyusui meningkat secara signifikan untuk mendukung pemulihan jaringan dan produksi ASI matur.

a. Kebutuhan Energi: Ibu memerlukan tambahan asupan energi sebesar 500 kkal/hari di atas kebutuhan normalnya (Arumndari, 2025).
b. Komponen Penting:
    1) Protein Tinggi: Konsumsi protein hewani, khususnya telur rebus, terbukti secara signifikan mempercepat penyembuhan luka jahitan perineum (selisih hingga 1,35 hari lebih cepat dibandingkan tanpa konsumsi rutin) (Marshall et al., 2022).
    2) Mikronutrien: Tablet zat besi (Fe) minimal selama 40 hari untuk mencegah anemia, serta Vitamin A (200.000 unit) untuk meningkatkan kualitas ASI bagi bayi (Marshall et al., 2022).
c. Catatan Praktik: Budaya "tarak" atau pantangan makanan (seperti dilarang makan ikan atau telur karena dianggap membuat luka gatal/bau) tidak memiliki dasar ilmiah. Pembatasan ini justru menghambat asupan nutrisi yang dibutuhkan dan harus dikoreksi melalui edukasi yang persuasive (Arumndari, 2025).

2. Cairan

Status hidrasi ibu berkorelasi langsung dengan volume ASI yang disekresi. Komposisi ASI sebagian besar (85-95%) adalah air, sehingga dehidrasi ringan sekalipun dapat menurunkan output ASI.

a. Rekomendasi: Ibu dianjurkan minum minimal 3 liter per hari atau 8–12 gelas.
b. Indikator Hidrasi Adekuat: Urin berwarna jernih, frekuensi buang air kecil (BAK) normal, dan tidak adanya keluhan haus yang menetap (Marshall et al., 2022).

3. Eliminasi

Gangguan eliminasi sering ditemukan pada fase awal nifas akibat trauma jalan lahir atau pengaruh hormonal (Mohr et al., 2022).

a. Buang Air Kecil (BAK): Terjadi peningkatan diuresis pada hari ke-2 hingga ke-4 postpartum karena tubuh membuang kelebihan cairan ekstraseluler selama hamil. Penahanan BAK akibat nyeri luka jahitan harus dihindari karena kandung kemih yang penuh dapat menghambat kontraksi uterus (atonia) (Polat et al., 2018).
b. Buang Air Besar (BAB): Konstipasi sering terjadi karena penurunan motilitas usus selama persalinan dan rasa takut ibu jika jahitan perineum terbuka.
c. Intervensi: Mobilisasi dini (2 jam pascapersalinan normal), peningkatan asupan serat, dan teknik relaksasi sangat efektif untuk merangsang peristaltik usus kembali normal (Mohr et al., 2022).

4. Istirahat dan Kesehatan Psikologis

Keseimbangan antara istirahat fisik dan stabilitas mental sangat memengaruhi keberlangsungan peran baru ibu.

a. Kaitan Laktasi: Kurang tidur meningkatkan kadar kortisol (hormon stres) yang secara langsung menghambat refleks oksitosin, sehingga produksi ASI menurun.
b. Risiko *Postpartum Blues*: Sekitar 80% perempuan mengalami gangguan suasana hati ringan pada minggu pertama yang ditandai dengan perasaan sedih, mudah menangis, dan cemas. Jika menetap lebih dari 2 minggu, kondisi ini dapat berkembang menjadi depresi pascasalin.
c. Peran Bidan: Bidan harus melakukan skrining psikologis awal dan mendorong keterlibatan keluarga untuk berbagi tugas domestik, sehingga ibu dapat tidur saat bayi tidur. Penggunaan terapi komplementer seperti pijat endorphin juga direkomendasikan untuk meningkatkan ambang relaksasi dan kenyamanan ibu (Ernstmeyer & Christman, 2025; Nagel et al., 2022).

E. Pemeriksaan Fisik dan Tanda Bahaya

Pemeriksaan fisik pada ibu nifas dilakukan secara berkesinambungan melalui empat kali kunjungan nifas untuk memantau pemulihan fisik dan mendeteksi komplikasi secara dini (Adams et al., 2023; Ughul & Sutarno, 2024).

Tabel 4.1 Frekuensi Kunjungan Nifas

Kunjungan	Waktu Kunjungan	Tindakan
KF 1	6 jam – 3 hari setelah persalinan	• Menilai kondisi umum ibu dan bayi • Memastikan perdarahan tidak berlebihan • Memantau kontraksi uterus

		• Mengajari dan mengevaluasi pemberian ASI/menyusui oleh ibu ke bayinya.
KF 2	Hari ke-4 – ke-28 setelah persalinan	• Menilai proses involusi uterus • Mengevaluasi kondisi luka perineum/SC, produksi ASI, pemberian asi/menyusui oleh ibu, dan adaptasi ibu terhadap bayi.
KF 3	Hari ke-29 – ke-42 setelah persalinan	• Memastikan pemulihan organ reproduksi • Mengevaluasi keberlanjutan menyusui dan pemberian ASI • Memberikan konseling KB pasca persalinan.
KF 4	Dilakukan bila ditemukan masalah atau komplikasi (sebagai kunjungan tambahan sesuai kebutuhan)	

Sumber: (Adams et al., 2023; Kementrian Kesehatan RI, 2020)

1. Pendekatan Pemeriksaan Sistematis

Pendekatan yang digunakan adalah pemeriksaan *head-to-toe* dengan fokus klinis pada adaptasi puerperium:

a. Tanda-Tanda Vital:
   1) Suhu: Deteksi dini infeksi sangat bergantung pada pemantauan suhu. Peningkatan suhu hingga 38°C dalam 24 jam pertama mungkin akibat dehidrasi, namun jika menetap atau melebihi 38°C setelah 24 jam, hal ini menjadi indikator kuat adanya infeksi puerperal.
   2) Tekanan Darah: Evaluasi tekanan darah sangat penting untuk mendeteksi hipertensi pascasalin atau preeklamsia postpartum, meskipun kondisi ini lebih jarang terjadi dibandingkan masa kehamilan.
b. Abdomen: Fokus utama adalah menilai involusi uteri. Tinggi Fundus Uteri (TFU) harus turun secara gradual (1-2 cm/hari) dan kontraksi uterus harus teraba keras untuk menjamin hemostasis. Adanya nyeri tekan abdomen yang ekstrem di luar nyeri kontraksi normal (*afterpains*) perlu diwaspadai sebagai tanda endometritis.
c. Perineum: Pemeriksaan dilakukan untuk menilai penyembuhan luka episiotomi atau laserasi. Bidan harus memantau tanda-tanda infeksi menggunakan parameter REEDA (*Redness, Edema, Ecchymosis, Discharge, Approximation*). Ibu disarankan tidak menyentuh luka secara langsung untuk mencegah kontaminasi kuman.

d. Payudara: Penilaian meliputi adanya pembengkakan (*engorgement*), kondisi puting (menonjol, datar, atau terbenam), serta identifikasi dini adanya lecet atau retakan yang dapat menjadi pintu masuk bakteri penyebab mastitis.

2. Tanda Bahaya yang Memerlukan Tindakan Segera

Dalam praktik klinik, bidan harus menerapkan prinsip kewaspadaan tinggi. Berikut adalah tanda bahaya utama yang memerlukan eskalasi medis segera:

Tabel 4.2 Tanda Bahaya Dalam Masa Nifas

Tanda Bahaya	Kemungkinan Masalah Klinis	Tindakan Prioritas
Perdarahan hebat (ganti pembalut 2x dalam 30 menit)	Atonia uteri atau sisa plasenta	Masase fundus, pasang infus, siapkan rujukan
Demam tinggi (>38ºC) disertai lochea berbau busuk	Infeksi puerperal / Endometritis	Stabilisasi, antibiotik sesuai wewenang, kolaborasi
Nyeri, merah, atau bengkak pada betis secara unilateral	Tromboflebitis / Trombosis Vena Dalam	Hindari masase kaki, imobilisasi, rujukan segera
Sakit kepala hebat, pandangan kabur, bengkak di wajah	Preeklamsia pascasalin	Pantau tekanan darah ketat, cegah kejang, rujukan
Rasa sedih ekstrem, tidak mau merawat bayi	Depresi nifas berat	Skrining psikologis, dukungan keluarga, kolaborasi

Sumber: (Kementrian Kesehatan RI, 2020)

F. Jadwal Kunjungan Masa Nifas (KF)

Sesuai dengan program nasional, ibu nifas setidaknya mendapatkan 4 kali kunjungan (Kementrian Kesehatan RI, 2020):

Tabel 4.4 Jadwal kunjungan Nifas

KF 1 (6–48 jam PP)	Mencegah perdarahan, deteksi atonia uteri, pemberian ASI awal (IMD), dan pencegahan hipotermi pada bayi.
KF 2 (3–7 hari PP)	Memastikan involusi uterus normal, nutrisi cukup, dan ibu menyusui dengan baik.
KF 3 (8–28 hari PP)	Mengevaluasi adanya penyulit laktasi dan pemulihan fisik ibu.
KF 4 (29-42 Hari PP)	Konseling Keluarga Berencana (KB) secara dini dan

	evaluasi akhir masa nifas.

Sumber: (Kementrian Kesehatan RI, 2020)

G. Asuhan Kebidanan Masa Nifas

1. Perawatan Payudara

Selain makanan, emosi atau kondisi mental seorang ibu, faktor isapan atau teknik menyusui, produksi ASI juga dipengaruhi oleh bagaimana perawatan payudara ibu yang fungsinya merangsang payudara sehingga mempengaruhi hipofisis untuk mengeluarkan hormon prolaktin dan oksitosin. Perawatan ini juga berperan penting dalam mencegah bendungan ASI dan mendukung keberhasilan menyusui secara eksklusif. Dan tidak disarankan jika dilakukan pada Ibu yang mengalami luka terbuka di sekitar payudara, benjolan nyeri, dan infeksi pada payudara. Perawatan payudara dapat dilakukan mulai hari ke-1 setelah melahirkan, dengan minimal 2 kali sehari selama 30 menit (Modak et al., 2023).

Tujuan *Breast Care*:

a. Menjaga kebersihan payudara
b. Melenturkan puting
c. Melancarkan aliran dan produksi ASI
d. Mencegah bendungan serta infeksi
e. Memperbaiki sirkulasi darah, dan
f. Mempertahankan bentuk payudara agar tetap baik (Modak et al., 2023; Mustikawati et al., 2026).

2. Pijat Limfatik

Pijat Limfatik adalah Teknik pijatan dan pengaliran getah bening yang efektif untuk mengatasi pembengkakan payudara (*engorgement*) dan peradangan payudara (*mastitis*). Pada payudara dengan bendungan ASI atau mastitis ringan, pijat limfatik membantu mengalirkan cairan berlebih, melancarkan ASI, mengurangi nyeri dan inflamasi, serta mencegah progresi ke abses. Sehingga apabila terjadi mastitis, sebaiknya tidak dilakukan *breastcare* atau pijat oksitosinl, namun dapat dilakukan pijat limfatik ini. Karena *breast care* atau pijat oksitosin, dapat menyebabkan ASI akan semakin deras dan mastitis tidak akan reda. Catatan Penting yang harus diperhatikan yaitu, bahwa pijat limfatik: Hanya ilakukan bila tidak ada luka terbuka atau abses. Tekanan pijatan harus lembut dan mengikuti arah aliran limfa (ke ketiak atau ke atas dada), bukan menekan keras putting (Louis-Jacques & Stuebe, 2020; Mitchell et al., 2022).

3. SPEOS (*Stimulasi Pijat Endorphin, Oksitosin, dan Sugestif*)

Metode **SPEOS** merupakan intervensi gabungan yang bekerja melalui stimulasi fisik dan psikologis untuk mengaktifkan hormon-hormon krusial dalam

proses laktasi, yaitu endorfin, prolaktin, dan oksitosin. Secara klinis, metode ini terbukti efektif dalam meningkatkan kelancaran produksi ASI, mempercepat proses involusi uterus, serta memberikan rasa nyaman bagi ibu nifas. Berikut adalah komponen dan langkah-langkah pelaksanaannya (Pramesti et al., 2022):

Komponen Utama Metode SPEOS:

a. Pijat Oksitosin: Tindakan ini melibatkan pemijatan di sepanjang kedua sisi tulang belakang, mulai dari vertebrae servikal ke-7 (C7) hingga tulang rusuk ke-6 (T6). Stimulasi pada saraf parasimpatis di area ini mengirimkan sinyal ke hipotalamus untuk memicu hipofisis posterior melepaskan hormon oksitosin. Oksitosin kemudian merangsang kontraksi sel mioepitel di kelenjar susu, yang memicu *let-down reflex* atau pemancaran ASI. Selain itu, pijat ini juga merangsang hipofisis anterior untuk mengeluarkan hormon prolaktin guna meningkatkan volume produksi ASI.
b. Pijat Endorfin (*Endorphin Massage*): Merupakan teknik sentuhan ringan yang dilakukan pada leher, lengan, dan punggung untuk merangsang hipotalamus melepaskan hormon endorfin. Endorfin berfungsi sebagai penenang alami dan penghilang rasa sakit (*analgesik*) yang membantu ibu merasa rileks. Kondisi yang rileks ini secara tidak langsung mendukung kerja hormon oksitosin dan menurunkan kadar hormon stres (kortisol/ACTH) dalam darah.
c. Sugestif (Afirmasi Positif): Komponen ini bertujuan untuk menanamkan keyakinan dan ketenangan jiwa pada ibu nifas. Melalui pemberian kalimat-kalimat motivasi, ibu dapat memfokuskan pikiran pada hal-hal positif, meningkatkan kepercayaan diri, dan membangun niat yang kuat untuk menyusui secara eksklusif (Puspitasari et al., 2025; R et al., 2023; Widiantari et al., 2023).

Tahap Pelaksanaan:

a. Sugesti Positif: Mulailah memasukkan kalimat afirmasi seperti: *"Relaksasi ini membuat saya tenang dan damai. Saya mampu menyusui dan merawat bayi dengan mudah dan bahagia, ASI saya melimpah"*.
b. Pijat Endorfin: Sambil proses relaksasi mata, lakukan pijatan ringan dimulai dari leher ke arah samping lengan tangan kiri dan kanan, lalu ulangi pada punggung atas. Lakukan sebanyak 3-4 kali untuk memastikan ibu tetap fokus dan rileks.
c. Identifikasi Titik Oksitosin: Temukan tonjolan tulang di bagian belakang leher (processus spinosus/vertebrae C7). Bayangkan sebuah garis imajiner sepanjang tulang belakang, lalu tarik garis tersebut ke kiri dan kanan masing-masing sekitar 1 cm.

d. Pijat Oksitosin Tahap 1: Mulai pemijatan dari atas dengan kedua ibu jari pada garis imajiner tersebut dengan gerakan memutar kecil-kecil hingga ke arah pinggang. Ulangi proses ini minimal dua kali.
e. Pijat Oksitosin Tahap 2: Sambil terus memberikan sugesti, ganti teknik pijatan menggunakan ruas buku jari telunjuk yang kedua pada area yang sama (C7 ke T6).
f. Pijat Oksitosin Tahap 3: Ganti lagi pijatan dengan kepalan tangan yang bergerak naik-turun secara berlawanan antara sisi kiri dan kanan.
g. Evaluasi: Amati respons ibu selama tindakan; seluruh rangkaian pemijatan dilakukan selama kurang lebih 15 menit (Mona et al., 2025).

4. Akupresur

Akupresur merupakan teknik pelayanan kesehatan alternatif yang dilakukan dengan memberikan tekanan pada titik-titik meridian tertentu menggunakan jari tangan atau benda tumpul untuk menyeimbangkan bioenergi tubuh. Pada ibu nifas, stimulasi ini bertujuan untuk melancarkan sirkulasi darah, menurunkan rasa nyeri, serta merangsang sistem hormonal guna mendukung pemulihan pascapersalinan.

Prinsip dasar akupresur serupa dengan akupunktur, yaitu menyeimbangkan interaksi antara Yin, Yang, dan Qi melalui stimulasi pada sistem meridian. Secara klinis, penekanan pada titik akupresur akan merangsang saraf perifer yang terhubung langsung dengan sistem saraf pusat dan kelenjar hipofisis. Respons dari stimulasi ini memicu hipofisis anterior untuk meningkatkan sekresi hormon prolaktin guna memproduksi ASI di kelenjar alveoli, serta memicu hipofisis posterior untuk melepaskan hormon oksitosin yang bertanggung jawab atas *let-down reflex* atau pemancaran ASI. Selain itu, akupresur meningkatkan kadar endorfin sistemik yang berfungsi sebagai opiat alami tubuh untuk mengurangi rasa sakit dan menciptakan efek relaksasi yang mendalam (Pujiastuti & Winarni, 2025).

Pelaksanaan akupresur harus dilakukan dalam kondisi ibu yang rileks dengan durasi sekitar 1–2 menit per titik, dilakukan dua kali sehari selama dua minggu. Berikut adalah titik-titik krusial untuk mendukung kelancaran ASI (Diaris & Dewi, 2025; Pujiastuti & Winarni, 2025; Shofiyana & Kustiyati, 2025):

a. ST 15, 16, 18: Terletak di area payudara (di atas, samping, dan bawah areola) untuk memperlancar aliran susu secara lokal.
b. ST 36: Terletak di bawah lutut, berfungsi untuk meningkatkan energi tubuh dan melancarkan sirkulasi menuju kelenjar payudara.
c. CV 17: Berada di tengah tulang dada (sternum), efektif untuk mengurangi stres dan sumbatan pada payudara.

d. SI 1: Terletak di ujung kuku jari kelingking, merupakan titik spesifik untuk memicu produksi ASI.
e. LI 4: Terletak di antara telunjuk dan ibu jari, berfungsi untuk merelaksasi tubuh dan merangsang hormon oksitosin.
f. BL 15-17: Titik di sepanjang tulang belakang yang memiliki lokasi serupa dengan titik pijat oksitosin (C7 hingga T6).

5. Pijat Nifas

Pijat nifas merupakan terapi kesehatan yang dilakukan dengan memberikan tekanan pada area tubuh tertentu secara terstruktur guna meningkatkan relaksasi dan mempercepat proses pemulihan ibu setelah melahirkan. Asuhan komplementer ini bertujuan untuk menyeimbangkan kondisi fisik dan psikologis ibu yang mengalami transisi besar pascapersalinan (Yamasaki et al., 2026).

Secara fisiologis, pijatan pada punggung dan area tubuh lainnya akan menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah, yang secara langsung memperbaiki sirkulasi nutrisi dan oksigen ke seluruh jaringan. Hal ini diikuti dengan relaksasi otot-otot yang tegang akibat proses persalinan. Di tingkat sistem saraf pusat, pijat merangsang otak untuk melepaskan neurotransmiter yang memperbaiki suasana hati dan kenyamanan psikologis ibu secara menyeluruh (Yamasaki et al., 2026).

Pemberian pijat pada masa nifas memberikan berbagai manfaat klinis, di antaranya (Chen et al., 2024; Yamasaki et al., 2026):

a. Relaksasi Sistemik: Membantu merelaksasi tubuh sehingga denyut jantung dan tekanan darah bekerja secara normal.
b. Regulasi Hormonal: Menurunkan kadar hormon stres (kortisol) dan meningkatkan hormon endorfin serta serotonin yang menghadirkan rasa nyaman dan ketenangan jiwa.
c. Stimulasi Laktasi dan Involusi: Meningkatkan produksi hormon oksitosin yang memicu kontraksi rahim (dapat mencegah perdarahan) serta melancarkan refleks pengeluaran ASI (*let-down reflex*).
d. Kesehatan Fisik dan Mental: Mengurangi nyeri punggung, kelelahan fisik, serta menurunkan risiko terjadinya gangguan psikologis seperti *postpartum blues*.
e. Sirkulasi dan Imunitas: Melancarkan peredaran darah, menjaga kondisi sendi, dan meningkatkan kinerja daya tahan tubuh.

6. Yoga

Yoga nifas merupakan serangkaian latihan fisik yang mengintegrasikan gerakan tubuh (*asana*), pengendalian napas (*pranayama*), dan teknik relaksasi yang dirancang khusus untuk memfasilitasi masa transisi ibu setelah persalinan. Praktik ini berakar dari disiplin kuno yang bertujuan menciptakan keseimbangan

harmonis pada dimensi fisik, mental, emosional, dan spiritual individu. Melalui penyatuan jiwa dan pikiran, yoga membantu ibu nifas mengendalikan panca indra dan anggota badan guna mencapai kebugaran total di tengah tantangan peran baru sebagai orang tua (Fatimah et al., 2024; Meilani & Putri, 2024).

Secara fisiologis, yoga nifas bekerja sebagai akselerator pemulihan tubuh dengan menstimulasi pelepasan hormon oksitosin dan endorfin. Stimulasi hormonal ini sangat krusial untuk memastikan kontraksi rahim berjalan optimal guna mendukung proses involusi uterus serta memicu *let-down reflex* pada laktasi. Selain itu, gerakan peregangan dalam yoga membantu mengembalikan elastisitas otot dan sendi yang meregang selama kehamilan, sementara teknik pernapasan (*pranayama*) meningkatkan oksigenasi jaringan dan memperkuat daya tahan tubuh (Chauhan & Tadi, 2026a; Tonasih, 2023; Wulandari et al., 2024).

Tujuan utama dari intervensi yoga pada periode *puerperium* mencakup aspek pemulihan organ dan kesejahteraan mental. Secara fisik, latihan ini memperkuat otot-otot panggul, punggung, dan perut, serta melancarkan sirkulasi darah sistemik. Dari perspektif psikologis, yoga nifas terbukti efektif dalam menenangkan pikiran, mereduksi tingkat stres dan kecemasan, serta meningkatkan kualitas tidur yang sering kali terganggu pascapersalinan. Keberhasilan dalam menjaga kestabilan emosi ini berperan penting dalam mencegah terjadinya *postpartum blues* dan depresi nifas (Fatimah et al., 2024; Wulandari et al., 2024).

Latihan ini sangat diindikasikan bagi ibu yang mengalami keluhan nyeri punggung bawah (*low back pain*), gangguan tidur, atau hipertensi ringan. Namun, bidan dan tenaga kesehatan harus memperhatikan beberapa kontraindikasi absolut, seperti suhu tubuh di atas 38°C, gejala syok kardiogenik, gagal jantung yang belum stabil, serta riwayat persalinan kurang dari 2 bulan jika terdapat komplikasi tertentu. Keamanan pasien tetap menjadi prioritas utama sebelum memulai rangkaian gerakan fisik apa pun (Fatimah et al., 2024; Idhayanti et al., 2020).

Persiapan pelaksanaan yoga nifas meliputi pemilihan pakaian yang nyaman, penggunaan matras yoga, serta penciptaan lingkungan yang tenang dengan cahaya redup guna mendukung suasana meditatif. Penggunaan wewangian aromaterapi dapat menjadi opsi tambahan untuk memperdalam relaksasi. Langkah kerja dimulai dengan *pranayama* seperti *Nadi Shodhana* (pernapasan hidung bergantian) untuk menurunkan tekanan darah dan *Bhramari* (suara lebah) untuk meredakan stres, diikuti oleh gerakan inti seperti *Adho Mukha Svanasana* untuk otot punggung dan *Bridge Pose* untuk fleksibilitas tulang belakang (Fatimah et al., 2024; Tonasih, 2023)

Rangkaian gerakan diakhiri dengan posisi relaksasi seperti *Balasana* (Child's Pose) untuk peregangan lembut pada pinggul dan *Side Lying Savasana* (posisi berbaring miring) untuk memulihkan energi tubuh sepenuhnya. Gerakan seperti *Seated Side Bend* dan *Janu Sirsasana* juga dapat diintegrasikan untuk melenturkan sisi tubuh serta melancarkan sistem pencernaan. Dengan melakukan yoga secara teratur, ibu nifas tidak hanya mendapatkan kembali kekuatan fisiknya, tetapi juga membangun kepercayaan diri yang lebih besar dalam merawat buah hatinya (Fatimah et al., 2024; Pujiastuti & Winarni, 2025).

7. Senam Nifas

Senam nifas merupakan serangkaian latihan fisik fungsional yang dilakukan oleh ibu segera setelah melahirkan. Fokus utama dari latihan ini adalah untuk memulihkan kondisi tubuh secara bertahap, mempercepat proses involusi uterus (kembalinya rahim ke bentuk semula), serta memperlancar pengeluaran lochea (Victoria & Yanti, 2021b). Selain aspek pemulihan organ reproduksi, senam ini dirancang untuk memperkuat otot-otot panggul, perut, dan punggung yang telah mengalami peregangan maksimal selama masa kehamilan dan proses persalinan (Mindarsih & Pattypeilohy, 2020).

Implementasi senam nifas secara teratur memberikan dampak signifikan terhadap kesehatan fisik maupun psikologis ibu. Secara fisiologis, gerakan-gerakan dalam senam nifas memicu kontraksi pada otot dinding perut yang secara mekanis membantu fundus uteri turun lebih cepat ke posisi asalnya. Selain itu, latihan ini berfungsi memperbaiki sirkulasi darah sistemik, yang berperan vital dalam mencegah komplikasi serius seperti trombosis vena (penyumbatan pembuluh darah) dan varises (Kuswanti & Retno, 2021).

Dari aspek pemulihan muskuloskeletal, senam nifas membantu mengencangkan kembali sendi-sendi yang melonggar dan meredakan keluhan fisik umum seperti kram kaki serta nyeri punggung bawah (Kuswanti & Retno, 2021). Secara psikologis, aktivitas fisik rutin ini terbukti efektif dalam menurunkan gejala depresi postpartum dan membantu ibu merasa lebih segar serta percaya diri dalam menjalani peran barunya.

Meskipun memberikan banyak manfaat, tidak semua ibu nifas dapat langsung melakukan latihan fisik ini. Senam nifas sangat dianjurkan bagi ibu dengan persalinan normal yang kondisinya stabil (Zubaida et al., 2021; Kuswanti & Retno, 2021). Idealnya, senam nifas dapat dimulai dalam waktu 24 jam pascapersalinan, dengan catatan kondisi umum ibu dalam keadaan baik dan stabil (Rohmawati, 2023). Latihan dilakukan secara berkesinambungan setiap hari, baik pada pagi maupun sore hari. Sangat disarankan untuk menghindari latihan

saat ibu merasa sangat lapar atau sesaat setelah makan besar guna menghindari ketidaknyamanan pencernaan (Rohmawati, 2023).

Persiapan sebelum memulai latihan meliputi penggunaan pakaian yang berbahan kaos dan longgar agar tidak menghambat pernapasan dan gerak. Ibu juga dianjurkan untuk mencukupi kebutuhan hidrasi (air putih) serta melakukan latihan di atas permukaan yang rata seperti matras atau tempat tidur yang cukup keras.

Rangkaian gerakan dilakukan secara bertahap, mulai dari pernapasan sederhana hingga penguatan otot inti (Malisa, 2024; Victoria & Yanti, 2021b):

a. Hari Pertama (Latihan Pernapasan): Berbaring terlentang dengan lutut ditekuk dan tangan di atas perut. Tarik napas dalam melalui hidung, tahan selama 5-8 detik, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Latihan ini bertujuan meningkatkan oksigenasi jaringan dan memulai sirkulasi yang baik.
b. Hari Kedua (Otot Lengan dan Ekstremitas): Berbaring terlentang dengan kedua tangan di atas kepala. Regangkan lengan kanan dan kaki kanan secara bersamaan, lalu bergantian dengan sisi kiri. Latihan ini membantu memulihkan tonus otot lengan.
c. Hari Ketiga (Otot Dasar Panggul): Melakukan latihan kontraksi otot vagina dan anus (seperti menahan kencing) selama 3 detik kemudian rileks. Fokus utama adalah memperkuat otot-otot dasar panggul yang bekerja keras selama persalinan.
d. Hari Keempat (Otot Punggung): Berbaring dengan lutut ditekuk, kencangkan otot perut hingga punggung rata menyentuh lantai, serta kencangkan otot bokong (*glutes*) selama 3 detik. Hal ini efektif meredakan nyeri pinggang.
e. Hari Kelima (Otot Perut Atas): Mengangkat kepala dan bahu sekitar 45 derajat dari lantai sambil menahan napas selama 3 detik. Gerakan ini melatih koordinasi otot perut dan paha belakang.
f. Hari Keenam (Otot Kaki): Berbaring terlentang dengan kaki lurus, lalu tekuk lutut ke arah perut secara bergantian antara kaki kanan dan kiri. Latihan ini meningkatkan sirkulasi darah di area tungkai bawah.
g. Hari Ketujuh (Sirkulasi Kaki): Tidur terlentang dengan posisi kaki sedikit lebih tinggi dari badan. Gerakkan jari-jari kaki seperti mencakar dan meregang, serta gerakkan telapak kaki secara memutar. Latihan ini krusial untuk mengurangi risiko edema atau pembengkakan kaki.

8. Aromaterapi

Aromaterapi merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan alternatif dan terapi komplementer yang memanfaatkan minyak esensial dari bahan tanaman untuk meningkatkan kebugaran tubuh serta membantu proses

pemulihan medis. Masa nifas sering kali menghadirkan tantangan fisik dan psikologis bagi seorang ibu, termasuk risiko stres, kecemasan, kelelahan, hingga gangguan tidur akibat transisi peran baru. Melalui pendekatan holistik, aromaterapi bekerja memengaruhi suasana hati (*mood*), emosi, dan sistem hormonal untuk menciptakan keseimbangan antara tubuh (*body*), pikiran (*mind*), dan jiwa (*soul*) (Hedigan et al., 2023).

Secara fisiologis, mekanisme kerja aromaterapi dimulai saat molekul aroma ditangkap oleh reseptor di dalam hidung, yang kemudian mengirimkan informasi pesan neurologis ke area otak yang mengontrol emosi dan memori, seperti amigdala dan hipokampus. Informasi ini juga diteruskan ke hipotalamus, yang bertindak sebagai pengatur sistem internal tubuh, termasuk suhu tubuh, reaksi terhadap stres, serta sistem seksualitas. Selain itu, stimulasi ini memicu pelepasan neurotransmiter seperti endorfin dan ensefalin yang berfungsi sebagai pereda nyeri alami dan penenang, sehingga mampu mengubah persepsi ibu terhadap rasa sakit atau ketidaknyamanan fisik lainnya (Osaili et al., 2023; Song & Yang, 2022).

Efektivitas aromaterapi sangat bergantung pada teknik penggunaannya yang tepat, yang secara umum terbagi menjadi tiga metode utama. Metode inhalasi atau penghirupan, baik secara langsung maupun melalui bantuan alat seperti *diffuser*, memberikan efek relaksasi yang sangat cepat karena diserap langsung oleh alveoli paru-paru dan dialirkan ke susunan saraf pusat. Metode topikal dilakukan dengan mengoleskan minyak esensial melalui teknik pijatan yang membuat tubuh rileks dan segar, sementara penggunaan secara oral sangat terbatas dan memerlukan kehati-hatian ekstra karena tidak semua jenis minyak esensial aman untuk dikonsumsi (Hedigan et al., 2023; Widiantari et al., 2023).

Beberapa jenis minyak esensial memiliki manfaat spesifik yang sangat relevan untuk kebutuhan ibu postpartum (Caballero-Gallardo et al., 2025; Hedigan et al., 2023; Osaili et al., 2023):

a. Lavender Oil (*Lavandula Angustifolia*): Dikenal sebagai salah satu minyak paling aman, lavender mengandung komponen utama *linalool* dan *linalyl asetat* yang memiliki efek sedatif serta relaksasi otot. Penggunaannya terbukti efektif menurunkan tingkat kecemasan, meredakan stres, serta mengurangi intensitas nyeri perineum akibat laserasi atau episiotomi. Untuk aplikasi inhalasi, biasanya digunakan 5 tetes minyak dalam 30 ml air yang diuapkan selama 15 menit (Osaili et al., 2023).
b. Chamomile Oil: Minyak ini memiliki kandungan bahan metabolit sekunder berupa *flavonoid* dan *terpenoid* yang bersifat anti-inflamasi serta penenang saraf (*astringen*). Terapi dengan *chamomile* sangat disarankan untuk ibu yang

mengalami gangguan tidur atau kecemasan karena kandungan *triptofan*-nya mampu menciptakan rasa tenang dan memperbaiki kualitas istirahat malam (Osaili et al., 2023).

c. Lemon Oil (*Citrus Limonia*): Mengandung senyawa ester *linalil asetat* dan *sitral* yang berkhasiat menormalkan keadaan emosi yang tidak seimbang. Aromaterapi lemon bermanfaat sebagai analgesik dan penenang, sangat efektif untuk mengatasi nyeri perineum serta meningkatkan suasana hati ibu yang sering merasa sensitif pascapersalinan (Caballero-Gallardo et al., 2025).
d. Rose Oil: Dijuluki sebagai "Ratu Segala Bunga", minyak mawar mengandung *geraniol*, *sitronelol*, dan vitamin A-C yang berfungsi sebagai antiseptik dan peningkat gairah hidup. Stimulasi aroma mawar mampu merangsang produksi endorfin secara masif, menghadirkan rasa nyaman, bahagia, serta semangat yang mendukung keberhasilan proses laktasi (Hedigan et al., 2023).

Implementasi aromaterapi dalam asuhan kebidanan nifas juga berperan penting dalam mendukung keberhasilan pemberian ASI eksklusif. Kondisi prikologis ibu yang rileks dan bebas dari stress akan memunculkan hormon oksitosin dan prolaktin secara lebih optimal. Dengan demikian, aromaterapi tidak hanya membantu pemulihan fisik ibu, tetapi juga memperkuat ikatan kasih sayang (*bonding*) antara ibu dan bayi melalui peningkatan kenyamanan selama proses menyusui.

9. *Herbal Steam Bath*

Herbal Steam Bath, atau yang secara tradisional dikenal dengan berbagai istilah daerah seperti *Oukup* di Suku Karo, *Bakera* di Minahasa, hingga *Ba'ukup* di Maluku, merupakan terapi sauna tradisional menggunakan rebusan rempah alami yang telah lama menjadi bagian dari kearifan lokal perawatan pascapersalinan di Indonesia. Terapi ini bekerja dengan memanfaatkan energi panas uap untuk menghangatkan tubuh, mengeluarkan racun melalui keringat (detoksifikasi), serta memberikan efek relaksasi yang mendalam bagi ibu nifas. Penggunaan uap rempah ini tidak hanya sekadar tradisi, tetapi juga merupakan upaya holistik untuk mengembalikan kebugaran fisik dan ketenangan pikiran setelah proses persalinan yang menguras energi (Rhomadona & Primihastuti, 2022; Wakhidah & Silalahi, 2020).

Manfaat klinis dari mandi uap herbal ini sangat beragam, mulai dari peningkatan sirkulasi darah sistemik hingga stabilisasi tekanan darah. Secara fisiologis, paparan uap panas menyebabkan pembuluh darah mengalami vasodilatasi, yang kemudian meningkatkan aliran darah dan suplai oksigen ke seluruh jaringan lokal serta mengurangi kekakuan pada sendi. Bagi ibu nifas, peningkatan aliran darah ini memiliki dampak langsung terhadap stimulasi

hormon oksitosin dan prolaktin, dua hormon kunci yang berperan dalam kelancaran refleks pengeluaran ASI (*let-down reflex*) serta peningkatan volume produksi ASI (Rhomadona & Primihastuti, 2022).

Efektivitas terapi ini didukung oleh penggunaan berbagai tanaman herbal yang kaya akan senyawa bioaktif. Bahan-bahan seperti serai, daun jeruk purut, jahe, cengkeh, kayu putih, daun sirih, temulawak, kunyit, pala, dan lengkuas merupakan komponen utama yang sering digunakan. Tanaman-tanaman tersebut mengandung minyak atsiri, flavonoid, saponin, dan fenol yang memberikan khasiat antiseptik, anti-inflamasi, dan efek penghangat tubuh. Minyak atsiri yang menguap bersama air juga berfungsi sebagai aromaterapi alami yang merangsang sistem saraf pusat untuk mereduksi tingkat stres dan mencegah munculnya depresi postpartum (Mentari & Yuhaswita, 2022; Rhomadona & Primihastuti, 2022).

Dalam pelaksanaannya, metode tradisional dilakukan dengan cara merebus rempah hingga mendidih, lalu meletakkan wadahnya di bawah kursi tempat ibu duduk tanpa pakaian agar uap dapat terserap sempurna oleh pori-pori kulit, terutama di area perineum guna membantu pengeluaran sisa darah kotor. Tubuh ibu kemudian ditutup rapat menggunakan kain atau tikar untuk memastikan uap panas tidak keluar, dengan durasi terapi sekitar 15–20 menit setiap hari selama satu minggu. Sementara itu, pada metode yang lebih modern, terapi ini dilakukan di ruangan khusus dengan suhu antara 60–80°C selama 15–30 menit (Farlikhatun et al., 2025; Rhomadona & Primihastuti, 2022).

Meskipun memberikan banyak keuntungan, aspek keamanan pasien tetap harus diutamakan selama prosedur berlangsung. Ibu nifas sangat dianjurkan untuk mencukupi kebutuhan hidrasi dengan minum air putih yang banyak, baik sebelum maupun sesudah terapi, guna mencegah risiko dehidrasi akibat pengeluaran keringat yang masif. Terapi harus segera dihentikan apabila ibu mulai merasakan gejala pusing, mual, lemas, atau menggigil. Selain itu, bagi ibu yang memiliki riwayat penyakit jantung atau gangguan pernapasan, konsultasi dengan tenaga kesehatan sangat disarankan sebelum memulai rangkaian terapi mandi uap ini (Farlikhatun et al., 2025).

10. *Hypnobreastfeeding*

Hypnobreastfeeding merupakan salah satu teknik komplementer dalam asuhan kebidanan yang mengintegrasikan seni relaksasi dan pemberian sugesti positif untuk memaksimalkan proses laktasi. Berakar dari ilmu hipnostetri (penerapan hipnosis dalam lingkup kebidanan) metode ini berfokus pada pemberdayaan pikiran bawah sadar ibu agar merasa lebih tenang, percaya diri, dan yakin terhadap kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan nutrisi bayi.

Secara etimologis, istilah ini berasal dari bahasa Yunani *Hypnos* yang berarti tidur atau pikiran tenang, namun dalam praktiknya, ibu tidak benar-benar tidur melainkan berada dalam kondisi relaksasi mendalam di mana fungsi analisis logis pikiran direduksi (Nurhayati et al., 2024).

Mekanisme kerja hypnobreastfeeding didasarkan pada hubungan yang erat antara kondisi psikologis dengan sistem endokrin. Saat ibu memasuki kondisi hipnosis atau *hypnotic trance*, pikiran bawah sadar menjadi lebih terbuka terhadap afirmasi positif, seperti *"ASI saya cukup untuk bayi saya sesuai dengan kebutuhannya"*. Secara fisiologis, kondisi rileks ini menstimulasi otak untuk melepaskan neurotransmiter seperti endorfin dan ensefalin yang memperbaiki suasana hati (*mood booster*) serta menurunkan kadar hormon stres (kortisol). Penurunan stres ini sangat krusial karena hormon stres diketahui dapat menghambat kerja refleks oksitosin, sementara ketenangan jiwa akan memacu sekresi hormon prolaktin (untuk produksi susu) dan oksitosin (untuk pengeluaran susu) secara lebih massif (Khalifatunnisak et al., 2025).

Manfaat dan tujuan utama dari intervensi ini mencakup dimensi fisik maupun emosional ibu nifas. Melalui hypnobreastfeeding, kecemasan dan ketakutan yang sering muncul pada ibu baru dapat diminimalisir, sehingga ibu mampu memfokuskan pikirannya pada hal-hal positif. Selain efektif dalam meningkatkan volume dan kelancaran aliran ASI tanpa bantuan obat-obatan (non-farmakologis), teknik ini juga berperan penting dalam mengurangi risiko postpartum blues serta memperkuat ikatan batin (bonding attachment) antara ibu dan bayi melalui pancaran kasih sayang yang dirasakan selama proses menyusui. Keunggulan lainnya adalah biayanya yang relatif rendah dan kemudahannya untuk dipraktikkan secara mandiri oleh ibu di rumah setelah mendapatkan bimbingan awal dari tenaga Kesehatan (Khalifatunnisak et al., 2025).

Pelaksanaan teknik ini melibatkan tiga tahapan relaksasi yang sistematis guna mencapai kondisi yang optimal (Khalifatunnisak et al., 2025):

a. Relaksasi Otot: Ibu melakukan relaksasi mulai dari puncak kepala hingga telapak kaki dengan membayangkan seluruh otot tubuh menjadi kendur dan lemas.
b. Relaksasi Napas: Ibu dianjurkan melakukan pernapasan perut yang lambat dan dalam untuk meredakan ketegangan fisik secara cepat.
c. Relaksasi Pikiran: Ibu belajar untuk memusatkan pikiran pada saat ini (*mindfulness*), misalnya dengan bantuan musik relaksasi atau aromaterapi, sehingga pikiran tidak lagi berkelana jauh dari raga.

Waktu pelaksanaan yang paling efektif adalah sebelum sesi menyusui atau sebelum memerah ASI, agar lonjakan hormon oksitosin dapat langsung mempermudah pengeluaran susu. Dengan konsistensi dalam pengendalian pikiran dan niat yang tulus, hambatan laktasi seperti puting lecet atau persepsi ASI kurang dapat teratasi dengan lebih baik. Secara keseluruhan, hypnobreastfeeding memberikan jalan keluar alami bagi ibu nifas untuk menjalani transisi peran barunya dengan lebih bahagia dan sejahtera (Khalifatunnisak et al., 2025)..

11. Asuhan Menyusui pada Masa Nifas

Asuhan menyusui merupakan komponen krusial dalam asuhan kebidanan masa nifas karena ASI adalah sumber nutrisi terbaik yang sesuai dengan kebutuhan bayi. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan UNICEF merekomendasikan pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan bayi guna mengoptimalkan pertumbuhan, perkembangan otak, serta mengurangi risiko penyakit menular dan kematian anak (Torabinia et al., 2021; Varela et al., 2025).

a. Peran Tenaga Kesehatan dalam Laktasi

Menurut Varela, et al (2025), asuhan kebidanan pada ibu nifas pada ruang lingkup manajemen laktasi merupakan komponen vital dalam tahap awal menyusui. Strategi yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yaitu meliputi:

1) Evaluasi Rutin: Melakukan pengamatan sistematis, pengkajian kesiapan ibu secara fisik dan psikologis, observasi secara langsung terhadap komponen menyusui untuk mendeteksi potensi masalah sedini mungkin.
2) Intervensi Edukasi: Memberikan bimbingan klinis dan edukasi kepada ibu berdasarkan hasil observasi untuk meningkatkan keberhasilan laktasi, demonstrasi teknik, koreksi teknik dan posisi secara tepat, berikan edukasi berkelanjutan terkait manfaat dan managemen menyusui.
3) Dukungan Psikologis: Membangun kepercayaan diri ibu terhadap kemampuannya menyusui, karena efikasi diri yang tinggi berkorelasi positif dengan keberlanjutan menyusui (Varela et al., 2025).

b. Prinsip Dasar Teknik Menyusui

Teknik menyusui yang benar berfokus pada tercapainya perlekatan (*latch-on*) yang optimal antara mulut bayi dan payudara ibu. Perlekatan yang baik akan memastikan bayi memperoleh ASI secara adekuat sekaligus mencegah terjadinya masalah seperti puting lecet atau bendungan ASI. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam praktik menyusui adalah sebagai berikut:

1) Pertama, kenyamanan ibu harus menjadi prioritas. Ibu dianjurkan memilih posisi yang stabil dengan penopang yang cukup pada punggung, lengan,

dan kaki. Penggunaan bantal dapat membantu mengurangi ketegangan otot dan mencegah kelelahan selama menyusui.

2) Kedua, posisi tubuh bayi harus berada dalam satu garis lurus, meliputi telinga, bahu, dan panggul. Posisi ini memungkinkan bayi menelan dengan lebih mudah dan mencegah ketegangan pada leher.
3) Ketiga, bayi didekatkan ke tubuh ibu dengan posisi menghadap payudara (tummy to tummy). Kepala, leher, dan punggung bayi perlu disangga dengan baik agar bayi dapat sedikit mendongakkan kepala saat menyusu.
4) Keempat, ibu dianjurkan membawa bayi ke arah payudara, bukan sebaliknya. Kebiasaan mendekatkan payudara ke mulut bayi dapat menyebabkan perlekatan yang kurang tepat.
5) Kelima, bayi harus mendapatkan sebagian besar areola, bukan hanya puting. Posisi hidung bayi sejajar dengan puting akan merangsang refleks membuka mulut secara lebar sehingga perlekatan menjadi lebih dalam dan efektif.
6) Keenam, kepala bayi sebaiknya tidak ditekan dari belakang. Hal ini bertujuan agar bayi dapat mengatur posisi kepala secara alami, sehingga puting masuk hingga mencapai langit-langit lunak dan proses hisapan menjadi lebih optimal.

Selain itu, aspek keamanan juga perlu diperhatikan. Menyusui tidak dianjurkan dilakukan saat bayi berada dalam gendongan kain atau alat bantu sejenis karena berisiko mengganggu jalan napas bayi (Varela et al., 2025).

c. Tahap Perlekatan Dalam Menyusui

Keberhasilan menyusui sangat ditentukan oleh kualitas perlekatan antara mulut bayi dan payudara ibu. Perlekatan yang tidak tepat sering menjadi penyebab utama berbagai masalah, seperti puting lecet, bayi tidak efektif menyusu, hingga kegagalan pemberian ASI eksklusif. Oleh karena itu, pemahaman mengenai teknik perlekatan yang benar perlu menjadi bagian inti dalam asuhan menyusui (Varela et al., 2025).

Secara praktis, perlekatan yang efektif dapat dilakukan melalui beberapa tahapan berikut (Mislu et al., 2024; Varela et al., 2025):

1) Tahap pertama, ibu memposisikan bayi dengan mendekatkan seluruh tubuh bayi ke tubuh ibu. Wajah bayi menghadap payudara, dengan posisi hidung sejajar dengan puting. Posisi ini penting untuk memicu refleks alami bayi dalam mencari sumber ASI (*rooting reflex*).
2) Tahap kedua, kepala bayi dibiarkan sedikit menengadah. Posisi ini memungkinkan bibir atas bayi menyentuh puting terlebih dahulu, yang akan merangsang bayi untuk membuka mulut secara lebar. Membuka mulut

secara optimal merupakan prasyarat utama untuk mendapatkan perlekatan yang dalam.

3) Tahap ketiga, saat mulut bayi terbuka lebar, ibu segera mendekatkan bayi ke payudara sehingga dagu bayi menyentuh payudara terlebih dahulu. Dengan posisi kepala yang sedikit ekstensi, lidah bayi dapat menjangkau bagian bawah areola secara maksimal, sehingga proses penghisapan menjadi lebih efektif.
4) Tahap keempat, setelah bayi melekat, perlu dilakukan evaluasi terhadap kualitas perlekatan. Tanda-tanda perlekatan yang baik antara lain:
   a) Mulut bayi terbuka lebar dan mencakup sebagian besar areola
   b) Dagu bayi menempel pada payudara, sementara hidung tetap bebas
   c) Areola tampak lebih banyak di bagian atas bibir bayi dibandingkan bagian bawah
   d) Pipi bayi tampak penuh dan membulat saat menghisap, tanpa cekungan

   Perlekatan yang tepat tidak hanya meningkatkan efektivitas pengosongan payudara, tetapi juga berperan dalam mencegah trauma pada puting serta mendukung kelancaran produksi ASI melalui stimulasi refleks prolaktin dan oksitosin.

   Dalam praktik klinis, bidan perlu melakukan observasi langsung terhadap proses perlekatan dan memberikan koreksi secara segera apabila ditemukan ketidaktepatan. Pendekatan yang sabar dan edukatif akan membantu ibu membangun kepercayaan diri serta keterampilan menyusui yang berkelanjutan.

d. Posisi Menyusui
   1) Posisi Menggendong (Cradle Hold)

      Posisi paling umum. Ibu duduk dengan punggung tersangga, bayi melintang di pangkuan menghadap payudara. Kepala berada di lengan ibu, tubuh bayi satu garis lurus. Kurang nyaman pada ibu pasca operasi sesar karena menekan area luka.
   2) Posisi Miring (Side-Lying Position)

      Ibu dan bayi berbaring saling berhadapan (perut ke perut). Cocok untuk ibu lelah atau pasca persalinan operatif, serta menyusui malam hari. Pastikan tubuh bayi tetap lurus dan tersangga.
   3) Posisi Setengah Bersandar (Laid-Back Nursing)

      Ibu dalam posisi setengah berbaring, bayi di atas tubuh ibu. Memanfaatkan refleks alami bayi, meningkatkan kenyamanan dan relaksasi, serta mengurangi tekanan pada luka operasi.
   4) Posisi Mengapit (Rugby Hold/Football Hold)

Bayi berada di samping tubuh ibu, di bawah lengan. Tidak menekan perut sehingga ideal untuk ibu pasca sesar dan efektif untuk menyusui bayi kembar (Eker & Aslan, 2024; Gao et al., 2022; Mislu et al., 2024).

e. Instrumen Evaluasi Klinis

Untuk memberikan asuhan yang terukur, bidan dapat menggunakan instrumen penilaian sebagai alat referensi. Beberapa instrumen yang umum digunakan antara lain (Varela et al., 2025):

1) LATCH Scoring System: Menilai perlekatan, suara menelan yang terdengar, jenis puting, kenyamanan payudara/puting, dan posisi [Lampiran 4].
2) Bristol Breastfeeding Assessment Tool (BBAT): Alat terbaru yang mengevaluasi empat elemen utama (posisi, perlekatan, isapan, dan transfer ASI) dengan skor total 0–8 poin. BBAT terbukti sangat responsif terhadap perubahan kondisi menyusui dari waktu ke waktu [Lampiran 5].
3) Breastfeeding Self-Efficacy Scale (BSES): Digunakan untuk mengukur tingkat kepercayaan diri ibu, yang membantu mengidentifikasi ibu yang berisiko tinggi menghentikan menyusui lebih dini [Lampiran 6].

f. Hambatan dalam Menyusui

Bidan harus waspada terhadap faktor-faktor yang dapat menghambat keberhasilan laktasi, seperti (Torabinia et al., 2021; Varela et al., 2025):

1) Masalah Fisik: Nyeri pada puting, luka, atau trauma perineum yang berat.
2) Faktor Psikologis: Kurangnya efikasi diri, kecemasan, atau pengalaman menyusui yang buruk di masa lalu.
3) Persepsi Ketidakcukupan: Banyak ibu menghentikan menyusui karena merasa asupan ASI bagi bayinya tidak mencukupi, yang sering kali memerlukan validasi klinis seperti penimbangan berat badan bayi sebelum dan sesudah menyusui (*test weighing*).

Masalah menyusui sering terjadi pada masa awal nifas dan umumnya berkaitan dengan teknik, frekuensi menyusui, serta kondisi payudara. Penatalaksanaan yang tepat dan segera sangat penting untuk mencegah komplikasi.

1) Puting lecet atau nyeri

   Biasanya disebabkan oleh perlekatan yang tidak tepat. Tatalaksana meliputi koreksi posisi dan teknik menyusui, memastikan bayi melekat dengan baik pada areola, serta mengoleskan ASI pada puting setelah menyusui untuk mempercepat penyembuhan. Hindari penggunaan sabun atau bahan iritatif pada puting.

2) ASI dirasa kurang

   Sering kali berkaitan dengan kurangnya stimulasi. Tatalaksana meliputi menyusui lebih sering sesuai kebutuhan bayi (*on demand*), memberikan

kedua payudara secara bergantian, meningkatkan kontak kulit (*skin to skin*), serta memastikan perlekatan efektif. Dukungan psikologis juga penting untuk mengurangi kecemasan ibu.

3) Bendungan ASI (breast engorgement)
   Ditandai payudara tegang, keras, dan nyeri. Tatalaksana meliputi menyusui lebih sering, kompres hangat sebelum menyusui untuk melancarkan aliran ASI, serta kompres dingin setelah menyusui untuk mengurangi nyeri dan edema. Bila perlu, lakukan pengeluaran ASI secara manual secukupnya.

4) Perlekatan tidak efektif
   Ditandai nyeri saat menyusui, bayi sering lepas, atau tidak puas setelah menyusu. Tatalaksana utama adalah evaluasi dan koreksi teknik perlekatan, termasuk posisi kepala bayi dan kedalaman hisapan.
5) Produksi ASI berlebih
   Dapat menyebabkan aliran ASI terlalu deras sehingga bayi kesulitan menghisap. Tatalaksana meliputi pengaturan posisi menyusui (misalnya posisi setengah bersandar), serta observasi teknik menyusui untuk membantu bayi beradaptasi dengan aliran ASI.
6) Sumbatan duktus ASI
   Ditandai adanya benjolan nyeri pada payudara. Tatalaksana meliputi menyusui lebih sering pada sisi yang terkena, pijat lembut ke arah puting saat menyusui, kompres hangat sebelum menyusui, serta menghindari pakaian atau bra yang terlalu ketat.
7) Mastitis
   Merupakan peradangan payudara yang ditandai nyeri, kemerahan, dan dapat disertai demam. Tatalaksana meliputi tetap melanjutkan menyusui (terutama pada payudara yang terkena), istirahat cukup, kompres hangat, serta analgetik bila diperlukan. Rujukan diperlukan bila tidak membaik dalam 24–48 jam untuk terapi antibiotik.
8) Abses payudara
   Terjadi akibat mastitis yang tidak tertangani. Ditandai adanya benjolan berisi cairan disertai nyeri hebat. Tatalaksana meliputi tindakan drainase oleh tenaga medis dan terapi antibiotik. Menyusui umumnya masih dapat dilanjutkan sesuai kondisi.
9) Infeksi payudara atau puting
   Dapat disebabkan oleh bakteri, jamur, atau virus. Gejala meliputi nyeri menetap, gatal, atau perubahan pada kulit payudara. Tatalaksana

disesuaikan dengan penyebab dan memerlukan terapi spesifik dari tenaga medis.

10) Tongue tie pada bayi

Kondisi di mana pergerakan lidah terbatas sehingga mengganggu perlekatan. Tatalaksana meliputi evaluasi klinis dan, bila diperlukan, tindakan sederhana (frenotomi) untuk memperbaiki fungsi menyusu.

H. Komunikasi, Informasi, dan Komunkasi (KIE)

Pemberian edukasi pada masa nifas harus dilakukan secara individual dan kontekstual agar ibu mampu melakukan perawatan mandiri dengan percaya diri.

Materi KIE Utama:

1. Perawatan Mandiri: Teknik perawatan payudara yang benar dan personal higiene area genitalia dan perawatan mandiri pada bayi baru lahir.
2. Kewaspadaan Dini: Pengenalan tanda bahaya nifas, seperti perdarahan hebat, demam tinggi, dan nyeri kepala parah.
3. Kebutuhan Dasar: Edukasi mengenai pola menyusui yang efektif dan pemenuhan gizi seimbang bagi ibu menyusui (Kementrian Kesehatan RI, 2020).

Teknik Edukasi Efektif:

Bidan sangat disarankan menggunakan metode *Teach-back* untuk memverifikasi tingkat pemahaman ibu serta melakukan demonstrasi langsung yang melibatkan suami atau keluarga sebagai pendukung utama (Setianingsih et al., 2024).

I. Dokumentasi Asuhan Kebidanan pada Ibu Nifas

Dokumentasi asuhan merupakan bagian integral dari keselamatan pasien dan menjadi bukti legal atas kompetensi profesional bidan. Pencatatan yang baik harus bersifat objektif, lengkap, tepat waktu, dan mudah dibaca oleh tim kesehatan lainnya (Romlah et al., 2024).

Implementasi Format SOAP:

Setiap temuan klinis disusun menggunakan alur berpikir sistematis sebagai berikut:

1. S (Subjektif): Mencatat keluhan atau data yang disampaikan pasien, contoh: "Ibu mengeluh payudara terasa nyeri, tegang, dan penuh".
2. O (Objektif): Mencatat hasil pemeriksaan fisik dan tanda vital, contoh: TFU 2 jari di bawah pusat, payudara teraba padat, suhu 37,8ºC.

3. A (Analisis): Penetapan diagnosis berdasarkan sintesis data, contoh: P2A0AH2 nifas hari ke-3 dengan Bendungan ASI.
4. P (Penatalaksanaan): Langkah tindakan yang diberikan, meliputi edukasi teknik menyusui, kompres hangat, dan stimulasi pijat payudara/oksitosin.

J. Pemerikasaan Fisik pada Ibu Nifas

Pemeriksaan fisik dilakukan secara komprehensif dengan pendekatan *head-to-toe* untuk memastikan proses pemulihan berjalan normal dan mendeteksi komplikasi lebih awal [Lampiran 1].

1. Pengkajian Tanda-Tanda Vital (TTV)

a. Tekanan Darah: Normalnya stabil. Peningkatan bermakna dapat mengindikasikan preeklamsia postpartum, sedangkan penurunan drastis bisa menjadi tanda perdarahan hebat.
b. Suhu: Kenaikan hingga 38°C dalam 24 jam pertama mungkin akibat dehidrasi. Jika >38°C setelah 24 jam, waspadai infeksi puerperalis.
c. Nadi: Denyut nadi >100x/menit memerlukan evaluasi terhadap kemungkinan infeksi atau perdarahan.

2. Evaluasi Payudara

a. Menilai kesimetrisan, adanya bendungan ASI (engorgement), atau kemerahan.
b. Pemeriksaan puting susu: Menilai jenis puting (menonjol, datar, atau terbenam) dan adanya luka lecet atau retakan.

3. Pemeriksaan Abdomen (Involusi Uteri)

a. Tinggi Fundus Uteri (TFU): Segera setelah lahir TFU setinggi pusat. Pada hari ke-5 berada di pertengahan pusat-simfisis, dan tidak teraba lagi setelah hari ke-12.
b. Kontraksi: Uterus harus teraba keras. Kandung kemih yang penuh dapat menghambat kontraksi dan menyebabkan uterus lembek.

4. Pemeriksaan Genitalia dan Perineum

a. Lochea: Menilai warna, jumlah (normal 240–270 ml total selama nifas), dan bau (bau busuk mengarah pada infeksi).
b. Perineum: Menilai penyembuhan luka jahitan, edema, atau hematoma menggunakan parameter REEDA (*Redness, Edema, Ecchymosis, Discharge, Approximation*).

5. Pemeriksaan Ekstremitas

Menilai adanya edema, nyeri tekan, atau rasa panas pada betis untuk mendeteksi tanda-tanda tromboflebitis (Joo et al., 2024; Kementrian Kesehatan RI, 2020).

K. Instrumen Evaluasi Laktasi dengan LATCH Score

Instrumen LATCH memberikan penilaian objektif terhadap efektivitas menyusui dengan total skor maksimal 10.

Interpretasi:

Instrumen LATCH Score merupakan sistem penilaian yang digunakan oleh tenaga kesehatan untuk mengevaluasi efektivitas teknik menyusui secara objektif dan terstruktur. Akronim LATCH mewakili lima indikator utama penilaian, di mana masing-masing komponen diberi skor antara 0 hingga 2 dengan total skor maksimal 10. Skor ≤ 6 memerlukan intervensi laktasi intensif dan tindak lanjut dalam 48 jam. Berikut adalah rincian indikator penilaian dalam LATCH Score:

1. **L (*Latch* / Perlekatan): Menilai seberapa baik bayi menempel pada payudara.**
   a. Skor 0: Bayi terlalu mengantuk, enggan menyusu, atau tidak terjadi perlekatan sama sekali.
   b. Skor 1: Bayi membutuhkan bantuan dan rangsangan untuk melakukan perlekatan; melakukan beberapa kali percobaan baru berhasil.
   c. Skor 2: Bayi dapat memegang payudara dengan baik, bibir memutar keluar (*flanged*), dan melakukan isapan ritmik.
2. **A (Audible Swallowing / Suara Menelan): Menilai kemampuan bayi untuk menerima dan menelan ASI secara efektif.**
   a. Skor 0: Tidak terdengar suara menelan.
   b. Skor 1: Terdengar beberapa kali suara menelan dengan bantuan stimulasi.
   c. Skor 2: Suara menelan terdengar secara spontan, sering, dan ritmik.
3. **T (Type of Nipple / Jenis Puting): Menilai kondisi fisik puting susu ibu.**
   a. Skor 0: Puting terbenam (*inverted*).
   b. Skor 1: Puting berbentuk datar (*flat*).
   c. Skor 2: Puting menonjol atau menonjol setelah dilakukan stimulasi (*everted*).
4. **C (Comfort /Kenyamanan): Menilai tingkat kenyamanan payudara dan puting ibu selama menyusui.**
   a. Skor 0: Ibu mengalami nyeri hebat, payudara bengkak (*engorged*), pecah-pecah, atau lecet parah.
   b. Skor 1: Ibu merasakan ketidaknyamanan ringan hingga sedang, terdapat area kemerahan, atau luka memar kecil pada puting.
   c. Skor 2: Ibu tidak merasa nyeri (*painless*), payudara terasa lembut dan tidak tegang.
5. **H (Hold / Posisi): Menilai kemampuan ibu dalam memposisikan dan memegang bayi secara mandiri.**
   a. Skor 0: Ibu memerlukan bantuan penuh (*full assist*) dari tenaga kesehatan untuk memposisikan bayi.

b. Skor 1: Ibu membutuhkan bantuan minimal, seperti penggunaan bantal penyangga untuk kenyamanan.
c. Skor 2: Ibu mampu memposisikan bayi secara mandiri tanpa bantuan orang lain (Selçuk et al., 2025; Varela et al., 2025).

L. Instrumen Evaluasi dengan Early Warning Score (EWS)

1. Modified Early Obstetric Warning Score (MEOWS)

Digunakan untuk pemantauan fisiologis ibu guna mencegah morbiditas berat. Parameter utama dalam *Modified Early Obstetric Warning* Score (MEOWS) terdiri dari enam tanda vital inti yang digunakan untuk mendeteksi perburukan kondisi fisiologis pada ibu hamil dan nifas [Lampiran 6]..

Parameter tanda vital tersebut meliputi:

a. Laju Napas (*Respiratory Rate*): Diukur dalam napas per menit.
b. Saturasi Oksigen (*Oxygen Saturation*/SpO2): Persentase oksigen dalam darah.
c. Suhu Tubuh *(Temperature*): Diukur dalam derajat Celcius.
d. Denyut Nadi (*Pulse Rate*): Diukur dalam denyut per menit.
e. Tekanan Darah Sistolik (Parameter: Laju napas, saturasi O2, suhu, nadi, tekanan darah sistolik, dan diastolik.
f. Tekanan Darah Diastolik (*Diastolic Blood Pressure*): Batas tekanan saat jantung berelaksasi.
g. Tekanan Darah Diastolik (Diastolic Blood Pressure): Batas tekanan saat jantung berelaksasi (Gerry et al., 2024; Murphy et al., 2007; Swami et al., 2023).

2. Neonatal Early Warning Score (NEWS)

Instrumen penilaian untuk mengidentifikasi perburukan kondisi bayi baru lahir [Lampiran 7].

a. Parameter Utama: Laju napas (RR), upaya bernapas (retraksi), suhu, nadi, saturasi O2, dan tingkat kesadaran.
b. Respons Klinik:
    1) Skor 0: Observasi rutin setiap 6 jam.
    2) Skor 1-2: Evaluasi setiap 30 menit.
    3) Skor ≥ 3/Zona Merah: Aktivasi respons cepat (RRT) dan rujukan ke NICU (Amouri et al., 2020; Pahwa et al., 2025).

M. Lampiran Instrumen Evaluasi dan OSCE/Lab Skill

Lampiran 1. Standar Operating Prosedur (SOP) Pemeriksaan Fisik Ibu Nifas

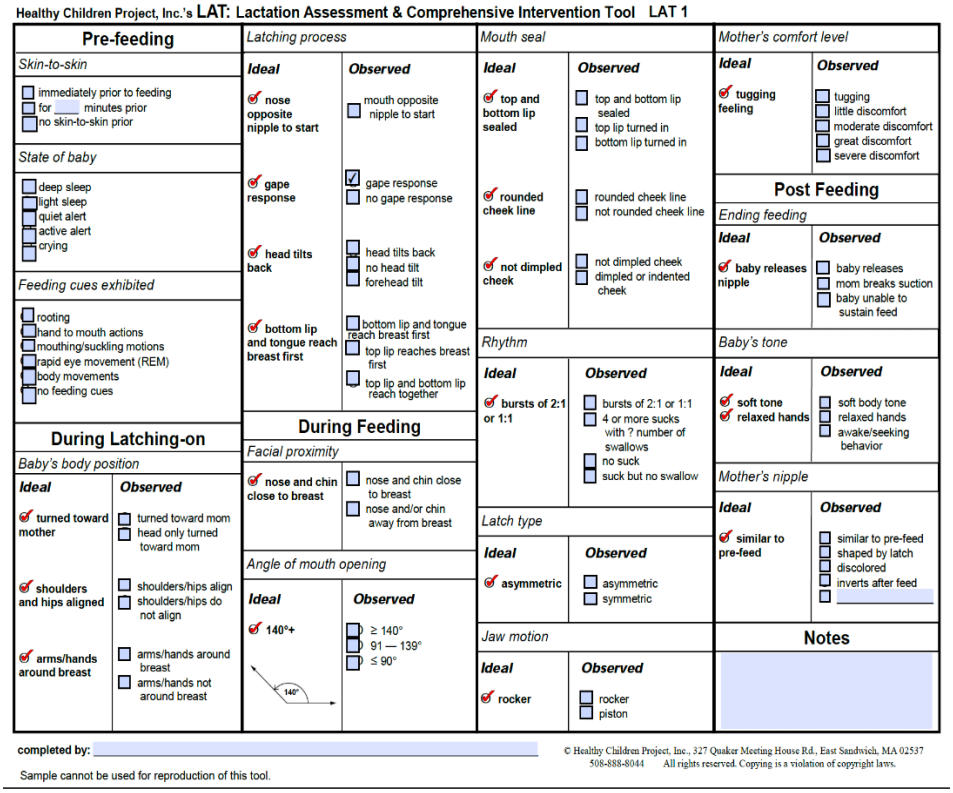
PROTAP	PROSEDUR
Pengertian	Pemeriksaan fisik merupakan salah satu cara mengetahui gejala atau masalah kesehatan yang dialami oleh ibu nifas dengan mengumpulkan data objektif dengan dilakukan pemeriksaan kepada pasien
Indikasi	Ibu dalam masa nifas
Tujuan	1. Untuk mengumpulkan data 2. Mengidentifikasi masalah pasien 3. Meniai perubahan status pasien 4. Mengevaluasi tindakan yang telah diberikan
Pengkajian	Ibu nifas
Persiapan tempat pasien dan alat	Tempat : Ruangan disiapkan sebaik mungkin dengan memasang penyekat , mengatur pencahayaan Persiapan pasien : Sebelum melakukan pemeriksaan beritahu pasien tindakan yang akan dilakukan, atur posisi untuk mempermudah pemeriksaan, atur pasien seefisien mungkin Persiapan alat dan bahan : 1. Alat pelindung diri petugas 2. Baki beralas 1 buah 3. Tensimeter dan stetoskop 4. Botol 3 buah 5. Tissue 6. Lampu senter 7. Hammer 8. Spatel lidah 9. Kapas dan air DTT 10. Hand scoen 1 pasang 11. Pinset 12. Bengkok 13. Tempat sampah 14. Larutan klorin 0,5%

PROTAP	PROSEDUR
Persiapan pasien	Sebelum melakukan pemeriksaan beritahu pasien tindakan yang akan dilakukan. Atur posisi untuk mempermudah pemeriksaan, atur pasien seefisien mungkin
Prosedur tindakan	1. Jelaskan prosedur tindakan yang akan dilakukan kepada ibu 2. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk pemeriksaaan 3. Cuci tangan keseluruhan dengan sabun dan air mengalir serta mengeringkan dengan handuk 4. Minta ibu berbaring terlentang diatas tempat tidur pemeriksaan 5. Pemeriksaan umum Memeriksa TTV : tekanan darah, suhu tubuh, nadi dan pernapasan 6. Pemeriksaan fisik pada ibu a. Muka dan mata Periksa apakah ada oedema pada wajah, periksa tingkat anemia ibu dengan memeriksa warna kulit muka (wajah) dan konjungtiva. Serta periksa pisio untuk menilai ada tidaknya ;pisiot atau kuning. Konjungtiva yang pucat manandakan ibu anemis b. Pemeriksaan pada leher Minta ibu sedikit mendongak. Lakukan palpasi kelenjar tiroid dan kelenjar limfe. Perhatikan adanya pembesaran kelenjar tiroid dan pembengkakan kelenjar limfe. c. Pemeriksaan pada payudara • Melakukan inspeksi terlebih dahulu mengenai bentuk payudara (simetris atau tidak), kemerahan/tidak, keadaan putting pecah/tidak. • Pasien berbaring terlentang dengan lengan kiri diatas kepala,kemudian palpasi payudara

PROTAP	PROSEDUR
	kiri secara sistematis melingkar searah jarum jam sampai axilla. Catat adanya massa, benjolan yang membesar, pembengkakan atau abses, periksa pengeluaran ASI ;pisio/tidak. Ulangi prosedur yang sama untuk payudara sebelah kanan. d. Pemeriksaan fisik pada perut • Lakukan inspeksi pada perut apakah ada luka beka operasi/tidak. • Palpasi untuk menilai kontraksi uterus, melakukan pengukuran TFU • Lakukan pemeriksaan diastasis rektus abdominalis dengan cara menganjurkan ibu untuk membungkukkan kepalanya kemudian 2 jari petugas diletakkan di bagian linea nigra. Apabila terdapat jarak lebih 2 jari menunjukkan adanya peregangan otot rectus abdominalis. e. Pemeriksaan fisik pada genetalia • Mengatur posisi ibu dorsal recumbent • Memakai sarung tangan • Memberitahu ibu tentang prosedur pemeriksaan genetalia • Memeriksa jahitan episiotomi ada atau tidaknya tanda REEDA (*Redness*/kemerahan, *Edema*/bengkak, *Ecchymosis*/Ekimosis, *Discharge*/pengeluaran, Aproximation/penyatuan luka) • Memeriksa lokhea yang keluar • Memeriksa adanya hemoroid dengan cara menganjurkan pasien dalam posisi sims, yaitu posisi seperti memeluk guling dan keudian melakukan pemeriksaan pada anus • Meletakkan sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5% f. Pemeriksaan fisik pada kaki • Adanya oedema dengan cara menekan

PROTAP	PROSEDUR
	daerah mata kaki apabila dalam waktu >3 detik tidak kembali lagi berarti mengalami oedema • Lihat adanya varises yaitu dengan cara meminta ibu untuk posisi sims dan melihat ada tidaknya varises pada betis • Memeriksa ada tidaknya tromboflebitis dengan cara menekuk kedua kaki ibu kemudian tekan betis/ meminta klien menghentakkan kaki kearah tangan petugas dan tanyakan apakah ada nyeri atau tidak (tanda Homan) 7. Melakukan pemeriksaan reflek patella 8. Membereskan alat 9. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir kemudian keringkan dengan handuk yang bersih 10. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada pasien 11. Dokumentasi

Lampiran 2. Instrumen Lactation Assessment Tool (LAT)



Healthy Children Project, Inc.'s LAT: Lactation Assessment & Comprehensive Intervention Tool LAT 1

Pre-feeding

Skin-to-skin

- ☐ immediately prior to feeding
- ☐ for ____ minutes prior
- ☐ no skin-to-skin prior

State of baby

- ☐ deep sleep
- ☐ light sleep
- ☐ quiet alert
- ☐ active alert
- ☐ crying

Feeding cues exhibited

- ☐ rooting
- ☐ hand to mouth actions
- ☐ mouthing/suckling motions
- ☐ rapid eye movement (REM)
- ☐ body movements
- ☐ no feeding cues

During Latching-on

Baby's body position

Ideal	Observed
☑ turned toward mother	☐ turned toward mom ☐ head only turned toward mom
☑ shoulders and hips aligned	☐ shoulders/hips align ☐ shoulders/hips do not align
☑ arms/hands around breast	☐ arms/hands around breast ☐ arms/hands not around breast

Latching process

Ideal	Observed
☑ nose opposite nipple to start	☐ mouth opposite nipple to start
☑ gape response	☑ gape response ☐ no gape response
☑ head tilts back	☐ head tilts back ☐ no head tilt ☐ forehead tilt
☑ bottom lip and tongue reach breast first	☐ bottom lip and tongue reach breast first ☐ top lip reaches breast first ☐ top lip and bottom lip reach together

During Feeding

Facial proximity

Ideal	Observed
☑ nose and chin close to breast	☐ nose and chin close to breast ☐ nose and/or chin away from breast

Angle of mouth opening

Ideal	Observed
☑ 140°+	☐ ≥ 140° ☐ 91 — 139° ☐ ≤ 90°

Mouth seal

Ideal	Observed
☑ top and bottom lip sealed	☐ top and bottom lip sealed ☐ top lip turned in ☐ bottom lip turned in
☑ rounded cheek line	☐ rounded cheek line ☐ not rounded cheek line
☑ not dimpled cheek	☐ not dimpled cheek ☐ dimpled or indented cheek

Rhythm

Ideal	Observed
☑ bursts of 2:1 or 1:1	☐ bursts of 2:1 or 1:1 ☐ 4 or more sucks with ? number of swallows ☐ no suck ☐ suck but no swallow

Latch type

Ideal	Observed
☑ asymmetric	☐ asymmetric ☐ symmetric

Jaw motion

Ideal	Observed
☑ rocker	☐ rocker ☐ piston

Mother's comfort level

Ideal	Observed
☑ tugging feeling	☐ tugging ☐ little discomfort ☐ moderate discomfort ☐ great discomfort ☐ severe discomfort

Post Feeding

Ending feeding

Ideal	Observed
☑ baby releases nipple	☐ baby releases ☐ mom breaks suction ☐ baby unable to sustain feed

Baby's tone

Ideal	Observed
☑ soft tone ☑ relaxed hands	☐ soft body tone ☐ relaxed hands ☐ awake/seeking behavior

Mother's nipple

Ideal	Observed
☑ similar to pre-feed	☐ similar to pre-feed ☐ shaped by latch ☐ discolored ☐ inverts after feed ☐ _____

Notes

completed by: _____

© Healthy Children Project, Inc., 327 Quaker Meeting House Rd., East Sandwich, MA 02537
508-888-8044 All rights reserved. Copying is a violation of copyright laws.

Sample cannot be used for reproduction of this tool.

Lampiran 3. Instrumen LATCH Breastfeeding Score

KOMPONEN	0	1	2	TOTAL
L (Latch)	Bayi mengantuk/reluctant, tidak ada perlekatan.	Mencoba berulang kali, perlekatan belum stabil.	Mulut terbuka lebar, bibir memutar keluar, isapan ritmik.	
A (Audible Swallowing)	Tidak terdengar suara menelan.	Terdengar sesekali dengan stimulasi.	Spontan dan sering.	
T (Type of Nipple)	Terbenam (*inverted*).	Datar (*flat*).	Menonjol (*everted*).	
C (Comfort)	Nyeri hebat, lecet, bendungan ASI parah.	Nyeri ringan/sedang, sedikit kemerahan.	Payudara lembut, tidak nyeri.	

H (Hold/Position)	Bantuan penuh dari petugas.	Bantuan minimal (posisi bantal).	Mandiri tanpa bantuan petugas.	

Sumber: (Ingram et al., 2015)

Sistem Penilaian Per Item: Setiap elemen diberikan nilai berdasarkan kualitas pencapaiannya:

- **Skor 0 (Buruk):** Tidak memenuhi kriteria atau persyaratan fitur yang diamati.
- **Skor 1 (Sedang):** Menunjukkan kualitas yang cukup atau di tingkat menengah.
- **Skor 2 (Baik):** Menunjukkan pencapaian yang berhasil atau optimal.

Total Skor: Penjumlahan dari keempat item tersebut menghasilkan skor total yang berkisar antara **0 hingga 8 poin**

Lampiran 4. Instrumen *Bristol Breastfeeding Assessment Tool* (BBAT)

Tabel Penilaian BBAT (Bristol Breastfeeding Assessment Tool)

Komponen Penilaian	0 Buruk	1 Sedang	2 Baik	Skor
POSITIONING/POSISI Bayi tertopang dengan baik; **Didekap pada tubuh ibu**; Berbaring miring/leher tidak tertekuk; **Hidung berhadapan dengan puting**; Ibu percaya diri dalam menangani bayi.	Tidak ada atau hanya sedikit elemen yang terpenuhi. Ibu perlu **dibimbing langkah demi langkah** dalam memposisikan bayi.	Mencapai beberapa elemen posisi. **Masih memerlukan beberapa saran** atau koreksi posisi.	**Mencapai semua elemen posisi**. Ibu mandiri dan tidak memerlukan saran posisi lagi.	
ATTACHMENT/PERLEKATAN *Rooting* positif; Mulut terbuka lebar; Bayi mencapai perlekatan	Bayi tidak mampu menempel pada payudara	Perlu dibimbing dalam langkah-langkah	**Mencapai semua elemen perlekatan**. Tidak	

cepat dengan **jumlah jaringan payudara yang cukup** di dalam mulut; Bayi tetap menempel dengan baik sepanjang sesi menyusu.	atau **perlekatan sangat buruk**. Tidak ada atau sangat sedikit elemen perlekatan yang tercapai.	perlekatan. Mencapai beberapa elemen. **Masih membutuhkan saran**terkait perlekatan.	memerlukan saran atau bantuan perlekatan lagi.	
SUCKING/ISAPAN Mampu membentuk **pola isapan efektif** pada kedua payudara (isapan cepat di awal kemudian isapan lebih lambat dengan jeda). Bayi mengakhiri sendiri sesi menyusu.	Tidak ada isapan yang efektif; **tidak terbentuk pola isapan**.	Beberapa isapan efektif terlihat; pola isapan belum memuaskan; bayi **sering lepas-pasang**dari payudara.	**Pola isapan efektif berhasil tercapai**.	
SWALLOW/MENELAN Suara menelan terdengar, teratur, dan lembut; **tidak ada suara "klik"**.	Suara menelan tidak terdengar sama sekali; terdengar **suara "klik"**.	Sesekali suara menelan terdengar; beberapa suara menelan **terdengar berisik** atau ada suara "klik".	**Suara menelan teratur**, terdengar jelas, dan tenang.	

Sumber: (Ingram et al., 2015)

Catatan Klinis:

- Skor total berkisar antara **0 hingga 8 poin**.
- Skor yang lebih tinggi menunjukkan keberhasilan menyusui yang lebih besar, sementara skor rendah mengidentifikasi ibu yang berisiko berhenti menyusui dini.
- BBAT terbukti lebih responsif terhadap perubahan kondisi dari waktu ke waktu dibandingkan instrumen lain seperti LATCH.

Lampiran 5. Instrumen *Breastfeeding Self-Efficacy Scale* (BSES-SF)

Kuisioner *Breastfeeding Self-Efficacy Scale – Short Form* (BSES-SF)

Petunjuk untuk menjawab pertanyaan:

1. Baca dan pahami setiap pertanyaan dengan seksama!
2. Berilah tanda (√) pada kolom yang sesuai dengan perasaan Ibu!
3. Pilihan jawaban Adalah:

STY : Sangat Tidak Yakin
TY : Tidak Yakin
KY : Kurang yakin
Y : Yakin
SY : Sangat Yakin

No.	Daftar Pertanyaan	STY	TY	KY	Y	SY
1.	Saya merasa bahwa bayi saya mendapatkan cukup ASI.					
2.	Saya tetap dapat menyusui bayi saya walaupun banyak hal yang saya lakukan.					
3.	Saya memberikan ASI kepada bayi saya tanpa tambahan susu formula.					
4.	Saya memastikan bahwa bayi saya tidak mendapatkan makanan apapun selain ASI.					
5.	Saya mampu mengelola keadaan saat menyusui untuk kenyamanan saya					
6.	Saya akan tetap menyusui bayi saya bahkan saat bayi saya menangis.					
7.	Saya tetap nyaman dalam menyusui saat ada anggota keluarga atau orang lain disekitar saya.					
8.	Saya puas dengan pengalaman menyusui saya.					
9.	Saya memberikan ASI kepada bayi saya dengan satu payudara sampai habis lalu beralih ke payudara sebelahnya.					
10.	Saya terus menyusui bayi saya untuk memberikan makanan.					
11.	Saya mampu memenuhi keinginan menyusui bayi saya					
12.	Saya mengetahui tanda ketika bayi saya selesai menyusu.					

Skor Total :

Sumber : *Breastfeeding Self – Efficacy Scale – Short Form* (Dennis, 2002)

Sumber: (Maurer et al., 2024)

Lampiran 6. Instrumen *Modified Early Obstetric Warning Score* (MEOWS)

Modified Early Obstetric Warning Scoring

Tanggal:			
Jam:			
Laju Respirasi/ menit	>25	3	>25
	21-25	2	21-25
	12-20	0	12-20
	<12	3	<12
Saturasi O2	>95	0	>95
	92-95	2	92-95
	<92	3	<92
Suplemen O2	%	2	
Temperatur (° C)	>37.7	3	>37.7
	37.3-37.7	2	37.3-37.7
	36.1-37.2	0	36.1-37.2
	<36	3	<36
Tekanan darah Sistolik (mmHg)	>160	3	>160
	150-160	2	150-160
	140-150	0	140-150
	90-140		90-140
	<90	3	<90
Tekanan darah diastole (mmHg)	>110	3	>110
	100-110	2	100-110
	90-100	1	90-100
	<90	0	<90
Laju detak jantung/ menit	>120	3	>120
	110-120	2	110-120
	100-110	1	100-110
	60-100	0	60-100
	50-60	2	50-60
	<50	3	<50
Kesadaran	Sadar	0	Sadar
	Nyeri/ Verbal/ Unrespond	3	Nyeri/ Verbal/ Unrespond
Nyeri	Normal	0	Normal
	Abnormal	3	Abnormal
Discharge/ Lochia	Normal	0	Normal
	Abnormal	3	Abnormal
Proteinuria (per hari)	+	2	Normal
	++>	3	Abnormal
TOTAL MEOWS SKOR			Total Skor

SKOR 1-4 (resiko ringan)	Assessment segera oleh bidan, respon segera, maks 5 menit, Eskalasi perawatan dan frekuensi monitoring tiap 4 jam, Jika diperlukan assessment oleh dokter jaga dan konsultasi ke DPJP, Jika terdapat gejala impending eclampsia (nyeri kepala, gangguan penglihatan dan nyeri ulu hati) eskalasi perawatan dan monitoring lebih dini
SKOR 5-6 / SALAH SATU PARAMETER DENGAN SKOR = 3 (resiko sedang)	assessment segera oleh tim kode blue (respon time 10 menit), tingkatkan frekuensi monitoring setiap jam, konsultasi ke DPJP untuk tatalaksana lanjutan dan direncanakan untuk pindah ruang intensif
SKOR 7 ATAU LEBIH (resiko tinggi)	Resusitasi dan monitoring secara kontinyu oleh dokter jaga dan bidan senior, Informasikan dan konsultasikan ke DPJP, pindahkan ke ruangan intensif. Jika terdapat tanda dan gejala penurunan kondisi secara cepat, penurunan kesadaran, kejang, akral dingin, distress pernapasan dan perdarahan yang massif, aktifkan code blue lakukan resusitasi dan monitoring secara continue, dokter jaga dan DPJP/ DPJP pengganti diharuskan hadir disamping pasien dan berkolaborasi untuk menentukan rencana perawatan lanjutan
HENTI NAPAS/JANTUNG	Lakukan RJP, Aktivasi code blue henti jantung segera, maksimal 5 menit)

Lampiran 7. Instrumen *Neonatus Early Warning Score* (NEWS)

NEONATUS EARLY WARNING SCORE																		
Tanggal																		Score
Jam																		
RR	≥80																	3
	70 – 79																	2
	60 – 69																	1
	30 – 59																	0
	20 – 29																	1
	16 – 19																	2
	≤15																	3
Retraksi dada	Tidak ada																	0
	Mild / moderate																	1
	Severe																	3
O_2	Tidak																	0
	≤2lpm																	1
	≥2lpm																	2
Saturasi O_2	≥94																	0
	90 – 93																	1
	86 – 89																	2
	≤85																	3
Nadi	≥190																	3
	180 – 189																	2
	150 – 179																	1
	110 – 149																	0
	90 -109																	1
	80 – 89																	2
	≤80																	3
Tekanan sistolik	≥110																	3
	100 – 109																	2
	80 – 99																	1
	60 – 79																	0
	50 – 59																	1
	45 – 49																	2
	≤45																	3
CRT	≤2 detik																	0
	≥2 detik																	1
Tingkat Kesadaran	A																	0
	V																	1
	P/U																	3
Total																		
Nama Perawat/ Bidan																		
Paraf																		

Apakah ibu mudah merasa khawatir?

Keterangan :

Score 0 - 2 : Asesmen Ulang setiap 8 jam

Score 3 – 4 : Asesmen Ulang setiap 4 – 6 jam

Score 5 - 6 : Asesmen Ulang setiap jam, Lapor DPJP

Lampiran 8. Checklist OSCE / Labskill (Keterampilan Klinis)

	- Apakah sulit tidur - Apakah merasa sedih - Apakah merasa tidak berguna • Apakah ibu merasakan sakit, demam atau pendarahan sejak persalinan? • Bagaimana kondisi payudara Ibu ? • Apakah ASI ibu keluar dengan baik? • Apakah ibu bisa menyusui anaknya? • Bagaimana daya hisap anak? • Apakah ada masalah dengan buang air kecil? Adakah ada masalah dengan buang air besar? Apakah keluar cairan berbau busuk?			
9	Menanyakan keluhan yang sering terjadi pada ibu nifas serta menatalaksana sesuai algoritma ibu nifas Mengecek Status HIV (dari Buku KIA, Kartu Ibu dan Kohort Ibu) atau bila tidak ada catatan, menyakan apakah pernah dilakukan tes HIV bila tidak ada catatan • Apakah ibu merasa gatal-gatal di kemaluan ibu • Apakah ibu mengalami batuk ≥ 2 minggu? • Tanyakan tentang prilaku merokok atau terpajan asap perokok lain • Apakah ibu minum alkohol/menggunakan obat terlarang? Atau ibu pernah mengalami kekerasan? • Tanyakan apakah ibu sudah mulai melakukan hubungan seksual dengan pasangannya • Apakah Ibu sudah mendapatkan vit A ?			
10	Menggali riwayat perkawinan: a. Usia nikah b. Lama menikah, pernikahan ke c. Status			
11	Menggali riwayat kehamilan terakhir: a. Periksa hamil dimana b. Keluhan selama hamil (pada masing-masing trimester) c. Adakah permasalahan kesehatan atau penyulit selama kehamilan d. Riwayat minum jamu/obat-obatan tertentu			
12	Riwayat persalinan sekarang: a. Kala I, Kala II, Kala III, Kala IV: lamanya, kejadian, adakah			

	penyulit, tindakan b. Keadaan bayi (tgl,jam kelahiran, berat lahir, jenis kelamin, adakah masalah/penyulit yang menyertai BBL, rawat gabung/tidak, IMD)			
13	Menggali Riwayat Obstetri (kehamilan, persalinan, nifas yang lalu): a. Jumlah kehamilan b. Jumlah persalinan c. Jumlah abortus d. Jumlah anak lahir hidup e. Jumah kelahiran mati f. Jumlah kelahiran prematur g. Persalinan dengan tindakan (SC, vakum, forcep, induksi/stimulasi) h. Riwayat perdarahan postpartum i. Berat bayi lahir j. Masalah janin k. Komplikasi nifas l. Laktasi			
14	Menggali riwayat KB (tempat pelayanan, jenis, lama pakai, alasan berhenti, keluhan)Rencana KB b. Rencana			
15	Menggali riwayat pemenuhan kebutuhan sehari-hari: a. Makan b. Minum c. Eliminasi d. Aktivitas/mobilisasi e. Istirahat f. Kebiasaan sehari-hari (merokok, jamu, obat-obatan) g. Seksual			
16	Menggali riwayat kesehatan sekarang: a. Alergi makanan atau obat b. Kardiovaskuler/jantung c. Malaria d. IMS e. HIV/AIDS f. Asma g. TBC h. DM			

	i. Hipertensi j. TORCH			
17	Menggali riwayat kesehatan sekarang: a. Alergi makanan atau obat b. Kardiovaskuler/jantung c. Malaria d. IMS e. HIV/AIDS f. Asma g. TBC h. DM i. Hipertensi j. TORCH			
18	Menggali riwayat kesehatan keluarga: a. Alergi makanan atau obat b. Kardiovaskuler/jantung c. Malaria d. IMS e. HIV/AIDS f. Asma g. TBC h. DM i. Hipertensi j. TORCH			
19	Menggali riwayat psikososial: a. Tanggapan ibu terhadap kelahiran bayinya b. Tanggapan keluarga/suami terhadap kelahiran bayinya c. Rencana merawat bayi d. Dukungan keluarga/suami terhadap perawatan bayi dan pemberian ASI e. Rencana menyusui f. Pengambilan keputusan dalam keluarga g. Aktivitas atau interaksi sosial h. Anggota keluarga yang tinggal serumah			
20	Menggali status ekonomi penghasilan perbulan			
21	Menggali data pengetahuan tentang masa nifas: Apakah ibu sudah mengetahui tentang masa nifas, sejauhmana yang			

	ibu ketahui tentang: a. Gizi ibu nifas, menu seimbang, penambahan kalori bagi ibu menyusui b. Personal higiene: kebersihan genetalia, mengganti pembalut, cara cebok, perawatan jahitan perineum c. Pakaian: bahan menyerap keringat, BH yang menyangga d. Pemberian ASI on demand, cara menyusui, perawatan payudara, teknik menyusui, cara pengeluaran ASI, pemerahan ASI, cara menyimpan ASI e. Tanda bahaya pada masa nifas f. Kebutuhan istirahat dan aktivitas termasuk *Early ambulation* dan mobilisasi dini			
	Skor maksimal : 72			
	Teknik (Bobot :1)			
24	Duduk tegak, postur tubuh terbuka			
25	Condongkan tubuh ke arah klien			
26	Kontak mata,sikap bersahabat			
27	Ekspresi muka terbuka dan tidak menilai			
	Skor maksimal : 4			
	TOTAL SKOR : A+B+C X 100 **86**			

Keterangan :

0 : jika langkah tidak dilakukan

1 : jika langkah dilakukan dengan benar dan berurutan tetapi kurang tepat dan atau fasilitator/dosen perlu membantu/mengingatkan hal-hal yang tidak terlalu berarti

2 : jika langkah dikerjakan dengan baik sesuai dengan urutan, tepat tanpa ragu-ragu dan tidak perlu bantuan.

.....
Penguji

(.....)

N. Latihan Soal

1. Seorang ibu, usia 30 tahun datang ke fasilitas Kesehatan menemui Bidan "E". Pasien mengatakan melahirkan anak pertamanya 10 hari yang lalu. Pasien mengatakan tubuhnya terasa lemas, suhu tubuhnya tidak seperti biasanya, dan badan seperti sakit mengalami gejala flu. Pasien juga mengeluh payudara kanan terasa nyeri, kemerahan, dan terasa hangat. Pasien sempat melakukan pemeriksaan suhu secara mandiri dengan hasil menunjukkan 38,5°C. Ibu mengatakan tidak ada kesulitan dalam menyusui karena sudah mendapat arahan dari Bidan "E" sebelum pulang dari bersalin. Namun sejak kemarin bayi lebih sering menyusu pada payudara kiri karena Ibu merasa lebih nyaman menyusui dan menggendong bayinya di sebelah sisi kiri..

   Pertanyaan:

   Tindakan yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut adalah:

   A. Menghentikan sementara untuk menyusui pada payudara yang sakit
   B. Tetap melanjutkan menyusui terutama pada payudara yang sakit dan istirahat cukup
   C. Melakukan asuhan kebidanan komplementer berupa SPEOS (Stimulasi Pijat Endorphin, Oksitosin, dan Sugestif) hingga suhu tubuh ibu normal Kembali
   D. Menyarankan ibu untuk rawat inap di fasilitas kesehatan

   Jawaban:

   B. Tetap melanjutkan menyusui terutama pada payudara yang sakit dan istirahat cukup

   Pembahasan:

   Gejala yang dialami ibu mengarah pada mastitis. Penatalaksanaan utama adalah tetap melanjutkan menyusui, terutama pada payudara yang mengalami gejala tersebut, untuk membantu pengosongan payudara. Disertai istirahat cukup dan pemantauan kondisi. Jika tidak membaik dalam 24–48 jam, diperlukan evaluasi lebih lanjut untuk kemungkinan terapi antibiotik.

   Pertanyaan:

   Apa yang harus dilakukan oleh Bidan terhadap pasien Ibu nifas dalam memberikan KIE dan Tindakan lanjutan untuk pemantauan kondisi pasca persalinas?

   A. Bidan dapat melakukan KIE terapi komplementer SPEOS (Stimulasi Pijat Endorphin, Oksitosin, dan Sugestif) untuk memperlancar ASI dan memunculkan rasa percaya diri Ibu dalam menyusui Bayinya
   B. Bidan perlu memberikan KIE dengan metode ***Teach-back*** untuk memverifikasi tingkat pemahaman ibu serta melakukan **demonstrasi langsung** yang

melibatkan suami atau keluarga dan memberikan jadwal kunjungan nifas yang sesuai

C. Bidan dapat melakukan promosi kesehatan untuk pemberian asuhan kebidanan pada ibu nifas berupa terapi memperlancar ASI di fasilitas Kesehatan.
D. Menyarankan ibu untuk istirahat dan dapat memberikan bayinya susu formula agar Kesehatan Ibu Kembali pulih dan dapat merawat bayinya lagi.

Jawaban:

E. B. Bidan perlu memberikan KIE dengan metode ***Teach-back*** untuk memverifikasi tingkat pemahaman ibu serta melakukan **demonstrasi langsung** yang melibatkan suami atau keluarga dan memberikan jadwal kunjungan nifas yang sesuai

Pembahasan:

Dalam proses KIE, Bidan perlu untuk memverifikasi ulang Tingkat pemahaman ibu dan dapat diverifikasi melalui lisan serta mengulang demostrasi secara langsung. Selain untuk memverifikasi pemahaman pasien juga untuk memastikan bahwa Teknik yang didemonstrasikan sudah sesuai. Sehingga pasien dapat mempraktikkan secara mandiri di rumah dengan tetap dilakukan ecaluasi pada kunjungan nifas. Jadwal kunjungan nifas juga sebaiknya sudah dijadwalkan sesuai dengan waktu KN1-KN$ atau adapat dilaksanakan sewaktu-waktu apabila terjadi kegawadaruratan atau kewaspadaan dini yang dirasakan oleh pasien.

2. Ny. S, berusia 26 tahun, baru saja melahirkan anak pertamanya secara normal 24 jam yang lalu di klinik bidan. Saat ini, kondisi vital ibu stabil, tidak ada riwayat hipertensi maupun anemia berat, dan ia ingin segera melakukan aktivitas fisik untuk mempercepat pemulihan rahimnya. Bidan merencanakan pemberian edukasi mengenai latihan fisik fungsional.

   Pertanyaan: Berdasarkan kondisi di atas, kapan waktu yang paling tepat bagi bidan untuk menganjurkan Ny. S memulai senam nifas dan apa manfaat utamanya terkait rahim?

   A. Segera setelah plasenta lahir untuk mencegah perdarahan primer.
   B. Dimulai 24 jam pascapersalinan untuk mempercepat involusi uterus.
   C. Setelah 1 minggu pascapersalinan agar luka perineum benar-benar kering.
   D. Menunggu masa nifas selesai (42 hari) agar organ reproduksi kembali normal.

   Jawaban:

   B. Dimulai 24 jam pascapersalinan untuk mempercepat involusi uterus.

   Pembahasan:

NSenam nifas secara ideal dimulai sejak **24 jam pascapersalinan** dengan catatan kondisi umum ibu dalam keadaan baik dan stabil. Secara fisiologis, gerakan fisik ini memicu kontraksi pada otot-otot dinding perut yang secara mekanis membantu proses **involusi uterus** (pengecilan rahim kembali ke ukuran semula). Selain itu, aktivitas ini meningkatkan sirkulasi darah yang sangat vital untuk mencegah komplikasi serius seperti trombosis vena dan varises.

3. Seorang bidan sedang melakukan kunjungan nifas pada hari ketiga kepada Ny. M. Saat diobservasi, bidan menemukan bahwa bayi tampak tertopang dengan baik, hidung sejajar puting, mulut terbuka lebar, dan perlekatan mencapai jaringan payudara yang cukup. Bidan juga mendengar suara menelan bayi yang teratur, lembut, dan tanpa suara klik. Bidan ingin menggunakan instrumen penilaian klinis yang objektif untuk mendokumentasikan keberhasilan ini.
   Pertanyaan: Instrumen penilaian menyusui manakah yang paling tepat digunakan bidan untuk mengevaluasi elemen posisi, perlekatan, isapan, dan transfer ASI secara sistematis?
   A. Parenting Self-Efficacy Scale (PSES).
   B. Bristol Breastfeeding Assessment Tool (BBAT).
   C. Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS).
   D. Neonatal Early Warning Score (NEWS).
   Jawaban:
   B. Bristol Breastfeeding Assessment Tool (BBAT)
   Pembahasan:
   BBAT merupakan instrumen penilaian klinis yang paling tepat untuk mengevaluasi efektivitas menyusui karena mencakup empat elemen esensial secara sistematis: **posisi (positioning), perlekatan (attachment), isapan (sucking),** dan **transfer ASI/suara menelan (swallowing)**. Instrumen ini sangat membantu bidan dalam melakukan evaluasi rutin untuk mendeteksi hambatan laktasi secara objektif. Jika skor yang didapat tinggi (mendekati 8), hal ini menunjukkan bahwa ibu sudah mandiri dan proses laktasi berjalan dengan sukses [Tabel Penilaian BBAT Lampiran 4].

O. Daftar Pustaka

Adams, Y. J., Miller, M. L., Agbenyo, J. S., Ehla, E. E., & Clinton, G. A. (2023). Postpartum care needs assessment: Women's understanding of postpartum care, practices, barriers, and educational needs. *BMC Pregnancy and Childbirth*, *23*, 502. https://doi.org/10.1186/s12884-023-05813-0

Amouri, S., Qadir, M., Jose, E., Simon, T., & Khan, J. (2020). Implementation of newborn early warning system in government hospital, United Arab Emirates. *Journal of Clinical Neonatology*, *9*, 182. https://doi.org/10.4103/jcn.JCN_132_19

Arumndari, R. W. B., Febriansyah Darus, Tonny Sundjaya, Runi. (2025). *Maternal Nutrition: The Foundation of Breastfeeding and Beyond*. Universitas Airlangga. Amerta Nutrition. https://doi.org/10.20473/amnt.v7i4.2023.487-493

Caballero-Gallardo, K., Quintero-Rincón, P., & Olivero-Verbel, J. (2025). Aromatherapy and Essential Oils: Holistic Strategies in Complementary and Alternative Medicine for Integral Wellbeing. *Plants*, *14*(3), 400. https://doi.org/10.3390/plants14030400

Chauhan, G., & Tadi, P. (2026a). Physiology, Postpartum Changes. In *StatPearls*. StatPearls Publishing. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK555904/

Chauhan, G., & Tadi, P. (2026b). Physiology, Postpartum Changes. In *StatPearls*. StatPearls Publishing. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK555904/

Chen, Y., Sun, X.-Y., Qian, C., Zhang, X.-X., Zhou, Y.-J., Zhang, H.-Y., & Xie, Z.-W. (2024). Therapeutic effect of manual massage on early postpartum rectus abdominis separation and postpartum depression. *World Journal of Psychiatry*, *14*(5), 678–685. https://doi.org/10.5498/wjp.v14.i5.678

Cunningham, F. G., Leveno, K. J., & Dashe, J. S. (2022). *Williams Obstetrics* (26e ed.). McGraw-Hill Education. (Original work published McGraw-Hill Education)

Diaris, N. M., & Dewi, N. M. U. K. (2025). *View of Acupressure Therapy as a Complementary Method to Enhance Breast Milk Production in Postpartum Mothers: A Study Supporting the Success of Exclusive Breastfeeding*. *10*(1), 40–47. https://doi.org/10.22225/wmj.10.1.8612.40-47

Eker, A., & Aslan, E. (2024). Effect of Lactation Management Model on Breastfeeding Process After Cesarean: A Prospective Randomized Controlled Study.

Reproductive Sciences, *31*(4), 1108–1116. https://doi.org/10.1007/s43032-023-01409-3

Ernstmeyer, K., & Christman, E. (Eds.). (2025a). *Nursing Health Promotion*. Chippewa Valley Technical College. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK615319/

Ernstmeyer, K., & Christman, E. (2025b). *Nursing Health Promotion: 11.2*. https://wtcs.pressbooks.pub/healthpromo/

Farlikhatun, L., Husna, A., Restuti, B. P., Munarti, I., Putri, K. A., Mutiah, R., & Sundari, S. (2025). Exploring the Role of Complementary Herbal Therapies (Red Ginger, Aloe Vera, Tangerang Turmeric, Cinnamon, Binahong Leaves, Green Betel Leaves) in Science Education: A Case Study on the Healing Process of Second-Degree Perineal Wounds in Postpartum Mothers. *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA*, *11*(7), 1235–1242. https://doi.org/10.29303/jppipa.v11i7.10621

Fatimah, E. S., Hartono, R. K., & Kusumastuti, I. (2024). Pengaruh Yoga Prenatal dan Hypnobirthing terhadap Tingkat Kecemasan Ibu Hamil Trimester 3. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, *13*(03), 215–224. https://doi.org/10.33221/jikm.v13i03.2940

Gao, H., Wang, J., An, J., Liu, S., Li, Y., Ding, S., Zhang, Y., & Chen, Y. (2022). Effects of prenatal professional breastfeeding education for the family. *Scientific Reports*, *12*(1), 5577. https://doi.org/10.1038/s41598-022-09586-y

Gerry, S., Bedford, J., Redfern, O. C., Rutter, H., Chester-Jones, M., Knight, M., Kelly, T., & Watkinson, P. J. (2024). Development of a national maternity early warning score: Centile based score development and Delphi informed escalation pathways. *BMJ Medicine*, *3*(1), e000748. https://doi.org/10.1136/bmjmed-2023-000748

Gil, W. S., Erazo, H. O. C., & Pérez, J. E. F. (2025, August). *Vaginal Delivery, as the Obstetrician Would Say*. https://doi.org/10.25100/peu.839

Haider, R. (2023). *Reproductive Function during Lactation*.

Hedigan, F., Sheridan, H., & Sasse, A. (2023). Benefit of inhalation aromatherapy as a complementary treatment for stress and anxiety in a clinical setting – A systematic review. *Complementary Therapies in Clinical Practice*, *52*, 101750. https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2023.101750

Idhayanti, R. I., Warastuti, A., & Yuniyanti, B. (2020). MOBILISASI DINI MENURUNKAN NYERI AKIBAT JAHITAN PERINEUM TINGKAT II PADA IBU POST PARTUM. *Jurnal Jendela Inovasi Daerah*, *3*(2), 29–43. https://doi.org/10.56354/jendelainovasi.v3i2.85

Ingram, J., Johnson, D., Copeland, M., Churchill, C., & Taylor, H. (2015). The development of a new breast feeding assessment tool and the relationship with breast feeding self-efficacy. *Midwifery*, *31*(1), 132–137. https://doi.org/10.1016/j.midw.2014.07.001

Joo, Y., Gatewood, J. V., Israel, M. A. M., & McGrath, K. W. (2024). *Collins-Bride & Saxe's Clinical Guidelines for Advanced Practice Nursing*. Jones & Bartlett Learning.

Kementrian Kesehatan RI. (2020). *BUKU KIA KESEHATAN IBU DAN ANAK*. Kementrian Kesehatan dan JICA (Japan Internationa; Cooperation Agency).

Khalifatunnisak, A., Farokah, A., & Dewi, A. R. (2025). MINDFUL MOTHERHOOD: HYPNOBREASTFEEDING AS A NATURAL SOLUTION TO INCREASE BREAST MILK PRODUCTION. *Indonesian Midwifery and Health Sciences Journal*, *9*(2), 153–165. https://doi.org/10.20473/imhsj.v9i2.2025.153-165

Louis-Jacques, A. F., & Stuebe, A. M. (2020). Enabling Breastfeeding to Support Lifelong Health for Mother and Child. *Obstetrics and Gynecology Clinics of North America, New Postpartum Visit: Beginning of Lifelong Health*, *47*(3), 363–381. https://doi.org/10.1016/j.ogc.2020.04.001

Malisa, N. (2024). PENGARUH SENAM NIFAS (Tranversus) GERAKAN I DAN III TERHADAP PENYEMBUHAN LUKAPERINEUM PADA IBU POST PARTUMDI PMB "R" TAHUN 2021. *JAKIA : Jurnal Kesehatan Ibu Dan Anak*, *2*(3), 91–102. https://doi.org/10.62527/jakia.2.3.30

Marshall, N. E., Abrams, B., Barbour, L. A., Catalano, P., Christian, P., Friedman, J. E., Hay, W. W., Hernandez, T. L., Krebs, N. F., Oken, E., Purnell, J. Q., Roberts, J. M., Soltani, H., Wallace, J., & Thornburg, K. L. (2022). The importance of nutrition in pregnancy and lactation: Lifelong consequences. *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, *226*(5), 607–632. https://doi.org/10.1016/j.ajog.2021.12.035

Maurer, L., Schultz, A., Dennis, C.-L., Alexandrowicz, R. W., & McQueen, K. (2024). The Breastfeeding Self-Efficacy Scale–Short Form (BSES-SF): German Translation

and Psychometric Assessment. *Journal of Human Lactation*, *40*(3), 374–385. https://doi.org/10.1177/08903344241254108

Meilani, M., & Putri, A. R. S. (2024). *Pengantar Asuhan Kebidanan Masa Nifas Komplementer*. Penerbit NEM.

Mentari, G., & Yuhaswita, Y. (2022). The Spread of "Tradisi Mandi Uap" as a Track Identification of Spices in Indonesia. *Indonesian Journal of Social Science Education (IJSSE)*, *4*(1), 40. https://doi.org/10.29300/ijsse.v4i1.6713

Mislu, E., Kumsa, H., Arage, M. W., Shitie, A., & Adimasu, A. (2024). Effective breastfeeding techniques and associated factors among lactating women: A community-based study, north east Ethiopia. *Frontiers in Public Health*, *12*, 1337822. https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1337822

Mitchell, K. B., Johnson, H. M., Rodríguez, J. M., Eglash, A., Scherzinger, C., Miller, B., Berens, P., Widmer, K., & Academy of Breastfeeding Medicine Academy of Breastfeeding Medicine. (2022). Academy of Breastfeeding Medicine Clinical Protocol #36: The Mastitis Spectrum, Revised 2022. *SAGE Publications*, *17*(5), 360–376. https://doi.org/10.1089/bfm.2022.29207.kbm

Modak, A., Ronghe, V., & Gomase, K. P. (2023). The Psychological Benefits of Breastfeeding: Fostering Maternal Well-Being and Child Development. *Cureus*, *15*(10), e46730. https://doi.org/10.7759/cureus.46730

Mohr, S., Raio, L., Gobrecht-Keller, U., Imboden, S., Mueller, M. D., & Kuhn, A. (2022). Postpartum urinary retention: What are the sequelae? A long-term study and review of the literature. *International Urogynecology Journal*, *33*(6), 1601–1608. https://doi.org/10.1007/s00192-021-05074-5

Mona, S., Dasaryandi, K. R., & Susanti, S. (2025). The Effect of Combined SEFT and SPEOS Therapy on Anxiety and Breast Milk Production in Postpartum Women: A Quasi-Experimental Study. *Majalah Kesehatan Indonesia*, *6*(3), 119–126. https://doi.org/10.47679/makein.2025272

Murphy, K., Packer, C., Stevens, A., & Simpson, S. (2007). Effective early warning systems for new and emerging health technologies: Developing an evaluation framework and an assessment of current systems. *International Journal of Technology Assessment in Health Care*, *23*(3), 324–330. https://doi.org/10.1017/S0266462307070493

Mustikawati, M., Hikma, W. E., & Lestari, F. (2026). The Effectiveness of Breast Care in Increasing Breast Milk Production in Postpartum Mothers. *Indonesian Journal of Global Health Research*, *8*(3), 69–78. https://doi.org/10.37287/ijghr.v8i3.1072

Nurhayati, F., Irianto, G., & Yulianah, R. (2024). The effect of hypnobreastfeeding on breast milk expenditure in postpartum mothers primiparous days 4-7 in TPMB Heni Nurhaeni Bandung city year 2024. *Science Midwifery*, *11*(6), 917–924. https://doi.org/10.35335/midwifery.v11i6.1416

Osaili, T. M., Dhanasekaran, D. K., Zeb, F., Faris, M. E., Naja, F., Radwan, H., Ismail, L. C., Hasan, H., Hashim, M., & Obaid, R. S. (2023). A Status Review on Health-Promoting Properties and Global Regulation of Essential Oils. *Molecules*, *28*(4), 1809. https://doi.org/10.3390/molecules28041809

Pahwa, K., Mittal, K., & Arya, V. (2025). 816: CORRELATION AND ASSOCIATION OF NEONATAL EARLY WARNING SCORE WITH MORTALITY NEWBORNS. *Critical Care Medicine*, *53*(1). https://doi.org/10.1097/01.ccm.0001101928.70470.3f

Polat, M., Şentürk, M. B., Pulatoğlu, Ç., Doğan, O., Kılıççı, Ç., & Budak, M. Ş. (2018). Postpartum urinary retention: Evaluation of risk factors. *Turkish Journal of Obstetrics and Gynecology*, *15*(2), 70–74. https://doi.org/10.4274/tjod.43931

Pramesti, L. D., Dewi, M., & Gayatri, M. (2022). *Literature Review: Pengaruh Relaktasi Suplementer Dikombinasikan Dengan Metode "SPEOS" (Stimulasi Pijat Endorfin, Oksitosin, Dan Sugestif) Terhadap Durasi Relaktasi Pada Ibu Menyusui*. *6*(2), 88–96. https://doi.org/10.21776/ub.JOIM.2022.006.02.3

Pujiastuti, N., & Winarni, S. (2025). Back Acupressure, Baby Positioning and Latching, and Breast Massage Increase Breast Milk Production: A Controlled Clinical Trial. *Acta Medica Philippina*, *59*(16), 93–99. https://doi.org/10.47895/amp.vi0.9130

Puspitasari, D., Rahayu, H. S. E., Wijayanti, K., & Rohmayanti. (2025). Effectiveness SPEOS Method (Endorphin, Oxytocin, and Suggestive Massage Stimulation) on Breast Milk Production in Postpartum Mothers: A Systematic Literature Review. *Gaster*, *23*(2), 211–225. https://doi.org/10.30787/gaster.v23i2.1578

R, H. N., C, E., F, C. S., & R, S. (2023). The Effect Of A Combination Of Speos (Endorphine Massage Stimulation, Oxytocin Massage And Suggestion) On The Success Of The Let Down Reflex And The Production Of The Mother's Milk Production Post Sectio Caesarea At Dr. Hospital. H. Slamet Martodirdjo Pam.

International Journal of Health and Pharmaceutical (IJHP), *3*(4), 980–988. https://doi.org/10.51601/ijhp.v3i4.313

Rhomadona, S. W., & Primihastuti, D. (2022). The Effect of Herbal Steam Bath to Increasing Breast Milk Production in Postpartum Mothers. *International Journal of Advanced Health Science and Technology*, *2*(6), 420–425. https://doi.org/10.35882/ijahst.v2i6.184

Romlah, R., Sari, A. P., & Anita, T. (2024). Simplications Documentation Format of the Midwifery Care SOAP. *Jurnal Ilmiah Kesehatan (JIKA)*, *6*(3), 407–415. https://doi.org/10.36590/jika.v6i3.903

Ruan, W., Zhang, B., Ma, J., & Ke, H. (2025). The Effect of Yoga on Women with Postpartum Depression: A Meta-analysis. *International Journal of Yoga*, *18*(2), 106. https://doi.org/10.4103/ijoy.ijoy_283_24

Selçuk, A. K., Yanikkerem, E., & Erdoğan, S. Ü. (2025). The factors affecting breastfeeding self-efficacy, LATCH scores and effect of postnatal breastfeeding education on mothers' self-efficacy. *Revista Da Escola de Enfermagem Da USP*, *59*, e20240281. https://doi.org/10.1590/1980-220X-REEUSP-2024-0281en

Setianingsih, F., Lestari, Y., Permatasari, G., & Agustikawati, N. (2024). Pemberian Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Adaptasi Psikologi Post Partum Sebagai Upaya Pencegahan Postpartum Blues Pada Ibu Nifas Di UPT Puskesmas Kec. Alas Barat. *Jurnal Kabar Masyarakat*, *2*(1), 128–133. https://doi.org/10.54066/jkb.v2i1.1578

Shofiyana, I. W., & Kustiyati, S. (2025). Pengaruh Terapi Akupresur Terhadap Kelancaran Produksi ASI Ibu Menyusui Bayi Baru Lahir. *IJMT : Indonesian Journal of Midwifery Today*, *5*(1), 42–48. https://doi.org/10.30587/ijmt.v5i1.10585

Song, J.-A., & Yang, H. (2022). Fatigue relief by aromatherapy use in prenatal and postnatal women: A systematic review and meta-analysis. *Korean Journal of Women Health Nursing*, *28*(2), 87–99. https://doi.org/10.4069/kjwhn.2022.05.15

Swami, T., Shams, A., Mittelstadt, M., Guenther, C., Tse, T., Noor, H., & Shahid, R. (2023). Implementation of early warning system in the clinical teaching unit to reduce unexpected deaths. *BMJ Open Quality*, *12*(2), e002194. https://doi.org/10.1136/bmjoq-2022-002194

Tonasih. (2023). *ASUHAN KEBIDANAN KOMPLEMENTER PADA MASA NIFAS* (1st ed.). Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta. (Original work published Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta)

Torabinia, M., Rosenblatt, S. D., & Mosadegh, B. (2021). A Review of Quantitative Instruments for Understanding Breastfeeding Dynamics. *Global Challenges*, *5*(10), 2100019. https://doi.org/10.1002/gch2.202100019

Ughul, A., & Sutarno, M. (2024). Karakteristik Kunjungan Ibu Nifas di RSUD Tanah Merah Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan. *Malahayati Nursing Journal*, *6*(5), 1797–1809. https://doi.org/10.33024/mnj.v6i5.11222

Varela, P., Nanou, C., Bouroutzoglou, M., Kyrkou, G., & Deltsidou, A. (2025). The Bristol Breastfeeding Assessment Tool (BBAT): A systematic review of the psychometric properties of the translated versions. *European Journal of Midwifery*, *9*, 10.18332/ejm/201343. https://doi.org/10.18332/ejm/201343

Victoria, S. I. V. S. I., & Yanti, J. S. Y. J. S. (2021a). ASUHAN KEBIDANAN PADA IBU NIFAS DENGAN PELAKSANAAN SENAM NIFAS. *Jurnal Kebidanan Terkini (Current Midwifery Journal)*, *1*(1), 45–55. https://doi.org/10.25311/jkt/Vol1.Iss1.313

Victoria, S. I. V. S. I., & Yanti, J. S. Y. J. S. (2021b). ASUHAN KEBIDANAN PADA IBU NIFAS DENGAN PELAKSANAAN SENAM NIFAS. *Jurnal Kebidanan Terkini (Current Midwifery Journal)*, *1*(1), 45–55. https://doi.org/10.25311/jkt/Vol1.Iss1.313

Wakhidah, A. Z., & Silalahi, M. (2020). Study Ethnomedicine Betimun: The Traditional Steam Bath Herb of Saibatin Sub-tribe, Lampung. *STRADA : Jurnal Ilmiah Kesehatan*, *9*(2), 1258–1267. https://doi.org/10.30994/sjik.v9i2.257

Westrepp, I. R. F., & Huesped, M. Á. (2025). Pathological puerperium: Challenges and complications of the postpartum period. *SAP Health and Policy*, *4*, 223–223. https://doi.org/10.56294/shp2025223

Widiantari, K., Dewianti, N. M., & Arsani, N. L. W. A. (2023). The Effect Application of the SPEOS Method (Endorphin, Oxytocin, Suggestive Massage Stimulation) with Essential Oil Aromatherapy on Breast Milk Production in Postpartum Mothers. *Babali Nursing Research*, *4*(4), 785–795. https://doi.org/10.37363/bnr.2023.44316

Wulandari, S., Yani, E. R., & Kundarti, F. I. (2024). Differences in Postpartum Depression and Breast Milk Production in Postpartum Mothers After Implementing Postnatal Yoga. *EMBRIO: Jurnal Kebidanan*, *16*(1), 71–78. https://doi.org/10.36456/embrio.v16i1.8171

Yamasaki, A., Sakamoto, N., Edamitsu, Y., Ishibashi, M., Kimura, F., & Igarashi, T. (2026). Effects of early postpartum massage on physical discomfort, mood, and emotional well-being: A randomized controlled trial. *European Journal of Midwifery*, *10*, 10.18332/ejm/216378. https://doi.org/10.18332/ejm/216378

BAB 5

KETERAMPILAN PELAYANAN KB: KONSELING, SKRINING KELAYAKAN, DAN TINDAK LANJUT EFEK SAMPING

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

- Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan mampu:
- CPL 1. Menguasai konsep teoritis kesehatan reproduksi, keluarga berencana, metode kontrasepsi, serta prinsip pelayanan kontrasepsi yang aman dan berkualitas.
- CPL 2. Mampu melakukan pengkajian kebutuhan dan kondisi kesehatan klien sebagai dasar dalam menentukan kelayakan penggunaan metode kontrasepsi.
- CPL 3. Mampu memberikan konseling KB dengan pendekatan berpusat pada klien serta menghormati hak, pilihan, privasi, dan otonomi reproduksi klien.
- CPL 4. Mampu menerapkan prinsip skrining kelayakan kontrasepsi berdasarkan kondisi kesehatan, karakteristik klien, serta pedoman berbasis bukti.
- CPL 5. Mampu memberikan pelayanan kontrasepsi dasar dan tindak lanjut sesuai standar pelayanan, kompetensi, serta kewenangan profesi bidan.
- CPL 6. Mampu mengenali dan melakukan penatalaksanaan awal terhadap keluhan atau efek samping penggunaan kontrasepsi serta menentukan kebutuhan kolaborasi dan rujukan.
- CPL 7. Mampu menerapkan komunikasi efektif, keselamatan pasien, pencegahan infeksi, dokumentasi, dan profesionalisme dalam pelayanan keluarga berencana.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

- Setelah mempelajari topik ini, mahasiswa diharapkan mampu:
- CPMK 1. Menjelaskan tujuan, prinsip, dan ruang lingkup pelayanan keluarga berencana.
- CPMK 2. Menjelaskan jenis dan karakteristik metode kontrasepsi yang digunakan dalam pelayanan KB.
- CPMK 3. Melakukan pengkajian kebutuhan reproduksi, riwayat kesehatan, riwayat obstetri, dan penggunaan kontrasepsi sebelumnya.
- CPMK 4. Melaksanakan konseling KB secara sistematis, komunikatif, dan berpusat pada kebutuhan klien.

- CPMK 5. Memberikan informasi mengenai efektivitas, keuntungan, keterbatasan, cara penggunaan, kemungkinan efek samping, dan kebutuhan tindak lanjut setiap metode.
- CPMK 6. Melakukan skrining untuk memastikan bahwa klien tidak sedang hamil sebelum memulai metode kontrasepsi yang memerlukan kepastian tersebut.
- CPMK 7. Menggunakan prinsip Medical Eligibility Criteria untuk menentukan kelayakan penggunaan metode kontrasepsi berdasarkan kondisi kesehatan klien.
- CPMK 8. Mengidentifikasi kondisi yang memerlukan pemeriksaan tambahan, konsultasi, pemilihan metode alternatif, atau rujukan sebelum kontrasepsi diberikan.
- CPMK 9. Mengenali efek samping yang umum terjadi pada penggunaan kontrasepsi hormonal, AKDR, dan implan.
- CPMK 10. Memberikan konseling dan tindakan awal terhadap efek samping sesuai kondisi klien dan kewenangan bidan.
- CPMK 11. Mengenali tanda bahaya yang membutuhkan evaluasi segera, kolaborasi, atau rujukan.
- CPMK 12. Melakukan KIE mengenai penggunaan metode, kunjungan ulang, perlindungan terhadap infeksi menular seksual, serta tanda yang membutuhkan pemeriksaan.
- CPMK 13. Mendokumentasikan hasil konseling, skrining, metode yang dipilih, tindakan, serta tindak lanjut pelayanan KB secara lengkap dan sistematis.

Pendahuluan

Pelayanan keluarga berencana (KB) merupakan bagian penting dari pelayanan kesehatan reproduksi yang bertujuan membantu perempuan, laki-laki, dan pasangan merencanakan kehamilan sesuai kebutuhan, kondisi kesehatan, serta tujuan reproduksinya. Pelayanan KB yang berkualitas tidak hanya berfokus pada pemberian alat atau obat kontrasepsi, tetapi mencakup pemberian informasi yang benar, penilaian kelayakan penggunaan metode, penghormatan terhadap pilihan klien, pelaksanaan tindakan sesuai kompetensi, serta tindak lanjut terhadap keluhan dan efek samping yang mungkin muncul.

Pemilihan metode kontrasepsi merupakan keputusan individual. Tidak terdapat satu metode yang paling sesuai bagi seluruh klien karena setiap metode memiliki karakteristik, manfaat, keterbatasan, efek samping, dan persyaratan penggunaan yang berbeda. Kondisi kesehatan, usia, riwayat obstetri, keinginan mempunyai anak kembali, pola menstruasi, kebutuhan perlindungan terhadap infeksi menular seksual, kenyamanan, serta preferensi klien perlu dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan.

Konseling menjadi salah satu keterampilan utama dalam pelayanan KB. Konseling yang baik tidak diarahkan untuk menentukan metode atas nama klien, tetapi membantu klien memahami pilihan yang tersedia dan membuat keputusan secara sadar berdasarkan informasi yang memadai. Prinsip pelayanan kontrasepsi modern menekankan pendekatan yang berpusat pada klien, penghormatan terhadap otonomi reproduksi, kerahasiaan, dan pengambilan keputusan tanpa paksaan. WHO dan CDC menekankan bahwa pelayanan kontrasepsi seharusnya mendukung pilihan yang diinformasikan dan menghindari hambatan medis yang tidak diperlukan.

Setelah konseling, tenaga kesehatan perlu melakukan skrining kelayakan untuk memastikan bahwa metode yang dipilih aman bagi kondisi klien. Penilaian tidak hanya bertujuan mencari kontraindikasi, tetapi juga menentukan apakah suatu metode dapat digunakan tanpa pembatasan, dapat digunakan dengan pertimbangan tertentu, atau sebaiknya tidak digunakan karena risiko kesehatan yang terlalu besar. WHO melalui Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use mengelompokkan kelayakan penggunaan metode kontrasepsi ke dalam empat kategori berdasarkan kondisi medis dan karakteristik fisiologis klien.

Pelayanan KB juga tidak berhenti setelah metode diberikan. Klien perlu memperoleh informasi mengenai perubahan yang mungkin terjadi setelah penggunaan kontrasepsi, cara menggunakan metode dengan benar, kapan harus kembali untuk mendapatkan pelayanan, serta tanda atau keluhan yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Efek samping yang tidak dijelaskan sebelumnya dapat menimbulkan kekhawatiran dan menyebabkan penghentian metode meskipun kondisi tersebut sebenarnya masih dapat ditangani.

Bidan memiliki peran penting dalam seluruh rangkaian pelayanan tersebut sesuai kompetensi dan kewenangannya. Mahasiswa kebidanan perlu memiliki kemampuan mengintegrasikan komunikasi, anamnesis, pemeriksaan, pengambilan keputusan klinis, keterampilan konseling, serta tindak lanjut dalam satu rangkaian pelayanan KB yang aman dan berpusat pada klien. Pedoman Pelayanan Kontrasepsi dan Keluarga Berencana Kementerian Kesehatan RI juga menempatkan metode kontrasepsi, prosedur klinis, dan pengelolaan pelayanan sebagai bagian penting dalam pelayanan KB.

Uraian Materi

A. Konsep Pelayanan KB dan Konseling Berpusat pada Klien

Pelayanan KB merupakan rangkaian pelayanan yang membantu klien menentukan dan menggunakan metode kontrasepsi sesuai kebutuhan reproduksinya. Pelayanan yang berkualitas tidak hanya mempertimbangkan efektivitas suatu metode dalam mencegah kehamilan, tetapi juga kesesuaian metode dengan kondisi kesehatan, kebutuhan, nilai, dan preferensi klien.

Konseling merupakan proses komunikasi dua arah antara tenaga kesehatan dan klien. Melalui konseling, tenaga kesehatan membantu klien memahami kebutuhan reproduksinya, mengenali pilihan kontrasepsi yang tersedia, serta mempertimbangkan manfaat dan keterbatasan masing-masing metode. Klien perlu diberikan kesempatan untuk bertanya, menyampaikan kekhawatiran, dan menentukan metode yang dianggap paling sesuai tanpa tekanan dari tenaga kesehatan maupun pihak lain.

Informasi yang diberikan dalam konseling perlu mencakup cara kerja metode, efektivitas, cara penggunaan, lama perlindungan, kemungkinan kembalinya kesuburan setelah penghentian, efek samping yang umum, risiko tertentu, serta kapan klien perlu kembali ke fasilitas kesehatan. Informasi diberikan secara seimbang dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami.

Konseling juga perlu menekankan bahwa sebagian besar metode kontrasepsi tidak memberikan perlindungan terhadap infeksi menular seksual. Kondom memiliki peran penting dalam mengurangi risiko penularan IMS termasuk HIV apabila digunakan secara benar dan konsisten.

Pada akhir konseling, keputusan pemilihan metode tetap berada pada klien setelah memperoleh informasi yang memadai. Tenaga kesehatan berperan memastikan bahwa keputusan tersebut diinformasikan, sukarela, serta aman berdasarkan hasil skrining kondisi kesehatan.

B. Pengkajian dan Skrining Kelayakan Metode Kontrasepsi

Skrining merupakan tahapan penting sebelum suatu metode kontrasepsi diberikan. Tujuannya adalah memperoleh informasi yang cukup untuk menentukan apakah metode yang dipilih aman digunakan oleh klien. Skrining dilakukan secara sistematis melalui anamnesis, pemeriksaan yang relevan, dan penilaian berdasarkan kriteria kelayakan medis.

Anamnesis dapat mencakup usia, pola menstruasi, riwayat kehamilan dan persalinan, status menyusui, kemungkinan kehamilan, penggunaan kontrasepsi sebelumnya, penyakit yang sedang atau pernah dialami, penggunaan obat tertentu,

kebiasaan merokok, riwayat hipertensi, penyakit kardiovaskular, migrain, diabetes, gangguan hati, kanker tertentu, serta riwayat tromboemboli sesuai metode yang dipertimbangkan.

Kemungkinan kehamilan perlu dinilai sebelum memulai metode tertentu. Penolong dapat menggunakan riwayat menstruasi, aktivitas seksual, penggunaan kontrasepsi sebelumnya, kondisi postpartum atau pascaaborsi, serta pemeriksaan kehamilan apabila diperlukan. Tidak semua klien membutuhkan pemeriksaan laboratorium yang luas sebelum menggunakan kontrasepsi; pemeriksaan dilakukan sesuai metode yang dipilih dan kondisi klinis.

Salah satu kerangka yang digunakan secara internasional adalah Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use (MEC) WHO. Edisi keenam yang diterbitkan pada 2025 memuat lebih dari 2.000 rekomendasi untuk 25 metode KB serta menggunakan empat kategori kelayakan.

1. Kategori 1 menunjukkan bahwa tidak terdapat pembatasan penggunaan metode kontrasepsi tersebut.
2. Kategori 2 menunjukkan bahwa keuntungan penggunaan metode secara umum lebih besar dibandingkan risiko teoritis atau risiko yang telah diketahui.
3. Kategori 3 menunjukkan bahwa risiko teoritis atau risiko yang telah diketahui secara umum lebih besar dibandingkan keuntungan penggunaan metode sehingga metode biasanya tidak menjadi pilihan utama dan membutuhkan pertimbangan klinis lebih lanjut.
4. Kategori 4 menunjukkan adanya risiko kesehatan yang tidak dapat diterima apabila metode tersebut digunakan sehingga metode tidak digunakan pada kondisi tersebut.

Kategori MEC tidak menggantikan penilaian klinis. Kondisi kesehatan klien, ketersediaan metode alternatif, preferensi, serta kemampuan fasilitas tetap perlu dipertimbangkan. WHO menempatkan MEC sebagai pedoman untuk membantu tenaga kesehatan menentukan keamanan berbagai metode berdasarkan kondisi medis dan karakteristik fisiologis klien.

C. Pemilihan Metode dan Pengambilan Keputusan Bersama

Setelah proses skrining, tenaga kesehatan perlu mendiskusikan metode yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan klien. Pemilihan tidak hanya didasarkan pada apakah metode secara medis dapat digunakan, tetapi juga bagaimana karakteristik metode tersebut sesuai dengan tujuan reproduksi klien.

Beberapa klien membutuhkan metode untuk menunda kehamilan dalam waktu singkat, sedangkan klien lain membutuhkan perlindungan jangka panjang atau sudah tidak menginginkan kehamilan berikutnya. Kebutuhan tersebut dapat

memengaruhi pilihan antara metode jangka pendek, metode kontrasepsi jangka panjang, atau metode permanen.

Pilihan juga perlu mempertimbangkan kemampuan klien menggunakan metode secara konsisten. Pil dan kondom sangat dipengaruhi kepatuhan pengguna, sedangkan implan dan AKDR tidak memerlukan tindakan harian setelah dipasang. Metode suntik memerlukan pemberian ulang sesuai jadwal, sementara metode permanen diperuntukkan bagi klien yang telah membuat keputusan mantap untuk tidak menginginkan kehamilan di masa mendatang.

Tenaga kesehatan perlu menjelaskan bahwa efektivitas bukan satu-satunya pertimbangan. Perubahan pola menstruasi, kenyamanan penggunaan, keteraturan kunjungan, keinginan mempertahankan menstruasi bulanan, kebutuhan privasi, dan rencana kehamilan selanjutnya dapat memengaruhi penerimaan terhadap suatu metode.

Setelah klien menentukan pilihan, tenaga kesehatan memastikan kembali kelayakan medis, menjelaskan cara penggunaan, kemungkinan efek samping, serta kebutuhan tindak lanjut. Apabila metode yang diinginkan tidak sesuai dengan kondisi kesehatan, tenaga kesehatan perlu menjelaskan alasan medis secara jelas dan mendiskusikan alternatif yang lebih aman tanpa mengambil alih keputusan klien.

D. Efek Samping Kontrasepsi dan Penatalaksanaan Awal

Efek samping merupakan salah satu alasan klien datang kembali atau menghentikan penggunaan metode kontrasepsi. Oleh karena itu, konseling mengenai kemungkinan efek samping sebaiknya dilakukan sebelum metode dimulai. Klien yang telah mengetahui perubahan yang mungkin dialami cenderung lebih siap menghadapi kondisi tersebut dan mengetahui kapan harus mencari pertolongan.

Kontrasepsi hormonal dapat menyebabkan perubahan pola perdarahan menstruasi, seperti perdarahan tidak teratur, bercak, menstruasi yang lebih sedikit, atau amenore. Pada sebagian klien dapat terjadi sakit kepala, mual, nyeri payudara, atau keluhan lain yang waktunya berkaitan dengan penggunaan metode. Jenis dan pola efek samping berbeda sesuai metode dan respons masing-masing individu.

Penggunaan implan juga sering berhubungan dengan perubahan pola perdarahan. Perubahan tersebut perlu dijelaskan sebagai salah satu kondisi yang dapat terjadi selama penggunaan. Apabila perdarahan sangat banyak, berkepanjangan, muncul setelah pola sebelumnya stabil, atau disertai keluhan lain, penyebab lain perlu dipertimbangkan dan klien memerlukan evaluasi.

Pada pengguna AKDR tembaga, menstruasi dapat menjadi lebih banyak atau lebih lama terutama pada bulan-bulan awal, sedangkan pengguna AKDR yang melepaskan levonorgestrel dapat mengalami bercak atau perdarahan tidak teratur pada awal penggunaan dan selanjutnya menstruasi dapat berkurang atau berhenti. Perubahan pola menstruasi perlu dibedakan dari perdarahan abnormal yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut.

Penatalaksanaan efek samping dimulai dengan melakukan anamnesis dan penilaian klinis. Bidan perlu menentukan apakah keluhan merupakan efek yang dapat terjadi akibat metode, tanda kehamilan, infeksi, masalah ginekologis lain, atau kondisi yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Keinginan klien juga perlu diperhatikan; klien dapat memilih tetap menggunakan metode, mengganti metode, atau menghentikannya setelah mendapatkan informasi yang cukup.

Keluhan yang mengarah pada kondisi serius—misalnya perdarahan sangat banyak disertai tanda gangguan hemodinamik, nyeri panggul berat atau demam, kecurigaan kehamilan, gangguan neurologis akut, sesak napas atau nyeri dada, serta tanda lain yang mengarah pada komplikasi—memerlukan evaluasi segera dan kolaborasi atau rujukan sesuai kondisi.

Dengan demikian, tindak lanjut efek samping tidak boleh hanya berfokus pada mempertahankan penggunaan kontrasepsi. Prioritasnya adalah memastikan keselamatan klien sekaligus membantu klien menentukan apakah metode tersebut masih dapat diterima dan sesuai dengan kebutuhannya.

E. Tindak Lanjut, KIE, Dokumentasi, dan Rujukan

Setelah kontrasepsi diberikan, klien perlu memperoleh informasi mengenai penggunaan metode secara benar serta kebutuhan tindak lanjut. Jadwal kunjungan berbeda sesuai jenis metode. Metode yang memerlukan pemberian ulang harus mengikuti jadwal yang ditentukan, sedangkan pengguna metode jangka panjang perlu mengetahui kapan harus kembali untuk evaluasi, penggantian, atau pelepasan.

Klien juga perlu diberi tahu bahwa kunjungan tidak harus menunggu jadwal yang telah ditentukan apabila terdapat masalah. Klien dapat kembali apabila mengalami efek samping yang mengganggu, terdapat tanda bahaya, mencurigai kehamilan, mengalami masalah penggunaan metode, ingin mengganti metode, atau sekadar membutuhkan informasi tambahan.

Pada kunjungan tindak lanjut, tenaga kesehatan dapat mengevaluasi kepuasan terhadap metode, kepatuhan penggunaan, perubahan kondisi kesehatan, efek samping yang dialami, penggunaan obat lain, serta perubahan tujuan reproduksi. Penilaian tersebut membantu menentukan apakah metode dapat dilanjutkan atau perlu dimodifikasi.

KIE harus diberikan dengan bahasa yang sederhana dan spesifik. Klien perlu memahami cara menggunakan kontrasepsi, tindakan apabila lupa atau terlambat menggunakan metode sesuai jenisnya, efek samping yang dapat terjadi, tanda yang membutuhkan pemeriksaan, serta kapan metode perlu diganti atau dihentikan. Informasi mengenai pencegahan IMS dan penggunaan kondom juga diberikan sesuai kebutuhan.

Dokumentasi pelayanan KB dilakukan secara lengkap dan sistematis. Catatan setidaknya memuat hasil pengkajian, riwayat kesehatan yang relevan, hasil pemeriksaan, hasil skrining kelayakan, informasi dan konseling yang diberikan, keputusan klien, metode yang dipilih, tindakan atau obat yang diberikan, serta rencana tindak lanjut.

Bidan perlu mengenali batas kewenangan dalam pelayanan KB. Apabila ditemukan kondisi yang membutuhkan pemeriksaan atau penanganan di luar kompetensi, klien perlu dikonsultasikan atau dirujuk. Pelayanan tetap diarahkan untuk menjaga kesinambungan asuhan sehingga informasi mengenai kondisi, metode yang digunakan, keluhan, dan tindakan sebelumnya dapat diterima secara jelas oleh tenaga kesehatan atau fasilitas tujuan.

Keterampilan pelayanan KB pada akhirnya merupakan integrasi antara konseling, pengkajian, skrining kelayakan, pengambilan keputusan bersama, pemberian metode, pemantauan efek samping, KIE, dokumentasi, dan rujukan. Mahasiswa kebidanan perlu memahami bahwa kualitas pelayanan tidak hanya diukur dari keberhasilan memberikan kontrasepsi, tetapi juga dari kemampuan membantu klien menggunakan metode secara aman, nyaman, sadar, dan sesuai dengan tujuan reproduksinya.

F. Latihan Soal

1. Seorang perempuan berusia 27 tahun, P1A0, datang ke puskesmas untuk mendapatkan kontrasepsi. Ia ingin menunda kehamilan selama 3 tahun tetapi masih bingung memilih antara suntik dan implan. Suaminya menyarankan suntik, sedangkan pasien tertarik menggunakan implan karena tidak ingin sering datang ke fasilitas kesehatan. Tidak ditemukan keluhan atau masalah kesehatan saat anamnesis awal.

   Apakah tindakan bidan yang paling tepat pada kasus tersebut?

   A. Menentukan metode suntik karena sesuai dengan keinginan suami
   B. Menyarankan implan karena lebih efektif dibandingkan suntik
   C. Menjelaskan pilihan metode secara seimbang dan memberi kesempatan klien menentukan pilihannya
   D. Meminta klien berdiskusi kembali dengan suami sebelum memilih metode

E. Menunda pelayanan sampai klien menyetujui metode yang direkomendasikan bidan

Kunci jawaban: C. Menjelaskan pilihan metode secara seimbang dan memberi kesempatan klien menentukan pilihannya

Rasional: Konseling KB merupakan komunikasi dua arah yang membantu klien memahami pilihan kontrasepsi, manfaat, keterbatasan, cara penggunaan, dan efek sampingnya. Keputusan akhir tetap berada pada klien setelah memperoleh informasi yang memadai dan tanpa tekanan dari tenaga kesehatan maupun pihak lain.

- A tidak tepat: Pilihan kontrasepsi tidak ditentukan berdasarkan keinginan pasangan.
- B tidak tepat: Bidan dapat menjelaskan efektivitas implan, tetapi tidak mengambil alih keputusan klien.
- C tepat: Sesuai prinsip konseling berpusat pada klien dan informed choice.
- D tidak tepat: Keterlibatan pasangan dapat didukung bila diinginkan klien, tetapi bukan syarat untuk mengambil keputusan.
- E tidak tepat: Bidan tidak boleh memaksakan metode tertentu kepada klien.

2. Seorang perempuan berusia 38 tahun, P3A0, datang untuk menggunakan kontrasepsi hormonal. Ia mengatakan merokok setiap hari dan memiliki riwayat hipertensi. Pasien juga pernah mengalami migrain dan saat ini menggunakan obat antihipertensi. Ia meminta pil kontrasepsi karena sebelumnya pernah menggunakan metode tersebut. Bidan akan menentukan keamanan metode berdasarkan kondisi kesehatan pasien.

   Apakah tindakan yang paling tepat dilakukan bidan?

   A. Memberikan pil sesuai keinginan pasien tanpa pemeriksaan lebih lanjut
   B. Menolak seluruh metode kontrasepsi hormonal
   C. Melakukan skrining kelayakan medis sebelum menentukan metode
   D. Menyarankan kontrasepsi permanen karena pasien telah memiliki tiga anak
   E. Memberikan kontrasepsi terlebih dahulu kemudian melakukan skrining pada kunjungan berikutnya

   Kunci jawaban: C. Melakukan skrining kelayakan medis sebelum menentukan metode

   Rasional: Sebelum kontrasepsi diberikan, perlu dilakukan skrining melalui anamnesis dan pemeriksaan yang relevan. Usia, kebiasaan merokok, hipertensi, migrain, penyakit kardiovaskular, riwayat tromboemboli, dan penggunaan obat merupakan faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan kelayakan metode.

- A tidak tepat: Kondisi kesehatan pasien dapat memengaruhi keamanan metode tertentu.
- B tidak tepat: Tidak semua kontrasepsi hormonal otomatis tidak boleh digunakan; kelayakan bergantung pada jenis metode dan kondisi klinis.
- C tepat: Skrining harus dilakukan sebelum keputusan metode ditetapkan.
- D tidak tepat: Jumlah anak bukan alasan untuk mengarahkan klien secara sepihak ke metode permanen.
- E tidak tepat: Skrining dilakukan sebelum metode diberikan.

3. Seorang perempuan berusia 30 tahun, P2A0, datang ke klinik untuk memilih kontrasepsi. Ia belum ingin hamil dalam waktu 5 tahun dan mengatakan sering lupa minum obat. Pekerjaannya membuatnya sulit datang ke fasilitas kesehatan secara berkala. Hasil pengkajian tidak menunjukkan kondisi kesehatan yang membatasi penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang.
   Apakah metode yang paling sesuai untuk didiskusikan dengan klien?
   A. Pil kontrasepsi harian
   B. Kondom saja
   C. Implan atau AKDR
   D. Metode kalender
   E. Suntik dengan jadwal berulang
   Kunci jawaban: C. Implan atau AKDR
   Rasional: Pemilihan metode perlu mempertimbangkan tujuan reproduksi dan kemampuan klien menggunakan metode secara konsisten. Implan dan AKDR memberikan perlindungan jangka panjang serta tidak memerlukan tindakan harian setelah pemasangan, sehingga relevan untuk didiskusikan dengan klien yang ingin menunda kehamilan beberapa tahun dan sering lupa menggunakan metode harian.
   - A tidak tepat: Pil membutuhkan kepatuhan penggunaan setiap hari.
   - B tidak tepat: Kondom dapat menjadi pilihan, tetapi keberhasilannya sangat dipengaruhi penggunaan yang benar dan konsisten setiap hubungan seksual.
   - C tepat: Sesuai dengan kebutuhan perlindungan jangka panjang dan pola hidup klien.
   - D tidak tepat: Metode ini membutuhkan pengamatan dan kepatuhan yang konsisten.
   - E tidak tepat: Suntik tetap membutuhkan kunjungan berulang sesuai jadwal.

4. Seorang perempuan berusia 26 tahun, P1A0, menggunakan implan sejak 4 bulan yang lalu. Ia datang ke puskesmas karena sering mengalami bercak darah tidak teratur. Tidak terdapat nyeri perut, demam, perdarahan banyak, atau keluhan lain. Pemeriksaan umum menunjukkan kondisi stabil. Pasien khawatir karena menganggap implan tidak cocok dan ingin mengetahui apakah harus dilepas.
   Apakah tindakan bidan yang paling tepat?
   A. Segera melepas implan tanpa melakukan konseling
   B. Menjelaskan bahwa perubahan pola perdarahan dapat terjadi dan melakukan penilaian klinis
   C. Mengatakan bahwa bercak menunjukkan kegagalan kontrasepsi
   D. Memberikan antibiotik untuk mencegah infeksi
   E. Merujuk semua pengguna implan dengan bercak ke rumah sakit

   Kunci jawaban: B. Menjelaskan bahwa perubahan pola perdarahan dapat terjadi dan melakukan penilaian klinis

   Rasional: Penggunaan implan sering berkaitan dengan perubahan pola perdarahan. Penatalaksanaan dimulai dengan anamnesis dan penilaian klinis untuk memastikan bahwa keluhan merupakan efek metode dan bukan kehamilan, infeksi, atau masalah ginekologis lainnya. Keinginan klien untuk melanjutkan, mengganti, atau menghentikan metode tetap perlu dihormati setelah memperoleh informasi yang cukup.
   - A tidak tepat: Pelepasan tidak harus dilakukan segera bila tidak ada indikasi dan klien belum mengambil keputusan setelah konseling.
   - B tepat: Sesuai prinsip evaluasi efek samping dan konseling.
   - C tidak tepat: Bercak tidak otomatis menunjukkan kegagalan kontrasepsi.
   - D tidak tepat: Tidak terdapat tanda infeksi.
   - E tidak tepat: Rujukan tidak diperlukan pada semua kasus bercak tanpa tanda bahaya.

5. Seorang perempuan berusia 34 tahun, P2A0, menggunakan AKDR sejak 6 bulan yang lalu. Ia datang ke TPMB dengan keluhan nyeri panggul berat sejak kemarin disertai demam. Pasien juga mengeluh perdarahan yang lebih banyak dari biasanya dan merasa lemas. Hasil pemeriksaan menunjukkan suhu 38,5°C dan tekanan darah 95/60 mmHg.
   Apakah tindakan yang paling tepat dilakukan bidan?
   A. Menjelaskan bahwa kondisi tersebut merupakan efek samping normal AKDR
   B. Menyarankan pasien kembali setelah menstruasi selesai
   C. Melakukan evaluasi segera dan kolaborasi atau rujukan sesuai kondisi
   D. Memberikan KIE dan meminta pasien memantau keluhan di rumah

E. Mengganti AKDR dengan kontrasepsi hormonal pada kunjungan tersebut

Kunci jawaban: C. Melakukan evaluasi segera dan kolaborasi atau rujukan sesuai kondisi

Rasional: Nyeri panggul berat, demam, perdarahan banyak, dan tanda gangguan kondisi umum merupakan keluhan yang dapat mengarah pada komplikasi dan membutuhkan evaluasi segera. Materi menegaskan bahwa perdarahan sangat banyak, nyeri panggul berat atau demam, kecurigaan kehamilan, gangguan neurologis akut, sesak napas, atau nyeri dada merupakan keadaan yang membutuhkan evaluasi, kolaborasi, atau rujukan.

- A tidak tepat: Nyeri panggul berat disertai demam bukan efek samping yang boleh dianggap normal.
- B tidak tepat: Penundaan pemeriksaan dapat membahayakan klien.
- C tepat: Kondisi pasien membutuhkan evaluasi dan penanganan segera.
- D tidak tepat: Terdapat tanda bahaya sehingga tidak cukup hanya diberikan KIE.
- E tidak tepat: Prioritas utama adalah menilai dan menangani kondisi klinis, bukan langsung mengganti metode.

G. Ringkasan

Pelayanan keluarga berencana merupakan pelayanan kesehatan reproduksi yang tidak hanya berfokus pada pemberian metode kontrasepsi, tetapi juga mencakup konseling, pengkajian kondisi kesehatan, skrining kelayakan, pemilihan metode, pemantauan efek samping, serta tindak lanjut. Pelayanan yang berkualitas perlu menempatkan klien sebagai pusat pengambilan keputusan dengan tetap memperhatikan keamanan, kebutuhan reproduksi, kondisi kesehatan, nilai, dan preferensi masing-masing individu.

Konseling menjadi dasar penting dalam membantu klien memahami berbagai pilihan kontrasepsi beserta cara kerja, efektivitas, keuntungan, keterbatasan, efek samping, dan kebutuhan tindak lanjut. Keputusan penggunaan metode tetap berada pada klien setelah mendapatkan informasi yang memadai dan tanpa tekanan. Setelah klien menentukan pilihan, tenaga kesehatan perlu melakukan skrining kelayakan untuk memastikan metode tersebut aman berdasarkan riwayat kesehatan, kondisi klinis, kemungkinan kehamilan, dan kriteria kelayakan medis. Medical Eligibility Criteria (MEC) dapat digunakan sebagai pedoman untuk membantu menentukan keamanan suatu metode, tetapi tetap harus disertai penilaian klinis individual.

Pemilihan metode kontrasepsi perlu mempertimbangkan tujuan reproduksi, lama perlindungan yang diinginkan, kemampuan menggunakan metode secara

konsisten, kenyamanan, kemungkinan perubahan pola menstruasi, serta rencana kehamilan berikutnya. Tidak terdapat satu metode yang paling sesuai bagi seluruh klien. Oleh karena itu, pengambilan keputusan bersama antara tenaga kesehatan dan klien menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa kontrasepsi yang digunakan aman sekaligus dapat diterima oleh klien.

Efek samping kontrasepsi perlu dikenali dan ditangani melalui anamnesis serta penilaian klinis yang tepat. Perubahan pola perdarahan, amenore, bercak, sakit kepala, atau keluhan lain dapat berkaitan dengan penggunaan kontrasepsi, tetapi tenaga kesehatan tetap perlu mempertimbangkan kemungkinan kehamilan, infeksi, atau kondisi patologis lainnya. Adanya perdarahan berat, nyeri panggul berat, demam, gangguan hemodinamik, nyeri dada, sesak napas, atau tanda bahaya lain memerlukan evaluasi segera serta kolaborasi atau rujukan sesuai kondisi.

Tindak lanjut, KIE, dan dokumentasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelayanan KB. Klien perlu memahami cara menggunakan metode, jadwal kunjungan, efek samping yang mungkin terjadi, tanda bahaya, serta kondisi yang mengharuskan kembali ke fasilitas kesehatan. Dokumentasi yang lengkap mendukung kesinambungan pelayanan dan keselamatan klien. Dengan demikian, keterampilan pelayanan KB membutuhkan integrasi kemampuan komunikasi, pengkajian, pengambilan keputusan klinis, konseling, pemantauan, serta kemampuan mengenali batas kewenangan untuk memberikan pelayanan kontrasepsi yang aman, efektif, berpusat pada klien, dan berbasis bukti.

H. Daftar Pustaka

Curtis, K. M., Nguyen, A. T., Tepper, N. K., Zapata, L. B., Snyder, E. M., Hatfield-Timajchy, K., Kortsmit, K., Cohen, M. A., & Whiteman, M. K. (2024). U.S. selected practice recommendations for contraceptive use, 2024. MMWR Recommendations and Reports, 73(3), 1–77.

Nguyen, A. T., Curtis, K. M., Tepper, N. K., Kortsmit, K., Brittain, A. W., Snyder, E. M., Cohen, M. A., Zapata, L. B., & Whiteman, M. K. (2024). U.S. medical eligibility criteria for contraceptive use, 2024. MMWR Recommendations and Reports, 73(4), 1–126.

World Health Organization, & Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health/Center for Communication Programs. (2022). Family planning: A global handbook for providers (4th ed.).

World Health Organization. (2025a). Medical eligibility criteria for contraceptive use (6th ed.).

World Health Organization. (2025b). Selected practice recommendations for contraceptive use (4th ed.).

PROFIL PENULIS



Dyah Ayu Septika Wijaya, S.Tr. Keb., M.Keb lahir di Malang pada September 1993. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi S1 Kebidanan, Institut Teknologi Sains dan Kesehatan RS dr. Soepraoen Malang. Penulis menyelesaikan pendidikan terakhirnya pada Program Magister Kebidanan di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang. Sesuai dengan pendidikan yang ditempuh, saat ini penulis menekuni bidang Kebidanan salah satunya asuhan Kebidanan. Sebelum menjalani karir sebagai dosen, penulis adalah seorang praktisi kebidanan di Rumah Sakit Petrokimia Gresik. Penulis aktif sebagai editor Asian Journal of Fertility, Endocrinology, and Reproductive, pengurus Organisasi Ilmiah Malang Reproductive Training Center, dan Host podcast Kesehatan Perempuan.



Nama Septika Yani Veronica,S.ST.,Bdn.,M.Tr.Keb Lahir di wonokarto, 14 September 1989. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi DIV kebidanan, di STiKes Aisyah Pringsewu Lampung tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 di Poltekkes Kemenkes Semarang dan lulus tahun pada tahun 2018. Melanjutkan profesi kebidanan di universitas aisyah pringsewu pada tahun 2022, Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2011 setelah lulus pendidikan DIII saya bekerja di STIkes aisyah pringsewu hingga sampai Saat ini penulis bekerja sebagai dosen di Universitas aisyah pringsewu. Mendapatkan amanah tugas tambahan sebagai wakil dekan kemahasiswaan Universitas aisyah pringsewu. mengampu mata kuliah asuhan kebidanan komplèmenter kehamilan, dokumentasi kebidanan, ilmu kesehatan anak dan manajemen organisasi, askeb gadar maternal. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, pengabmas dan mendapat hibah PDP penelitian dari kemenristekdikti tahun 2024, Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: uapvero@gmail.com

Motto: "Living your life" baik buruknya situasimu jangan pernah meninggalkan sholat dan selalu bersyukur, nikmati keadaan kita saat ini.

PROFIL PENULIS



Hanik Khairun Nisa, S.Tr.Keb.,Bdn., M.Keb Lahir pada 19 Februari 1997 di Oku Timur, Sumatera Selatan. Riwayat Pendidikan Diploma III Kebidanan Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta (2018), DIV Kebidanan Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta (2019), S2 Magister Kebidanan Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta (2021) Serta Menyelesaikan Pendidikan Profesi Bidan Sekolah Tinggi Abdi Nusantara (2025). Riwayat pekerjaan Sejak tahun 2021 penulis mulai aktif mengajar sebagai Dosen tetap di Program Studi Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan Di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada Palembang. Selain itu Penulis juga aktif dalam penerbitan buku serta jurnal nasional dan internasional lainnya.
Penulis dapat dihubungi melalui email : khairunnisa19021997@gmail.com



Siska Rosdiana, S.ST.,M.Keb Lahir di Ciamis, 28 Mei 1985. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D-III Kebidanan Politeknik Kesehatan Bandung 2006, jenjang DIV pada Program Studi DIV Kebidanan Fakultas Kedokteran, Universitas Padjadjaran tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Kebidanan pada Universitas Padjadjaran dan lulus pada tahun 2019. Saat ini penulis bekerja sebagai Dosen Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan dan Program Studi Pendidikan Profesi Bidan di Politeknik Kesehatan Bhakti Pertiwi Husada Cirebon, mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan pada Pranikah dan Prakonsepsi, Asuhan Kebidanan pada Kehamilan, serta Asuhan Kebidanan pada Persalinan dan Bayi Baru Lahir. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar**.** Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: chikabie16@gmailcom.
Motto: "Setiap hari adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh"

PROFIL PENULIS



Titi Purwitasari Handayani, SST.,Bdn., M.Keb lahir di Bogor tanggal 29 Juni 1986. Penulis adalah dosen tetap Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Institut Kesehatan Karsa Husada Garut. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D-III Kebidanan Politeknik Kesehatan Bandung 2007, jenjang DIV pada Program Studi DIV Kebidanan Fakultas Kedokteran, Universitas Padjadjaran tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Kebidanan pada Universitas Padjadjaran dan lulus pada tahun 2019. Penulis sebagai pengurus aktif dari organisasi profesi IBI ranting Pendidikaan cabang kabupaten Garut. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar**.** Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: titipurwitasarih30@gmail.com

Sinopsis

Buku Ajar Keterampilan Klinis Kebidanan: Pemeriksaan, Tindakan Dasar, Dan Kie disusun sebagai sumber pembelajaran bagi mahasiswa kebidanan untuk memahami dan menguasai keterampilan klinis dasar dalam pelayanan kebidanan. Buku ini mengintegrasikan pemeriksaan, tindakan dasar, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) dalam satu rangkaian pembelajaran yang sistematis dan aplikatif.

Pembahasan mencakup berbagai keterampilan dalam pelayanan kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, kesehatan reproduksi, serta keluarga berencana. Setiap materi menekankan keselamatan pasien, komunikasi efektif, pencegahan komplikasi, penghormatan terhadap hak perempuan, dan penerapan praktik berbasis bukti.

Melalui buku ini, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan penalaran klinis, mengenali kondisi yang memerlukan tindakan, kolaborasi, atau rujukan, serta meningkatkan kesiapan dalam praktikum dan praktik klinik. Buku ini dapat digunakan sebagai referensi pembelajaran teori, laboratorium, simulasi, maupun praktik lapangan.

Buku Ajar Keterampilan Klinis Kebidanan: Pemeriksaan, Tindakan Dasar, Dan Kie disusun sebagai sumber pembelajaran bagi mahasiswa kebidanan untuk memahami dan menguasai keterampilan klinis dasar dalam pelayanan kebidanan. Buku ini mengintegrasikan pemeriksaan, tindakan dasar, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) dalam satu rangkaian pembelajaran yang sistematis dan aplikatif.

Pembahasan mencakup berbagai keterampilan dalam pelayanan kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, kesehatan reproduksi, serta keluarga berencana. Setiap materi menekankan keselamatan pasien, komunikasi efektif, pencegahan komplikasi, penghormatan terhadap hak perempuan, dan penerapan praktik berbasis bukti.

Melalui buku ini, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan penalaran klinis, mengenali kondisi yang memerlukan tindakan, kolaborasi, atau rujukan, serta meningkatkan kesiapan dalam praktikum dan praktik klinik. Buku ini dapat digunakan sebagai referensi pembelajaran teori, laboratorium, simulasi, maupun praktik lapangan.



Penerbit:
PT OPTIMAL UNTUK NEGERI
Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005
Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7927-97-2 (PDF)
9 786347 927972